Optimal Untuk Negeri

Optimal

Buku Ajar

KOMPLIKASI NIFAS

Perdarahan, Infeksi, Gangguan Laktasi, dan Kesehatan Mental Ibu

Marleni • Fitriana Yuni Permana Sari • Teresia Hemelka
Helena Fransysca • Leni Suhartini

Editor : Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.



Buku Ajar :

Komplikasi Nifas: Perdarahan, Infeksi, Gangguan Laktasi, dan Kesehatan Mental Ibu

Penulis:
Marleni, S.ST., Bdn., M.Tr.Keb.
Bdn. Fitriana Yuni Permana Sari, S.Tr.Keb., M.Keb.
Bd. Teresia Hemelka, S.Tr.Keb., M.Keb.
Bdn. Helena Fransysca,SST, M.Kes.
Bdn. Leni Suhartini, S.ST.M.Kes.

Editor :
Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.

Optimal
Untuk
Negeri

Buku Ajar:

Komplikasi Nifas: Perdarahan, Infeksi, Gangguan Laktasi, dan Kesehatan Mental Ibu

Penulis:
Marleni, S.ST., Bdn., M.Tr.Keb.
Bdn. Fitriana Yuni Permana Sari, S.Tr.Keb., M.Keb.
Bd. Teresia Hemelka, S.Tr.Keb., M.Keb.
Bdn. Helena Fransysca,SST, M.Kes.
Bdn. Leni Suhartini, S.ST.M.Kes.

Editor : Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-77-0

Cetakan Pertama: Agustus, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar berjudul Komplikasi Nifas: Perdarahan, Infeksi, Gangguan Laktasi, dan Kesehatan Mental Ibu dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ajar ini disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, serta pembaca yang membutuhkan pemahaman dasar dan aplikatif mengenai komplikasi yang dapat terjadi pada masa nifas.

Masa nifas merupakan periode penting dalam keberlanjutan kesehatan ibu setelah persalinan. Pada masa ini, ibu mengalami proses pemulihan fisik, adaptasi psikologis, serta penyesuaian terhadap peran baru dalam merawat bayi. Namun, masa nifas juga memiliki risiko terjadinya berbagai komplikasi, seperti perdarahan postpartum, retensio plasenta, sisa plasenta, laserasi jalan lahir, hematoma, infeksi nifas, gangguan eliminasi, serta komplikasi lain yang dapat memengaruhi keselamatan dan kualitas hidup ibu. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam mengenali tanda bahaya, melakukan penatalaksanaan awal, serta menentukan kebutuhan rujukan secara tepat.

Buku ajar ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami konsep dan penerapan asuhan pada komplikasi masa nifas. Bab pertama membahas konsep dasar komplikasi masa nifas, meliputi fisiologi nifas, faktor risiko, dan keselamatan ibu. Bab kedua menguraikan perdarahan postpartum, termasuk klasifikasi, penyebab berdasarkan konsep 4T, serta tindakan awal yang dapat dilakukan di pelayanan primer. Bab ketiga membahas retensio plasenta dan sisa plasenta, mulai dari tanda klinis, penanganan awal, hingga prosedur rujukan. Bab keempat menguraikan laserasi jalan lahir dan hematoma, termasuk identifikasi masalah, penatalaksanaan awal, serta indikasi rujukan. Bab kelima membahas infeksi masa nifas, seperti endometritis, infeksi luka, dan upaya pencegahan penyebaran infeksi. Bab keenam membahas gangguan eliminasi dan komplikasi lain, seperti retensi urine, konstipasi, dan hemoroid.

Penyusunan buku ajar ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi secara bertahap, menghubungkan teori dengan praktik pelayanan, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi kasus komplikasi nifas. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi dosen dan tenaga kesehatan dalam mendukung proses pembelajaran, diskusi kasus, maupun penguatan kompetensi dalam pelayanan kesehatan ibu.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kelengkapan materi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kebidanan, khususnya dalam upaya deteksi dini, penanganan awal, dan pencegahan komplikasi masa nifas.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan dalam proses penyusunan buku ajar ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat dan mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan ibu yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **iii**
Daftar Isi ..... **v**

BAB 1 KONSEP DASAR KOMPLIKASI MASA NIFAS, FAKTOR RISIKO, DAN KESELAMATAN IBU **1**
A. Konsep Dasar Komplikasi Masa Nifas 5
B. Jenis-Jenis Komplikasi Masa Nifas 6
C. Faktor Risiko Komplikasi Masa Nifas 11
D. Prinsip Keselamatan Ibu (Patient Safety, PPI/K3) pada Masa Nifas 14
E. RINGKASAN 35
Referensi **38**

BAB 2 PERDARAHAN POSTPARTUM: KLASIFIKASI, PENYEBAB (4T) DAN TINDAKAN AWAL DI PELAYANAN PRIMER **40**
A. Teori Dasar 44
B. ETIOLOGI 45
C. KLASIFIKASI PERDARAHAN POSTPARTUM 47
D. TANDA DAN GEJALA 49
E. PEMERIKSAAN PENUNJANG 50
F. KOMPLIKASI 52
G. PENGKAJIAN KLINIS TERFOKUS 53
H. RINGKASAN 76

BAB 3 RETENSIO PLASENTA DAN SISA PLASENTA: TANDA KLINIS, PENANGANAN AWAL, DAN RUJUKAN **80**
A. Definisi 85
B. Etiologi 85
C. FAKTOR RISIKO 87
D. PATOFISIOLOGI 87
E. KLASIFIKASI 89
F. TANDA DAN GEJALA 89
G. PEMERIKSAAN PENUNJANG 90
H. KOMPLIKASI 90
I. PENATALAKSANAAN 92
J. RANGKUMAN 98

Referensi 100

BAB 4 LASERASI JALAN LAHIR DAN HEMATOMA: IDENTIFIKASI, PENATALAKSANAAN AWAL, DAN RUJUKANCAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 101

A. Pendahuluan 105
B. Definisi 106
C. Klasifikasi Laserasi 106
D. Etiologi dan Faktor Risiko 106
E. Patofisiologi 107
F. Manifestasi Klinis 107
G. Identifikasi dan Diagnosis 108
H. Penatalaksanaan Awal 108
I. Pencegahan 109
J. Indikasi Rujukan 109
K. Komplikasi 109
L. Peran Bidan 109

Referensi 117

BAB 5 INFEKSI MASA NIFAS: ENDOMETRITIS, INFEKSI LUKA, DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN 118

A. Endometritis 123
B. Infeksi Luka 125

Referensi 135

Profil Penulis 136

BAB 1

KONSEP DASAR KOMPLIKASI MASA NIFAS, FAKTOR RISIKO, DAN KESELAMATAN IBU

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan (PPI/K3) dalam pelayanan/asuhan masa nifas.	CPMK-1, CPMK-4, CPMK-6
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi interprofesional yang berpusat pada ibu dan keluarga.	CPMK-2, CPMK-6, CPMK-7
CPL-3	Menggunakan clinical reasoning dan evidence-based practice dalam pengambilan keputusan asuhan pada komplikasi nifas.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4
CPL-4	Melakukan pengkajian terfokus–komprehensif masa nifas (anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi tanda vital) untuk deteksi dini komplikasi.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5
CPL-5	Melaksanakan tindakan awal, stabilisasi dasar, dan menentukan kebutuhan rujukan pada komplikasi nifas.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-6
CPL-6	Melaksanakan edukasi, konseling, dukungan laktasi dan kesehatan mental, dokumentasi, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.	CPMK-5, CPMK-7, CPMK-1

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan prinsip profesionalisme, etika–legal, keselamatan (PPI/K3), dokumentasi, dan penggunaan pedoman/evidence dalam asuhan komplikasi nifas.
CPMK-2	Melakukan pengkajian terfokus ibu nifas dan menafsirkan tanda vital untuk menetapkan prioritas masalah serta rencana asuhan awal.
CPMK-3	Melaksanakan penatalaksanaan awal perdarahan postpartum dengan pendekatan 4T, stabilisasi, monitoring, dan keputusan rujukan sesuai algoritme.
CPMK-4	Melaksanakan deteksi dini serta penatalaksanaan awal infeksi masa nifas dan sepsis, termasuk pencegahan penyebaran dan evaluasi respons.
CPMK-5	Melaksanakan pengkajian dan penatalaksanaan awal gangguan laktasi (bendungan ASI, puting lecet, mastitis) serta koreksi teknik menyusui dan dukungan keluarga.
CPMK-6	Melakukan triase, stabilisasi pra-rujukan, dan komunikasi rujukan efektif untuk komplikasi nifas termasuk komplikasi sistemik.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Merancang dan melaksanakan edukasi, skrining kesehatan mental, konseling KB, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Komplikasi Masa Nifas: Fisiologi Nifas, Faktor Risiko, dan Keselamatan Ibu	1.1 Menguraikan parameter fisiologis nifas normal dan deviasi yang mengarah pada komplikasi.	1.2 Mengidentifikasi faktor risiko dan menerapkan prinsip keselamatan ibu pada pelayanan nifas.	CPMK-1	CPMK-2

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Tes tertulis (MCQ/SAQ) + audit dokumentasi kasus	Kepatuhan item keselamatan (PPI/K3/identifikasi) pada checklist; kelengkapan dan ketepatan format dokumentasi klinis; kesesuaian keputusan dengan pedoman/evidence yang dirujuk	10	Lembar jawaban tes; lembar audit dokumentasi; daftar rujukan pedoman
CPMK-2	OSCE pengkajian + ujian kasus tertulis	Kelengkapan data kunci anamnesis–pemeriksaan fisik; akurasi interpretasi tanda vital; ketepatan penetapan prioritas masalah dan rencana awal	15	Checklist OSCE; jawaban kasus tertulis

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Kepatuhan keselamatan pasien & PPI/K3	>2 langkah kritis terlewat; praktik berisiko; tidak konsisten menggunakan	Langkah dasar dilakukan namun ada 1–2 kekeliruan/terlewat; perlu arahan	Langkah kritis terlaksana konsisten; hanya	Proaktif mengidentifikasi risiko, melakukan mitigasi, dan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
	APD/hand hygiene		kekurangan minor	mengedukasi; tanpa kekeliruan
1.2 Dokumentasi & penggunaan pedoman/evidence	Dokumentasi tidak runtut/tidak lengkap; rasional tidak jelas; rujukan tidak relevan	Dokumentasi cukup tetapi ada data kunci hilang; rasional masih lemah; rujukan terbatas	Dokumentasi lengkap dan jelas; rasional sesuai pedoman; rujukan relevan	Dokumentasi sangat lengkap untuk continuity; rasional kuat; rujukan pedoman mutakhir dan kontekstual

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Anamnesis terfokus & pemeriksaan fisik sistematis	Data tidak terarah; komponen penting banyak terlewat	Data utama terkumpul namun belum sistematis; beberapa komponen terlewat	Sistematis, lengkap, dan komunikatif; kekurangan minor	Sangat sistematis, menggali red flags, menyesuaikan prioritas, komunikasi sangat efektif
2.2 Interpretasi tanda vital & prioritisasi masalah	Salah menafsir tanda vital/red flags; prioritas tidak tepat	Menafsir sebagian benar; prioritas belum konsisten	Menafsir tepat; menetapkan prioritas masalah dan rencana awal dengan rasional	Menafsir sangat tepat (termasuk kewaspadaan dini); prioritas dan rencana monitoring jelas dan terukur

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Klasifikasi PPH & identifikasi 4T	Klasifikasi salah; penyebab tidak terpetakan	Klasifikasi cukup; 1–2 komponen 4T teridentifikasi	Klasifikasi tepat; 4T disaring lengkap; penyebab paling mungkin ditetapkan berbasis temuan	Analisis komprehensif (kemungkinan multipel); menyusun kebutuhan konfirmasi dan pemantauan lanjutan
3.2 Tindakan awal–stabilisasi & monitoring	Urutan tindakan tidak sesuai; respons lambat; monitoring tidak terdokumentasi	Tindakan dasar dilakukan namun urutan/monitoring belum konsisten	Tindakan awal dan stabilisasi sesuai algoritme & kewenangan; monitoring dan	Sangat cepat dan tepat; monitoring komprehensif; persiapan rujukan terkoordinasi dengan baik

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
			keputusan rujukan tepat	

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Identifikasi infeksi/sepsis & derajat kegawatan	Tanda bahaya tidak dikenali; penilaian derajat tidak dilakukan	Gejala umum dikenali, namun red flags/derajat belum lengkap	Tanda klinis kunci dikenali; derajat kegawatan dan diagnosis kerja tepat	Penilaian sangat tajam; memetakan risiko komplikasi dan rencana monitoring terukur
4.2 Tatalaksana awal & pencegahan penyebaran	PPI diabaikan; tatalaksana awal tidak sesuai	PPI sebagian; tatalaksana awal sebagian sesuai; monitoring terbatas	PPI konsisten; tatalaksana awal sesuai protokol/kewenangan; evaluasi respons dilakukan	Komprehensif; koordinasi kolaborasi/rujukan tepat; dokumentasi lengkap dan jelas

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Pengkajian masalah laktasi	Penilaian teknik menyusui tidak dilakukan; masalah tidak teridentifikasi	Penilaian dasar dilakukan namun belum lengkap; penyebab belum jelas	Pengkajian lengkap (ibu–bayi–teknik); penyebab utama tepat	Analisis menyeluruh termasuk faktor psikososial; prioritas masalah dan target perbaikan jelas
5.2 Koreksi teknik menyusui & konseling	Demonstrasi keliru/berisiko; konseling tidak jelas	Demonstrasi cukup tetapi masih ada kesalahan; konseling belum individual	Demonstrasi benar; konseling jelas; rencana tindak lanjut dan kriteria rujukan tepat	Coaching sangat efektif (teach-back); melibatkan keluarga; follow-up terstruktur dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Triase & stabilisasi pra-rujukan	Kegawatan tidak dikenali; stabilisasi tidak tepat/tidak dilakukan	Kegawatan dikenali sebagian; stabilisasi dasar ada namun belum lengkap	Triase tepat; stabilisasi sesuai protokol/kewenangan; monitoring berkelanjutan	Sangat cepat, antisipatif, dan terkoordinasi; menyiapkan kebutuhan transport/alat secara optimal

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.2 Komunikasi rujukan & resume	Informasi kritis hilang; komunikasi tidak runtut; resume tidak lengkap	Komunikasi cukup runtut tetapi ada data kunci terlewat; resume perlu perbaikan	SBAR lengkap; resume rujukan jelas (tindakan, respons, rencana)	Closed-loop communication; memastikan penerimaan; rencana transport & rujukan balik terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Skrining kesehatan mental & tindak lanjut	Skrining tidak dilakukan; risiko krisis tidak dinilai	Skrining dilakukan terbatas; tindak lanjut belum jelas	Menggunakan instrumen tervalidasi; menilai risiko; dukungan awal dan rujukan sesuai	Komprehensif; safety plan jelas; pelibatan keluarga kuat; follow-up terjadwal dan terdokumentasi
7.2 Edukasi tanda bahaya/KB & continuity of care	Materi edukasi tidak lengkap; tanpa rencana tindak lanjut	Materi cukup namun belum disesuaikan; tindak lanjut umum	Materi lengkap dan terstruktur; metode sesuai; rencana follow-up jelas	Edukasi sangat efektif (teach-back + media); continuity of care rinci (kunjungan/telefollow-up/rujukan balik)

A. Konsep Dasar Komplikasi Masa Nifas

Masa nifas merupakan periode sejak lahirnya plasenta sampai sekitar 6-8 minggu setelah persalinan beradaptasi kembali menuju kondisi pra-hamil. Dalam periode ini berlangsung proses involusi uterus, penyesuaian sistem kardiovaskular dan hematologis, penyembuhan luka, serta adaptasi laktasi dan psikologis. Meskipun secara fisiologis masa nifas dapat berlangsung normal, kenyataannya fase ini merupakan salah satu periode paling rentan terhadap kesakitan dan kematian ibu bila terjadi komplikasi yang tidak terdeteksi atau tidak tertangani secara tepat waktu.

Komplikasi masa nifas dapat muncul segera setelah persalinan (dalam 24 jam pertama), pada minggu pertama, maupun beberapa minggu kemudian. Oleh karena itu, bidan wajib memahami jenis-jenis komplikasi yang paling sering terjadi, tanda-tanda klinis yang harus diwaspadai, dan prinsip penatalaksanaan awal yang aman. Komplikasi utama masa nifas yang perlu diperhatikan meliputi perdarahan nifas (*postpartum hemorrhage*), infeksi nifas (*puerperal* sepsis), tromboemboli, komplikasi kardiovaskular, dan gangguan psikologis seperti depresi *postpartum.*

B. Jenis-Jenis Komplikasi Masa Nifas

1. Perdarahan nifas (*Postpartum Hemorrhage*/PPH)

   Perdarahan nifas adalah perdarahan berlebihan setelah kelahiran bayi yang dapat mengancam jiwa. Perdarahan nifas dibedakan menjadi:

   a. Perdarahan nifas primer (dini)

      Terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan, dan umumnya disebabkan oleh atonia uteri (kontraksi uterus yang tidak adekuat), laserasi jalan lahir, retensi jaringan plasenta, atau gangguan pembekuan darah. Dalam praktik klinik dikenal konsep "4T" sebagai penyebab utama PPH:

      1) *Tone* (atonia uteri)
      2) *Trauma* (robekan jalan lahir, ruptur)
      3) *Tissue* (sisa plasenta atau selaput)
      4) *Thrombin* (kelainan koagulasi)

   b. Perdarahan nifas sekunder (lanjut)

      Terjadi setelah 24 jam sampai beberapa minggu *postpartum*. Penyebabnya sering berkaitan dengan subinvolusi uterus, sisa jaringan plasenta yang tertinggal, infeksi endometrium, atau kelainan koagulasi yang belum diidentifikasi. Secara klinis, ibu mengeluh perdarahan yang tetap banyak atau kembali meningkat, kadang disertai bekuan darah, rasa lemah, pusing, hingga tanda syok.

2. Infeksi masa nifas (*Puerperal* Sepsis)

   Infeksi masa nifas mencakup berbagai kondisi, seperti endometritis (infeksi lapisan dalam uterus), infeksi luka perineum atau luka SC, infeksi saluran kemih, dan infeksi payudara (mastitis). Endometritis merupakan salah satu bentuk infeksi nifas yang paling sering, ditandai oleh demam, nyeri perut bagian bawah, subinvolusi uterus, dan perubahan karakter lokia. Secara klinis, tanda-tanda infeksi nifas dapat meliputi:

   a. Demam, biasanya ≥ 38 °C, yang menetap atau muncul kembali setelah sempat normal.
   b. Nyeri perut bawah atau nyeri tekan uterus.
   c. Uterus yang tetap tinggi dan lembek (subinvolusi), tidak turun sesuai pola normal.
   d. Lokia yang berbau busuk, berubah menjadi purulen, atau jumlahnya tidak sesuai fase.
   e. Nyeri, kemerahan, atau keluarnya cairan berbau dari luka perineum atau luka operasi.

Bila infeksi tidak dikenali dan tertangani sedini mungkin, ibu berisiko berkembang menjadi sepsis, yaitu respons sistemik terhadap infeksi yang dapat menyebabkan syok septik dan kematian.

3. Tromboemboli dan komplikasi kardiovaskular

   Periode *postpartum* meningkatkan risiko terbentuknya trombus pada vena (trombosis vena dalam) dan emboli paru, terutama pada ibu dengan faktor risiko tertentu. Secara fisiologis, kehamilan dan nifas merupakan keadaan hiperkoagulabel, ditambah adanya kemungkinan imobilisasi dan cedera pembuluh darah saat persalinan. Tanda klinis trombosis vena dalam antara lain nyeri pada tungkai, bengkak unilateral, kemerahan, dan peningkatan suhu lokal. Bila trombus lepas dan bermigrasi ke paru, dapat terjadi emboli paru yang ditandai dengan sesak napas mendadak, nyeri dada, takikardi, dan kemungkinan kolaps. Selain itu, kardiomiopati peripartum dan gangguan kardiovaskular lainnya juga dapat muncul atau memburuk pada periode ini.

4. Komplikasi lain: aspek fisik dan aspek psikologis

   Beberapa komplikasi masa nifas ini tampak "ringan", namun apabila diabaikan dapat berujung serius. Komplikasi tersebut diantaranya adalah:

   a. Mastitis

      Mastitis adalah peradangan jaringan payudara yang biasa terjadi pada ibu menyusui dalam 2–3 minggu pertama *postpartum*, meskipun dapat muncul kapan saja selama laktasi. Peradangan ini sering berawal dari bendungan ASI (*engorgement)* dan adanya mikrotrauma pada puting (lecet/fisura) yang menjadi pintu masuk kuman. Lingkungan yang kaya nutrisi (ASI yang tertahan) dan aliran yang tidak lancar membuat bakteri mudah berkembang di jaringan payudara. Secara klinis, mastitis ditandai dengan tanda-tanda infeksi seperti demam (kalor), nyeri (dolor), kemerahan (rubor), bengkak (tumor), dan kehilangan dungsi (*functio luesa*). Faktor pencetus mastitis antara lain:

      1) Bendungan ASI karena bayi jarang menyusu, jadwal menyusui dibatasi, atau payudara tidak dikosongkan tuntas.
      2) Posisi dan perlekatan yang salah sehingga bayi hanya menghisap puting, bukan areola, sehingga aliran ASI tidak optimal.
      3) Puting lecet/ fisura yang tidak dirawat, sehingga bakteri dari kulit atau mulut bayi lebih mudah masuk.
      4) Tekanan lokal pada payudara, misalnya bra terlalu ketat atau posisi tidur tertentu yang menekan payudara.

b. Abses Payudara

Abses payudara adalah kumpulan pus (nanah) terlokalisasi di jaringan payudara sebagai kelanjutan mastitis yang berat atau tidak tertangani. Prosesnya dimulai dari peradangan dan infeksi yang semakin dalam, sehingga terbentuk rongga berisi pus. Abses payudara pada masa nifas ditandai dengan benjolan yang sangat nyeri pada payudara, teraba fluktuatif atau lembek di bagian tengahnya, dengan kulit di atasnya tampak sangat merah, mengkilap, dan terasa sangat hangat saat disentuh. Ibu biasanya mengalami demam yang dapat menetap atau naik-turun, disertai kelelahan ekstrem dan rasa tidak nyaman secara umum. Pada kasus yang lebih lanjut, abses dapat menembus kulit sehingga keluar cairan purulen atau nanah dari titik tertentu pada permukaan payudara.

Dari sisi dampak dan penatalaksanaannya, abses payudara hampir selalu memerlukan tindakan drainase melalui insisi dan pengeluaran pus di fasilitas kesehatan yang mampu, bersamaan dengan pemberian antibiotik sistemik untuk mengatasi infeksi. Menyusui dari payudara yang terkena biasanya dihentikan sementara waktu guna mencegah penyebaran infeksi, meskipun menyusui dari payudara sisi sebelah tetap dianjurkan untuk mencegah terjadinya bendungan ASI. Penanganan yang terlambat tidak hanya memperpanjang masa nyeri dan ketidaknyamanan ibu, tetapi juga meningkatkan risiko ibu berhenti menyusui secara keseluruhan, serta dapat meninggalkan jaringan parut permanen pada payudara yang memengaruhi estetika dan fungsi laktasi di masa depan.

c. Gangguan Eliminasi (Retensi Urin)

Retensi urin adalah ketidakmampuan ibu untuk mengosongkan kandung kemih secara adekuat setelah melahirkan, yang sering terjadi dalam 24–72 jam pertama postpartum, terutama pada kasus persalinan lama, penggunaan analgesia atau anestesi, trauma perineum, atau seksio sesarea. Mekanismenya melibatkan distensi kandung kemih yang menekan uterus sehingga mengganggu kontraksi normal, berkontribusi pada subinvolusi uterus dan meningkatkan risiko perdarahan nifas. Secara klinis, ibu merasa tidak puas setelah berkemih, sering bolak-balik ke toilet dengan volume urin kecil, atau justru tidak merasa ingin buang air kecil padahal kandung kemih sudah penuh, disertai benjolan suprapubik yang teraba, rasa tidak nyaman, atau nyeri di perut bawah.

Dampak dari kondisi ini cukup serius, karena dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, mengganggu proses involusi uterus secara keseluruhan, memperbesar kemungkinan perdarahan nifas, serta menimbulkan

ketidaknyamanan dan nyeri yang signifikan bagi ibu. Prinsip asuhan kebidanan mencakup anjuran BAK teratur dalam beberapa jam pertama setelah persalinan, dan bila ibu tidak mampu BAK spontan dengan tanda distensi kandung kemih, perlu dipertimbangkan kateterisasi sesuai protokol yang berlaku. Selain itu, edukasi penting diberikan mengenai kebutuhan minum yang cukup untuk merangsang produksi urin serta posisi BAK yang nyaman guna memfasilitasi pengosongan kandung kemih secara efektif.

d. Gangguan Eliminasi (Konstipasi)

Konstipasi pada ibu nifas merupakan kondisi sulit atau jarangnya buang air besar yang sering dialami karena adanya perubahan hormon pascapersalinan, rasa takut untuk mengejan dengan jahitan perineum, kurangnya mobilisasi dini dan asupan cairan serta serat yang tidak mencukupi. Secara klinis, ibu mengalami buang air besar dengan tinja keras sehingga memerlukan usaha mengejan yang kuat, rasa penuh dan tidak nyaman di perut, yang terkadang diperparah dengan nyeri perineum apabila terdapat luka jahitan.

Dampak dari konstipasi ini tidak hanya meningkatkan ketidaknyamanan fisik, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan stres yang dapat memperburuk kondisi psikologis ibu nifas. Pada kasus yang berat, konstipasi dapat menyebabkan hemoroid memburuk atau bahkan retensi feses yang lebih lanjut. Prinsip asuhan kebidanan meliputi anjuran untuk meningkatkan asupan cairan dan makanan berserat secara cukup, mendorong mobilisasi dini dengan aman, serta mengajarkan teknik mengejan yang tidak membebani luka perineum.

e. Gangguan Kontinensia (Inkontinensia Urin/Feses)

Gangguan kontinensia adalah ketidakmampuan menahan keluarnya urin atau feses. Gangguan yang paling sering terjadi masa nifas adalah inkontinensia urin stres (urin keluar saat batuk, tertawa, mengangkat beban). Selama kehamilan dan persalinan, peregangan otot dasar panggul serta struktur penunjangnya dapat menyebabkan gangguan fungsi kandung kemih. Kondisi ini dapat diperberat oleh trauma obstetrik, seperti persalinan yang lama, ukuran bayi yang besar, penggunaan forsep atau vakum, serta robekan perineum derajat tinggi. Akibatnya, ibu dapat mengalami keluarnya urin tanpa disadari saat batuk, tertawa, atau bersin. Beberapa juga merasakan sensasi tidak tuntas saat berkemih atau mengalami kebocoran urin ketika kandung kemih penuh. Pada kasus yang lebih berat, misalnya bila terdapat kerusakan sfingter akibat robekan derajat tinggi, ibu dapat mengalami kesulitan menahan gas atau bahkan feses.

Keluhan ini tidak hanya berdampak fisik tetapi juga psikologis. Ibu sering kali merasa kehilangan kepercayaan diri, malu, bahkan menarik diri dari aktivitas sosial. Selain itu, bila kebersihan daerah genital tidak terjaga, risiko infeksi juga dapat meningkat. Oleh karena itu, asuhan pada kondisi ini meliputi edukasi latihan dasar panggul atau senam Kegel yang dapat dimulai sedini mungkin setelah tidak ada kontraindikasi. Dukungan psikologis sangat penting agar ibu merasa didengar dan tidak malu mengungkapkan keluhannya. Bila keluhan cukup berat atau menetap, sebaiknya dilakukan rujukan ke layanan uroginekologi atau rehabilitasi medik untuk penanganan yang lebih komprehensif.

f. Aspek Psikologis

Masa nifas merupakan periode yang rentan terhadap perubahan psikologis karena ibu sedang beradaptasi dengan kondisi fisik pascapersalinan, perubahan hormonal, kelelahan, serta tanggung jawab baru dalam merawat bayi. Pada fase ini, ibu dapat mengalami gangguan suasana hati dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Dampak psikologis tersebut dapat muncul secara bertahap, mulai dari perubahan mood ringan yang bersifat sementara hingga kondisi yang lebih berat dan membutuhkan penanganan khusus. Berikut waktu perubahan psikologis ibu nifas menurut beberapa referensi:

1) Hari 0–2 *postpartum*: fase *taking-in*

   Pada fase ini ibu masih berfokus pada dirinya sendiri, kondisi fisik setelah persalinan, dan pengalaman melahirkan. Ibu cenderung pasif, banyak membutuhkan istirahat, serta mulai menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

2) Hari 2–10 *postpartum*: fase *taking-hold*

   Ibu mulai lebih aktif merawat bayi dan belajar menjalankan peran baru sebagai ibu. Pada periode ini muncul kerentanan psikologis berupa rasa cemas, kurang percaya diri, mudah khawatir, dan perasaan kewalahan dalam menghadapi tanggung jawab pengasuhan.

3) Setelah hari ke-10 *postpartum*: fase *letting-go*

   Ibu mulai menerima peran barunya dan menyesuaikan diri dengan kehidupan keluarga setelah melahirkan. Pada tahap ini, proses adaptasi psikologis berlanjut menuju penerimaan dan penyesuaian jangka lebih panjang.

4) Hari ke-2 sampai ke-5 *postpartum*: onset *baby blues*
   Perubahan mood ringan biasanya mulai tampak pada rentang waktu ini. Gejalanya berupa mudah menangis, emosi labil, mudah tersinggung, cemas, dan merasa kewalahan.
5) Hari ke-10 sampai 14 *postpartum*: *baby blues* umumnya mulai mereda
   Pada sebagian besar ibu, gejala *baby blues* bersifat sementara dan akan membaik dalam 1–2 minggu setelah persalinan.
6) Lebih dari 2 minggu *postpartum*: curiga depresi *postpartum*
   Bila gejala tidak membaik atau justru memburuk setelah dua minggu, kondisi ini perlu diwaspadai sebagai depresi postpartum.
7) 4 minggu *postpartum* ke atas: depresi *postpartum* dapat mulai terdeteksi
   Depresi *postpartum* dapat muncul sejak sekitar satu bulan setelah melahirkan dan pada beberapa kasus dapat berlanjut hingga berbulan-bulan setelah persalinan.
8) Minggu ke-7–8 *postpartum*: periode yang sering dilaporkan sebagai waktu muncul gejala
   Beberapa penelitian menyebutkan gejala depresi *postpartum* sering tampak pada minggu ke-7 hingga ke-8 setelah melahirkan. Dampak yang lebih berat bila tidak tertangani, ibu dapat mengalami sedih mendalam, kehilangan minat, kelelahan ekstrem, gangguan tidur, rasa tidak mampu merawat bayi, gangguan *bonding*, penurunan keberhasilan menyusui, hingga pikiran menyakiti diri sendiri atau bayi.

C. Faktor Risiko Komplikasi Masa Nifas

1. Faktor risiko perdarahan nifas

   Faktor risiko perdarahan nifas dapat diklasifikasikan berdasarkan fase sebelum, selama, dan setelah persalinan:

   a. Sebelum persalinan (*antepartum*)

      Pada masa *antepartum*, risiko perdarahan nifas dapat telah teridentifikasi sejak kehamilan berlangsung. Riwayat perdarahan *postpartum* pada kehamilan sebelumnya merupakan faktor risiko penting karena menunjukkan kemungkinan terjadinya kejadian serupa pada persalinan berikutnya. Selain itu, plasenta previa, solusio plasenta, kehamilan ganda, dan hidramnion juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko perdarahan karena berkaitan dengan gangguan implantasi plasenta, peregangan uterus yang berlebihan, atau kondisi kehamilan yang tidak stabil. Ibu dengan preeklampsia, hipertensi, anemia, maupun gangguan koagulasi memiliki kerentanan lebih tinggi karena

kondisi tersebut dapat memperburuk kemampuan tubuh dalam mempertahankan hemostasis. Usia ibu yang terlalu muda maupun terlalu tua, serta obesitas, juga perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi obstetrik.

b. Selama persalinan (*intrapartum*)

Pada fase *intrapartum*, perdarahan nifas sering kali berhubungan dengan proses persalinan yang berlangsung lama atau mengalami hambatan. Persalinan yang memanjang dapat menyebabkan kelelahan uterus sehingga kontraksi setelah bayi lahir menjadi kurang efektif. Penggunaan induksi atau augmentasi dengan oksitosin yang tidak terkontrol juga dapat memengaruhi fungsi kontraksi uterus secara optimal. Tindakan persalinan operatif seperti forsep, vakum, maupun seksio sesarea dapat meningkatkan risiko perdarahan karena berkaitan dengan trauma jaringan dan kehilangan darah yang lebih besar. Selain itu, laserasi jalan lahir yang luas, ruptur uteri, serta retensio plasenta merupakan kondisi yang dapat menyebabkan perdarahan hebat dan memerlukan penanganan segera.

c. Setelah persalinan (*postpartum*)

Pada masa *postpartum*, perdarahan nifas dapat terjadi akibat subinvolusi uterus atau adanya sisa jaringan plasenta yang tidak terdeteksi. Subinvolusi uterus menyebabkan proses pengecilan rahim berjalan lambat, sehingga pembuluh darah bekas implantasi plasenta tetap terbuka dan perdarahan dapat berlanjut. Sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim juga dapat menghambat kontraksi uterus dan memicu perdarahan lanjutan. Di samping itu, infeksi uterus dapat mengganggu proses involusi normal karena adanya peradangan yang menurunkan efektivitas kontraksi rahim. Gangguan pembekuan darah yang tidak segera ditangani turut memperberat kondisi, sebab tubuh tidak mampu menghentikan perdarahan secara adekuat. Oleh karena itu, pemantauan ketat pada masa nifas sangat diperlukan untuk mendeteksi tanda-tanda awal perdarahan.

2. Faktor risiko infeksi nifas

Infeksi nifas merupakan salah satu komplikasi yang berhubungan erat dengan kondisi kesehatan ibu sebelum persalinan serta mutu asuhan yang diterima selama proses persalinan dan masa nifas. Risiko terjadinya infeksi akan meningkat apabila ibu tidak mendapatkan kunjungan antenatal yang memadai, karena kondisi seperti anemia, diabetes, atau infeksi lain dapat tidak terdeteksi sejak awal dan akhirnya tidak tertangani dengan baik. Selain itu, persalinan yang berlangsung di rumah atau di fasilitas dengan standar kebersihan dan pencegahan infeksi yang rendah juga turut memperbesar risiko, terutama bila

tidak ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih dan tanpa dukungan peralatan steril yang memadai.

Faktor lain yang juga berperan adalah persalinan yang lama, ketuban pecah dalam waktu yang lama, serta seringnya dilakukan pemeriksaan vaginal tanpa penerapan teknik aseptik yang baik. Kondisi ini membuka peluang masuknya mikroorganisme ke saluran genital ibu sehingga memicu infeksi. Risiko juga semakin meningkat pada ibu yang menjalani tindakan invasif, seperti pemasangan alat, operasi, atau manipulasi intrauterin, apabila prosedur sterilisasi tidak dilakukan secara optimal. Di samping itu, status gizi yang buruk, anemia berat, penyakit kronis seperti diabetes, serta lingkungan rumah yang kurang higienis dapat menurunkan daya tahan tubuh ibu dan memperburuk kerentanan terhadap infeksi nifas.

3. Faktor risiko tromboemboli dan masalah psikologis

Ibu nifas yang terdapat faktor predisposisi seperti obesitas, usia ibu yang lebih tua, serta riwayat trombosis sebelumnya memiliki risiko lebih tinggi mengalami tromboemboli. Risiko ini semakin meningkat pada kondisi yang menyebabkan ibu lebih banyak berbaring atau kurang bergerak, misalnya setelah seksio sesarea atau akibat komplikasi lain yang membatasi mobilisasi. Selain itu, preeklampsia, dehidrasi, dan kondisi yang meningkatkan kekentalan darah juga turut memperbesar kemungkinan terbentuknya bekuan darah, sehingga perlu diwaspadai selama masa nifas.

Selain aspek fisik, masalah psikologis pada masa nifas juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko. Ibu dengan riwayat depresi atau gangguan kecemasan sebelumnya lebih rentan mengalami gangguan emosional setelah melahirkan. Risiko juga meningkat pada ibu yang kurang mendapatkan dukungan keluarga dan sosial, mengalami stres berat, kesulitan ekonomi, atau konflik dalam keluarga. Pengalaman persalinan yang traumatis maupun komplikasi serius pada ibu atau bayi dapat memperberat beban psikologis dan memicu munculnya kecemasan, ketakutan, hingga depresi *postpartum*.

Identifikasi faktor risiko tersebut sangat penting dalam asuhan kebidanan karena membantu bidan menentukan tindak lanjut yang lebih tepat. Dengan mengenali ibu yang berisiko, bidan dapat merencanakan kunjungan rumah yang lebih intensif, memberikan dukungan emosional secara berkelanjutan, serta melakukan rujukan apabila ditemukan tanda bahaya atau kebutuhan penanganan lanjutan.

D. Prinsip Keselamatan Ibu (*Patient Safety*, PPI/K3) pada Masa Nifas

1. Identifikasi dini tanda bahaya
   a. Perdarahan sangat banyak, perdarahan yang tiba-tiba meningkat kembali, atau keluarnya bekuan darah besar.

      Keadaan ini merupakan tanda bahaya yang mengindikasikan adanya perdarahan nifas yang tidak normal. Perdarahan yang kembali banyak setelah sempat berkurang, maupun keluarnya bekuan darah berukuran besar, dapat menunjukkan gangguan involusi uterus, sisa plasenta, atau kelainan lain yang membutuhkan penanganan segera.
   b. Demam tinggi, menggigil, nyeri perut bawah hebat, atau lokia berbau busuk.

      Gejala tersebut mengarah pada kemungkinan terjadinya infeksi nifas. Demam dan menggigil mencerminkan respons tubuh terhadap proses infeksi, sedangkan nyeri perut bawah dan lokia yang berbau tidak sedap dapat menjadi tanda infeksi pada uterus atau jalan lahir. Kondisi ini perlu segera dievaluasi agar tidak berkembang menjadi komplikasi yang lebih berat.
   c. Sakit kepala berat, gangguan penglihatan, nyeri epigastrium, atau tekanan darah meningkat.

      Tanda-tanda ini dapat mengarah pada komplikasi hipertensi pada masa nifas, termasuk preeklampsia *postpartum*. Sakit kepala berat, pandangan kabur, nyeri pada ulu hati, dan peningkatan tekanan darah merupakan gejala yang harus segera mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan komplikasi serius.
   d. Sesak napas tiba-tiba, nyeri dada, berdebar, atau salah satu tungkai bengkak, merah, dan nyeri.

      Keluhan tersebut dapat mengindikasikan terjadinya tromboemboli, seperti trombosis vena dalam atau emboli paru. Sesak napas mendadak dan nyeri dada merupakan tanda kegawatdaruratan, sedangkan pembengkakan tungkai yang disertai kemerahan dan nyeri dapat menunjukkan adanya bekuan darah pada pembuluh vena. Penanganan segera sangat diperlukan untuk mencegah kondisi yang mengancam jiwa.
   e. Perubahan psikologis berat, seperti menangis terus-menerus, rasa putus asa, atau pikiran menyakiti diri sendiri maupun bayi.

      Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan psikologis berat, seperti depresi postpartum. Perubahan emosi yang menetap, perasaan putus asa, serta munculnya pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayi merupakan tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Keadaan ini memerlukan dukungan psikologis, evaluasi profesional, dan rujukan segera bila diperlukan.

2. Penerapan PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam asuhan nifas

Penerapan PPI dan K3 dalam asuhan nifas adalah serangkaian upaya sistematis untuk mencegah terjadinya penularan infeksi serta melindungi ibu, bayi, keluarga, dan tenaga kesehatan dari risiko cedera selama proses pelayanan kebidanan. Pada masa nifas, ibu berada dalam kondisi yang relatif rentan karena adanya luka persalinan, luka operasi, perdarahan, serta penurunan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, penerapan prinsip PPI dan K3 menjadi bagian penting dalam menjaga mutu asuhan dan keselamatan pasien.

Tujuan utama penerapan PPI/K3 pada masa nifas adalah untuk meminimalkan risiko infeksi pada ibu dan bayi, mencegah penyebaran mikroorganisme di fasilitas pelayanan kesehatan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi tenaga kesehatan. Selain itu, penerapan ini juga bertujuan mengurangi risiko kecelakaan kerja, seperti tertusuk jarum, terpapar darah atau cairan tubuh, jatuh, dan cedera akibat lingkungan yang tidak aman. Dengan demikian, asuhan nifas dapat diberikan secara lebih aman, efektif, dan bermutu. Langkah penerapan:

a. Kebersihan tangan dan penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)

Kebersihan tangan merupakan langkah paling dasar namun paling penting dalam pencegahan infeksi. Tenaga kesehatan harus melakukan cuci tangan pada saat sebelum dan sesudah kontak dengan ibu atau bayi, sebelum tindakan aseptik, setelah kontak dengan cairan tubuh, serta setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Penggunaan sarung tangan bersih diperlukan saat pemeriksaan fisik yang berpotensi kontak dengan darah, lokia, atau cairan tubuh lain. Bila tindakan berisiko lebih tinggi, maka digunakan alat pelindung diri lain seperti masker, apron, atau pelindung wajah sesuai kebutuhan dan tingkat risiko.

b. Teknik aseptik dan sterilisasi alat

Semua tindakan yang melibatkan pemeriksaan perineum, penilaian luka operasi, maupun prosedur invasif harus dilakukan dengan teknik aseptik untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke tubuh ibu. Alat yang digunakan harus dalam kondisi bersih, dan bila tindakan memerlukan kontak dengan jaringan tubuh atau luka terbuka, alat harus steril sesuai indikasi. Permukaan atau alat yang terkontaminasi harus segera dibersihkan dengan prosedur disinfeksi yang benar agar tidak menjadi sumber penularan infeksi silang.

c. Pengelolaan limbah dan jarum tajam

Limbah medis, pembalut bekas, kasa yang terkontaminasi, serta bahan yang mengandung darah atau cairan tubuh harus dibuang ke dalam wadah

khusus sesuai klasifikasi limbah infeksius. Jarum tajam dan benda tajam lain wajib ditempatkan pada *safety box* untuk mencegah tertusuknya petugas atau orang lain. Pengelolaan limbah yang benar tidak hanya melindungi tenaga kesehatan, tetapi juga mencegah pencemaran lingkungan dan penularan penyakit.

d. Keamanan kerja dan lingkungan

Ruang pemeriksaan nifas harus ditata agar memberikan rasa aman, nyaman, dan menjaga privasi ibu. Tata letak ruangan perlu meminimalkan risiko jatuh, tersandung, atau cedera lain, terutama bagi ibu yang masih lemah setelah melahirkan. Ventilasi yang baik, pencahayaan memadai, serta kebersihan lingkungan juga sangat penting untuk menurunkan risiko pertumbuhan mikroorganisme dan mendukung kenyamanan asuhan. Lingkungan kerja yang aman akan membantu tenaga kesehatan memberikan pelayanan secara optimal sekaligus melindungi keselamatan ibu dan bayi.

3. Komunikasi keselamatan dan etika-legal

Asuhan nifas yang aman tidak hanya ditentukan oleh ketepatan tindakan klinis, tetapi juga oleh kualitas komunikasi antara tenaga kesehatan dan ibu. Komunikasi yang baik membantu ibu memahami kondisinya, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan kerja sama selama proses asuhan. Karena itu, setiap tindakan harus dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip etika dan ketentuan hukum yang berlaku agar pelayanan yang diberikan tidak hanya aman secara klinis, tetapi juga bertanggung jawab secara profesional.

a. Menjelaskan kondisi ibu, kemungkinan komplikasi, dan rencana tatalaksana dengan bahasa yang dapat dipahami.

Tenaga kesehatan perlu menyampaikan hasil pengkajian, kondisi ibu saat ini, serta kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak menimbulkan kebingungan. Penjelasan yang komunikatif akan membantu ibu memahami pentingnya pemeriksaan, tindakan, maupun pemantauan lanjutan. Dengan demikian, ibu dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait asuhan yang diterimanya.

b. Meminta persetujuan sebelum melakukan tindakan, termasuk menjelaskan risiko, manfaat, dan alternatif bila ada.

Setiap tindakan kebidanan harus didahului dengan persetujuan dari ibu setelah ia mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai tujuan tindakan, manfaat yang diharapkan, risiko yang mungkin muncul, serta alternatif yang tersedia apabila ada. Proses ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak ibu sebagai pasien sekaligus wujud penerapan prinsip otonomi dalam

pelayanan kesehatan. Dengan adanya persetujuan yang diinformasikan, tindakan yang dilakukan menjadi lebih etis dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Menjaga kerahasiaan informasi medis dan menghormati martabat ibu.

   Seluruh informasi yang diperoleh selama pemeriksaan dan asuhan nifas harus dijaga kerahasiaannya serta hanya disampaikan kepada pihak yang berwenang atau sesuai kebutuhan pelayanan. Selain itu, tenaga kesehatan harus memperlakukan ibu dengan penuh hormat, menjaga privasi, serta menghindari sikap atau tindakan yang dapat merendahkan martabat ibu. Prinsip ini penting untuk membangun rasa aman, nyaman, dan percaya antara ibu dan tenaga kesehatan.

d. Mendokumentasikan setiap temuan pemeriksaan, tindakan, dan edukasi secara lengkap dan akurat sebagai pertanggungjawaban profesional dan legal.

   Setiap hasil pemeriksaan, tindakan yang diberikan, respons ibu, serta edukasi yang telah disampaikan harus dicatat secara lengkap, jelas, dan sesuai fakta. Dokumentasi yang baik berfungsi sebagai bukti pelaksanaan asuhan, bahan evaluasi pelayanan, serta dasar pertanggungjawaban profesional dan hukum apabila diperlukan di kemudian hari. Oleh karena itu, pencatatan tidak boleh diabaikan karena merupakan bagian penting dari keselamatan pasien dan mutu pelayanan

Aktivitas 1 — *Knows How*

Seorang ibu berusia 30 tahun, G3P2A0, hari ke-5 masa nifas, datang ke puskesmas dengan keluhan demam sejak dua hari terakhir dan nyeri di perut bagian bawah. Ibu mengatakan perdarahan nifas masih cukup banyak dan mulai berbau tidak sedap. Ia juga mengeluh payudara kiri nyeri dan terasa tegang, sehingga enggan menyusui dari sisi tersebut. Riwayat persalinan: kala II memanjang, ketuban pecah 18 jam sebelum bayi lahir, dan terdapat luka jahitan perineum derajat 2. Sejak pulang dari rumah sakit, ibu jarang beranjak dari tempat tidur karena merasa lelah, minum sedikit, dan takut BAK maupun BAB karena nyeri di perineum.

Hasil pengkajian:

1. Suhu 38,7 °C, nadi 104 x/menit, tekanan darah 110/70 mmHg, respirasi 22 x/menit.
2. Uterus teraba masih setinggi pusat, lembek, dan nyeri tekan.
3. Lokia kecoklatan, berbau tidak sedap, jumlah sedang–banyak.
4. Luka perineum tampak kemerahan dan sedikit nyeri.
5. Payudara kiri tampak merah di satu area, hangat, dan sangat nyeri bila disentuh.
6. Ibu tampak lelah, cemas, dan mengatakan sulit tidur karena memikirkan kondisinya.

Pertanyaan diskusi:

1. Komplikasi masa nifas apa saja yang mungkin sedang dialami ibu pada kasus di atas?
2. Data apa yang mendukung dugaan perdarahan nifas sekunder, infeksi nifas, dan mastitis?
3. Faktor risiko apa saja yang tampak dari riwayat kehamilan, persalinan, dan masa nifas ibu?
4. *Red flags* (tanda bahaya) apa yang perlu segera diwaspadai dan menjadi indikasi eskalasi atau rujukan?
5. Tindakan awal aman apa yang harus dilakukan bidan di fasilitas pelayanan pertama dengan prinsip PPI/K3?
6. Bagaimana bidan menyusun rencana edukasi kepada ibu dan keluarga terkait tanda bahaya, perawatan luka, dan perawatan payudara?
7. Bagaimana contoh dokumentasi singkat (SOAP) untuk kasus ini?

Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/*skill lab* asuhan masa nifas

Fokus: urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Mahasiswa berlatih dalam *setting skill lab* untuk:

- Melakukan pengkajian cepat ibu nifas dengan keluhan komplikasi,
- Mengidentifikasi faktor risiko dan *red flags*,
- Melakukan tindakan awal yang aman sesuai kewenangan,
- Menerapkan PPI/K3 dan komunikasi terapeutik,
- Melakukan edukasi singkat, dan
- Mendokumentasikan asuhan.

SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	……..
2	Judul station	**Asuhan Masa Nifas Dengan Komplikasi**
3	Waktu yang dibutuhkan	**13 menit**
4	Tujuan station	Menilai 8 kompetensi professional bidan dalam asuhan ibu nifas dengan komplikasi secara terintegrasi
5	Kompetensi	**1. Pengumpulan data subjektif** **2. Prosedur pemeriksaan fisik dan laboratorium sederhana** **3. Perumusan diagnosis dan masalah** **4. Keterampilan prosedur tindakan sesuai pada perumusan diagnosis dan masalah** **5. KIE/Konseling** **6. Kolaborasi/ Rujukan** **7. Pendokumentasian** 8. **Perilaku profesional**
6	Kategori	1. Remaja 2. Masa pranikah/ prakonsepsi 3. Kehamilan fisiologis 4. Kehamilan dengan kompikasi atau kegawatdaruratan 5. Persalinan fisiologis 6. Persalinan dengan komplikasi atau kegawatdaruratan 7. Nifas fisiologis **8. Nifas dengan komplikasi atau kegawatdaruratan** 9. Bayi baru lahir, bayi dan balita fisiologis 10. Bayi baru lahir, bayi dan balita dengan komplikasi atau kegawatdaruratan 11. Masa antara/ keluarga berencana
7	Instruksi untuk peserta ujian	**SKENARIO KLINIK:** Ibu S, 30 tahun, G3P2A0, **hari ke-5 nifas**, datang ke Puskesmas dengan keluhan **demam 38,7°C sudah 2 hari ini, nyeri perut bawah, perdarahan masih banyak dan bau tidak sedap**, serta **payudara kiri merah, panas, nyeri dan takut menyusui**. Riwayat: kala II lama, ketuban pecah 18 jam, jahitan perineum

No.	Komponen	Isi
		derajat II. Hasil awal: Nadi 104x/menit, uterus tinggi lembek, lochea coklat berbau, payudara kiri panas, nyeri, kemerahan, dan bengkak **TUGAS:** 1. Lakukan pengkajian lengkap subyektif dan obyektif! 2. Tuliskan diagnosis kebidanan di lembar jawab! 3. Lakukan tindakan awal sesuai diagnosis! 4. Berikan KIE/konseling tanda bahaya dan rencana rujukan! 5. Tuliskan dokumentasi SOAP di lembar jawab!
8	Instruksi untuk penguji	**SKENARIO KLINIK:** Ibu S, 30 tahun, G3P2A0, **hari ke-5 nifas**, datang ke Puskesmas dengan keluhan **demam 38,7°C sudah 2 hari ini, nyeri perut bawah, perdarahan masih banyak dan bau tidak sedap**, serta **payudara kiri merah, panas, nyeri dan takut menyusui**. Riwayat: kala II lama, ketuban pecah 18 jam, jahitan perineum derajat II. Hasil awal: Nadi 104x/menit, uterus tinggi lembek, lochea coklat berbau, payudara kiri panas, nyeri, kemerahan, dan bengkak **TUGAS:** 1. Lakukan pengkajian lengkap subyektif dan obyektif! 2. Tuliskan diagnosis kebidanan di lembar jawab! 3. Lakukan tindakan awal sesuai diagnosis! 4. Berikan KIE/konseling tanda bahaya dan rencana rujukan! 5. Tuliskan dokumentasi SOAP di lembar jawab! **INSTRUKSI PENGUJI:** 1. Menilai peserta melakukan PPI/K3 (hand hygiene, APD, limbah safety) 2. Menilai peserta melakukan pengkajian data subyektif (menanyakan keluhan perdarahan, demam, nyeri, BAK/BAB, dan laktasi) dan obyektif (vital, TFU, lochea, luka perineum, payudara).

No.	Komponen	Isi
		3. Menilai kemampuan peserta dalam melakukan diagnosis mengucapkan "nifas hari ke-5 dengan perdarahan sekunder, infeksi nifas dan mastitis kiri" 4. Menilai kemampuan peserta dalam melakukan perawtan perineum, kompres hangat payudara 5. Menilai kemampuan peserta dalam KIE tanda bahaya nifas dan kapan rencana rujukan 6. Menilai kemampuan peserta dalam melakukan dokumentasi SOAP di lembar jawaban 7. Monitor perilaku profesional peserta. 8. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	**Hal-hal yang perlu dicantumkan diantaranya:** Peran Ibu nifas hari ke-5 dengan ekspresi lelah, cemas, lemah, dan memegang perut, serta menjawab pertanyaan ini : 1. Perdarahan: "Ganti pembalut tiap 2 jam, bau amis" 2. Demam: "Sore-malam 2 hari ini, badan lemas" 3. Nyeri: "Perut bawah dan payudara kiri nyeri" 4. BAK/BAB: "BAK tidak tuntas, BAB susah dan takut ngejan" 5. Menyusui: "Bayi susui kanan saja, kiri sakit"
10	*Setting station*	**Ruang Layanan Rawat Jalan Nifas (Puskesmas)** 1. Tempat tidur pasien dan KS (baju pasien) 2. Troli berisi APD, *vital signs* 3. KS berperan sebagai ibu pasien 4. Lembar jawab peserta (SOAP dan diagnosis) 5. Lembar observasi penguji 6. *Safety box* dan tempat sampah infeksius 7. Laboran **Tata letak ruang:** 1. Tempat tidur 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat

No.	Komponen	Isi
		7. Wastafel/*handrub* 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	**Peralatan:** 1. Sarung tangan steril 2. *Handrub/hand sanitizer* 3. Tensimeter, termometer dan stetoskop 4. Bengkok 5. Pengalas 6. Kassa steril 7. Lembar jawab peserta 8. Lembar jawab penguji **Peran laboran:** Merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Bdn. Fitriana Yuni Permana Sari, S,Tr.Keb., M.Keb
13	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). KEPMENKES RI Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan. Jakarta: Kemenkes RI 2. Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. (2020). Standar Profesi Bidan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI 3. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (2019). Pedoman pelayanan kesehatan masa nifas. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 4. Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. (2024). *Panduan Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) klinik. 5. Akbid Wijaya Husada Bogor. (2021). Panduan penyelenggaraan OSCE 2020-2021.

SOP EDUKASI DAN DEMONSTRASI ASUHAN KEBIDANAN KOMPLIKASI MASA NIFAS

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	**Tahap Pra interaksi**				
1	Mengecek catatan medis dan catatan kebidanan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. APD (sarung tangan steril dan *handrub/hand sanitizer)* b. *Vital signs* (tensimeter, termometer dan stetoskop) c. Bengkok d. Kassa steril e. Pengalas *f. Safety box*				
3	Mencuci tangan 6 langkah				
B	**Tahap Orientasi**				
4	Menyampaikan salam terapeutik dan perkenalan				
5	Mengecek identitas pasien, minimal nama dan tanggal lahir/umur secara aktif				
6	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
7	Memberi kesempatan bertanya				
8	Menjaga privasi dan kenyamanan ibu				
C	**Tahap Kerja (No. 9 s.d. 19: sistematis)**				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
9	Melakukan *hand hygiene*				
10	Menggunakan sarung tangan steril bila ada risiko kontak dengan cairan tubuh				
11	Melakukan pengkajian subyektif: a. Perdarahan (jumlah/ bau/ warna) b. Demam (onset/ durasi) c. Nyeri (lokasi dan skala) d. Eliminasi (BAK/ BAB) e. Laktasi (status menyusui)				
12	Melakukan pengkajian obyektif: a. *Vital signs* lengkap b. TFU/ tonus uterus c. Karakter lochea d. Inspeksi perineum e. Payudara (tanda infeksi)				
13	Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada ibu				
14	Mengatur posisi ibu dengan nyaman pada tempat tidur				
15	Mendemonstrasikan tindakan melakukan: a. Perawatan perineum b. Kompres hangat payudara c. Edukasi menyusui yang benar				
16	Menjelaskan tanda bahaya nifas dan merencanakan rujukan jika 3 tanda dari 5 ini muncul: a. Perdarahan sangat banyak, perdarahan yang tiba-tiba meningkat kembali, atau				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	keluarnya bekuan darah besar. b. Demam tinggi, menggigil, nyeri perut bawah hebat, atau lokia berbau busuk. c. Sakit kepala berat, gangguan penglihatan, nyeri epigastrium, atau tekanan darah meningkat d. Sesak napas tiba-tiba, nyeri dada, berdebar, atau salah satu tungkai bengkak, merah, dan nyeri e. Perubahan psikologis berat, seperti menangis terus-menerus, rasa putus asa, atau pikiran menyakiti diri sendiri maupun bayi.				
17	Meminta ibu mengulang kembali penjelasan yang sudah diberikan				
18	Merapikan pasien dan alat-alat yang digunakan				
19	Melepaskan sarung tangan dan melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
D	**Tahap Terminasi**				
20	Menyimpulkan kegiatan				
21	Mengevaluasi respons ibu secara subjektif dan objektif				
22	Memberikan *reinforcement* positif				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
23	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
24	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	**Tahap Dokumentasi**				
25	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi asuhan masa nifas, respons ibu, serta tindak lanjut				
F	**Penampilan Profesional**				
26	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

DOPS (*Does*)

PENERAPAN *DIRECT OBSERVATION OF PROCEDURAL SKILLS* (DOPS) PADA ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS DENGAN KOMPLIKASI

Komponen	Deskripsi	Nifas dengan Komplikasi
Metode penilaian	DOPS (*Direct Observation of Procedural Skills*) merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa prosedural mahasiswa dalam situasi klinik nyata di lahan praktik kebidanan, fokus pada satu keterampilan spesifik yang diamati secara terstruktur.	Pembimbing klinik mengamati secara langsung mahasiswa melakukan asuhan awal ibu nifas hari ke-5 dengan perdarahan sekunder, infeksi nifas, dan mastitis di poliklinik nifas atau ruang rawat jalan Puskesmas.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa mengintegrasikan PPI/ K3, pengkajian terfokus, diagnosis kebidanan, tindakan prosedural aman, KIE tanda	Mahasiswa dinilai tidak hanya hafal teori komplikasi nifas, tetapi mampu melakukan asuhan aman dan efektif

Komponen	Deskripsi	Nifas dengan Komplikasi
	bahaya, rencana rujukan, dokumentasi SOAP, dan profesionalisme dalam satu *encounter* klinik nifas komplikasi.	yang menyelamatkan nyawa ibu: deteksi 3 *red flags,* tindakan aseptik, dan rujukan tepat waktu.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemui di praktik kebidanan dan sesuai CPMK-1, 4, 6 (profesionalisme, deteksi dini komplikasi, triase/ rujukan).	Ibu S, 30 tahun G3P2A0, hari ke-5 nifas datang ke Puskesmas: demam 38,7°C sudah 2 hari, nyeri perut bawah, perdarahan masih banyak dan bau tidak sedap, payudara kiri merah, panas dan nyeri. Riwayat: kala II lama, KPP 18 jam, jahitan perineum II. TFU pusat lembek, lochea coklat berbau sedang-banyak, N:104×/mnt.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan asuhan nifas komplikasi secara utuh (15 menit): mulai salam terapeutik, *hand hygiene,* pengkajian S dan O, diagnosis, perawatan perineum aseptic, KIE 5 tanda bahaya, rujukan serta dokumentasi SOAP.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan *hand hygiene* 6 langkah dan memakai APD, pengkajian sistematis (perdarahan/ loclea, demam, nyeri, eliminasi, laktasi), diagnosis "nifas hari-5 dengan perdarahan sekunder, infeksi, dan mastitis", melakukan perawatan perineum aseptik, KIE 5P tanda bahaya dan rujukan SEGERA ke RS, serta menulis dokumentasi SOAP lengkap.
Aspek yang dinilai	8 domain kompetensi: PPI/ K3 (*hand hygiene,* APD, limbah), pengkajian S/O, diagnosis, tindakan prosedural, KIE dan rujukan, dokumentasi,	Pembimbing menilai: *hand hygiene* konsisten? Menggali keluhan dan melakukan pemeriksaan fisik? Diagnosis

Komponen	Deskripsi	Nifas dengan Komplikasi
	profesionalisme, menggunakan rubrik terstruktur bobot 10.	masalah? Teknik perawatan perineum aseptik? KIE 5 tanda bahaya dan 3 alasan merujuk? SOAP 7 unsur ditulis lengkap? Komunikasi dengan empati dan menjaga privasi?
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menggunakan *checklist* DOPS terstruktur untuk observasi objektif, fokus pada *safety first* (PPI/ K3), *accuracy diagnosis*, dan *timely referral* pada kasus berisiko tinggi.	Pembimbing fokus: Apakah mahasiswa mengenali 3 *red flags* (demam 38,7°C, subinvolusi, dan takikardia yang merupakan *sepsis risk*)? *Hand hygiene* sebelum perawatan perineum? Rujukan SEGERA disebut dengan alasan jelas? Ibu paham penjelasan?
Umpan balik	Umpan balik segera setelah observasi (5 menit), spesifik pada 3 kekuatan dan 2 area perbaikan, menggunakan bahasa positif dan *actionable.*	"Bagus sudah *hand hygiene* konsisten dan memberikan diagnosis 3 masalah tepat. Perlu tingkatkan urutan pengkajian sistematis (VS, TFU, lochea) dan sebut 3 alasan rujukan konkret (demam, subinvolusi, takikardia) agar ibu paham urgensi."
Keputusan penilaian	• Kompeten: ≥7,5/10, asuhan aman independen. • Supervisi: 5-7,4/10, perlu bimbingan terarah. • Remedial: <5/10 atau *critical fail* (PPI/diagnosis/rujukan=0).	• Kompeten: Asuhan lengkap, aman, rujukan tepat waktu. • Supervisi: Pengkajian/ tindakan parsial, masih perlu arahan. • Remedial: Tidak *hand hygiene*, tidak diagnosis,

Komponen	Deskripsi	Nifas dengan Komplikasi
		tidak rujuk dan dapat membahayakan ibu.
Makna dalam OBE	DOPS *level* "Does" (Miller) memberikan bukti autentik mahasiswa mampu asuhan nifas komplikasi secara independen di lahan praktik, bukan hanya teori/ simulasi.	CPMK-1, 4, 6 terbukti: Mahasiswa bukan hanya hafal komplikasi nifas, tapi menyelamatkan nyawa ibu melalui deteksi dini, tindakan aseptik, dan rujukan tepat waktu di situasi nyata.

Tabel 1. 1 PORTOFOLIO PADA ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS DENGAN KOMPLIKASI

Komponen	Deskripsi	Nifas dengan Komplikasi
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Portofolio memuat: • OSCE skor 8/10, • DOPS skor 7,5/10, • *case report* nifas komplikasi, • refleksi *patient safety*, dan • 3 umpan balik CI yang menunjukkan perkembangan dari "supervisi" ke "kompeten" dalam asuhan nifas.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa menunjukkan perkembangan dari OSCE minggu 1 skor 6/10 (remediasi) menjadi DOPS minggu 4 skor 8,5/10 (kompeten) setelah perbaikan PPI/ K3 dan diagnosis.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di lab dan performa nyata di lahan praktik.	• OSCE**:** Skor 8/10 (unggul di pengkajian O, lemah dokumentasi). • DOPS**:** Skor 7,5/10 (perawatan perineum aseptik sudah baik, KIE perlu lebih tegas rujukan).

Komponen	Deskripsi	Nifas dengan Komplikasi
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus pasien yang ditangani, data penting, masalah prioritas, intervensi, dan hasil.	• Ibu S, 30 tahun G3P2A0 hari-5 nifas: demam 38,7°C, perdarahan banyak dan berbau, payudara kiri mastitis. • Dx: perdarahan sekunder, infeksi, dan mastitis. • Tindakan**:** perawatan perineum aseptik, rujuk RS. • Hasil**:** ibu paham 5 tanda bahaya.
Refleksi *patient safety*	Refleksi mengenali risiko keselamatan, analisis kesalahan potensial, langkah pencegahan.	Mahasiswa refleksi: risiko sepsis akibat subinvolusi dan demam tidak terdeteksi maka perlu dilakukan pencegahan dengan *hand hygiene* ketat dan rujukan <30 menit**.**
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari *Clinical Instructor* menjadi bukti pembinaan.	CI**:** "Bagus diagnosis 3 masalah dan perawatan aseptik. Perlu sebut 3 alasan rujukan konkret dan urutan pengkajian VS, TFU, lochea lebih sistematis."
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi bukti konsistensi performa.	Dari 3 kasus nifas (2 fisiologis, 1 komplikasi), mahasiswa konsisten unggul PPI/ K3 (skor rata-rata 2,8/3) dan meningkat tajam diagnosis (dari 1 ke 3).
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio menunjukkan performa terjaga pada berbagai kesempatan.	• OSCE lab (8/10) • DOPS Puskesmas (7,5/10) • *Case real* (8,5/10)**:** konsisten deteksi *red flags* dan komunikasi empati.
Makna dalam OBE	Bukti autentik capaian pembelajaran terlihat dalam performa berulang.	CPMK-1, 4, 6**:** Mahasiswa bukan hafal teori**,** tapi selamatkan ibu melalui asuhan aman di 3 *setting* berbeda.

Tabel 1. 2 CASE REPORT PADA ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS DENGAN KOMPLIKASI

Komponen	**Deskripsi**	**Nifas dengan Komplikasi**
Hakikat *case report*	*Case report* merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, *case report* berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Case Report: Ibu S, 30 tahun G3P2A0, hari-5 nifas ke Puskesmas: demam 38,7°C sudah 2 hari, perdarahan lochea coklat berbau sedang-banyak, tanda infeksi payudara kiri positif.
Tujuan	*Case report* bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Dokumentasi pengkajian S dan O, Dx 3 masalah, perawatan aseptic, rujukan RS dan evaluasi ibu paham 5 tanda bahaya.
Isi laporan	Isi *case report* biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	• S: Perdarahan pembalut per 2 jam dan bau amis, demam 38°C, nyeri perut bawah serta payudara kiri, BAK tidak tuntas. • O: N104x/menit, TFU pusat lembek, lochea berbau. • Dx: Perdarahan sekunder, infeksi, dan mastitis.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	CI nilai: Analisis 3 *red flags* dan rujukan tepat (skor 3/3), pengkajian sistematis VS, TFU, dan lochea (skor 2,5/3).

Komponen	Deskripsi	Nifas dengan Komplikasi
Nilai edukatif	*Case report* membantu mahasiswa mengembangkan *clinical reasoning*, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Mahasiswa belajar kala II lama dan KPP 18 jam yang memungkinkan terjadinya faktor resiko infeksi nifas dan TFU lembek serta lochea berbau yang mengindikasikan dilakukannya rujukan SEGERA.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, *case report* menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	CPMK-4 terbukti: Deteksi dini dan penanganan awal infeksi nifas berhasil mencegah sepsis

Tabel 1. 3 REFLEKSI PATIENT SAFETY PADA ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS DENGAN KOMPLIKASI

Komponen	Deskripsi	Nifas dengan Komplikasi
Hakikat refleksi *patient safety*	Refleksi *patient safety* merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Risiko utama: Sepsis nifas akibat demam 38,7°C, subinvolusi, dan lochea berbau tidak terdeteksi/ terlambat rujukan.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan.	Kesalahan fatal: Tidak *hand hygiene* akan menyebabkan infeksi silang; dan jika tidak dirujuk <30 menit akan menyebabkan syok septik.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Risiko: Subinvolusi mengakibatkan perdarahan yang dapat berlanjut pada syok hipovolemik; sedangkan mastitis akan berlanjut menjadi abses dan menyebabkan sepsis.

Komponen	Deskripsi	Nifas dengan Komplikasi
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	• Perdarahan sekunder berlanjut pada syok (TFU lembek dan lochea banyak). • Infeksi nifas menyebabkan sepsis (demam dan takikardia). • Mastitis menyebabkan abses payudara.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	• *Hand hygiene* 6 langkah sebelum perawatan perineum. • Rujukan <30 menit jika demam dan subinvolusi. • KIE 5 tanda bahaya dengan pasien dapat mengulangi penjelasan informasi yang disampaikan
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Pembelajaran: "Red flags nifas = rujukan MANDIRI". Praktik berikut: cek TFU setiap kunjungan dan hitung pembalut/ jam untuk deteksi dini.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi *patient safety* menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	CPMK-1: Mahasiswa bukan hanya lakukan tindakan, tapi berpikir risiko sehingga dapat cegah kematian ibu secara proaktif.

E. RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa masa nifas (6-8 minggu *postpartum*) adalah periode paling rentan terhadap kesakitan dan kematian ibu jika komplikasi tidak terdeteksi dini dan ditangani secara tepat waktu. Fokus utama asuhan kebidanan meliputi penerapan PPI/ K3 yang ketat, deteksi dini tiga komplikasi utama yaitu (1) perdarahan nifas (PPH primer-sekunder) melalui pendekatan 4T (*Tone/Trauma/Tissue/Thrombin*), (2) infeksi nifas (*puerperal sepsis*), dan (3) mastitis/ abses payudara, serta penatalaksanaan awal yang aman, triase dan rujukan efektif, serta edukasi tentang 5 tanda bahaya nifas (5P) untuk mencegah sepsis atau syok. Mahasiswa diwajibkan menerapkan CPMK-1 (profesionalisme/etika/PPI), CPMK-4 (deteksi infeksi/sepsis), dan CPMK-6 (triase/rujukan) secara terintegrasi.

Pengkajian pada ibu nifas tidak terbatas pada perdarahan atau lochea, melainkan mencakup data subjektif seperti frekuensi/ jumlah/ bau perdarahan, onset demam, nyeri perut bawah atau payudara, pola eliminasi BAK/ BAB, serta status laktasi. Data objektif berupa tanda vital, tinggi fundus uteri (TFU) dan tonus, karakteristik lochea (warna/ jumlah/ bau), kondisi luka perineum, serta tanda infeksi payudara. *Red flags* seperti TFU lembek, lochea berbau busuk, dan demam ≥38°C mengharuskan rujukan segera ke RS dalam waktu kurang dari 30 menit. Diagnosis prioritas yang ditemui adalah "nifas hari ke-5 dengan perdarahan sekunder, infeksi nifas, dan mastitis", yang dipicu oleh faktor risiko seperti kala II lama dan ketuban pecah lebih dari 18 jam.

Alur asuhan dimulai dengan *hand hygiene* 6 langkah dan penggunaan APD steril (sarung tangan steril), dilanjutkan pengkajian sistematis (*vital signs*, TFU, lochea, luka perineum, dan payudara), lalu penetapan diagnosis yang diikuti perawatan perineum secara aseptik (arah depan ke belakang), kompres hangat pada payudara, serta KIE tentang 5 tanda bahaya nifas (5P) dengan evaluasi pemahaman ibu melalui *teach-back*. Rujukan ke rumah sakit dilakukan dengan menyebutkan tiga alasan klinis konkret (demam, subinvolusi uterus, takikardia), diakhiri dengan dokumentasi SOAP lengkap (7 unsur). Evaluasi keberhasilan asuhan terlihat dari pemahaman ibu terhadap tanda bahaya, stabilitas hemodinamik sementara, dan pelaksanaan rujukan yang tepat waktu.

Tabel 1. 4 Red Flags & Eskalasi:

Red flags	**Makna klinis**	**Tindakan eskalasi**
Perdarahan lebih dari 2 pembalut/jam dan adanya bekuan besar	PPH sekunder/ sisa plasenta/ syok	Rujuk RS <15 menit
Demam ≥38°C, lochea berbau, dan TFU lembek	Infeksi nifas yang dapat berlanjut pada sepsis	Rujuk <30 menit dan monitor tanda vital
Payudara menunjukkan tanda infeksi dan badan demam	Mastitis berlanjut ke tahap abses	Kompres dan rujuk ke RS (bedah)
Takikardia dan bengkak kaki	Tromboemboli	Emergensi RS
Merasakan sedih berat dan ada pikiran bunuh diri	Depresi *postpartum*	Rujuk psikiater

Form Checklist

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	**Pernyataan**	**Sudah**	**Belum**	**Catatan**
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep komplikasi nifas (PPH/ Infeksi/ Mastitis)	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus S dan O nifas komplikasi	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa mengidentifikasi 3 *red flags* dan faktor risikonya (kala II lama/KPP)	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa memberikan diagnosis "perdarahan sekunder, infeksi, dan mastitis"	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa melakukan perawatan perineum aseptik dan kompres hangat payudara	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa melakukan KIE 5 tanda bahaya masa nifas dan *teach back* nya	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menyusun rencana rujukan dengan 3 alasan klinis	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
8	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi SOAP secara lengkap	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa berkomunikasi dengan empati dan menjaga privasi perineum dan payudara	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa melakukan *hand hygiene* 6 langkah dan memakai APD secara konsisten	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menentukan ekskalasi jika ≥ 3 *red flags*	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa bersikap professional (etika/ sistematis/ responsif)	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa melakukan evaluasi respons ibu dan terminasi kontrak	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa refleksi *patient safety* (risiko sepsis)	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

Bo, K., Bø, K., & Majida, M. (2013). Prevalence and risk factors of urinary incontinence during pregnancy and after childbirth. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 92(10), 1127–1132. https://doi.org/10.1111/aogs.12181

Candeloro, K., Collins, R., & Meyer, G. (2011). Risk of venous thromboembolism during the postpartum period: A systematic review. Thrombosis and Haemostasis, 105(3), 415–421. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21343773/

Chen, Y., Li, X., Wang, Y., & Zhang, S. (2024). The risk factors of postpartum urinary retention for women with vaginal delivery: A retrospective cohort study. International Journal of Obstetrics and Gynecology, 2024(1), 1–8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38970657/

International Confederation of Midwives. (2021). International definition of the midwife. International Confederation of Midwives. http://internationalmidwives.org

James, A. H., Blumenfeld, M. L., & Jamison, M. G. (2017). Venous thromboembolism in pregnancy and the postpartum period: Incidence, risk factors, and mortality. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 217(2), 159–166. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2017.12.012

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang standar profesi bidan. Kementerian Kesehatan RI. https://file.bbg.ac.id/cabinet/ministerial-regulation/2020/Kepmenkes-Nomor-320-Tahun-2020.pdf

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Kementerian Kesehatan RI. https://repository.kemkes.go.id/book/122

Liu, Y., Zhang, J., Li, H., & Wang, X. (2022). Risk factors and prognosis of acute lactation mastitis developing into breast abscess. PLOS ONE, 17(8), e0273967. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0273967

Nahum, J. C., Morales, E., Buekens, P., & Leal de Carvalho, F. (2008). Risk factors for postpartum hemorrhage in vaginal deliveries. AJOG Obstetrics & Gynecology, 198(2), 200–206. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2730945/

Souza, J. P., Gulmezoglu, A. M., Carroli, G., Lumbiganon, P., & Widmer, M. (2013). Use of the WHO partograph in reduction of postpartum hemorrhage. The

International Journal of Obstetrics & Gynecology, 122(2), 156–161. https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2013.03.013

Turawa, E. B., & Bello, A. O. (2014). Interventions for treating postpartum constipation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2014(9), CD011121. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10823348/

World Health Organization. (2022). WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989

World Health Organization. (2023). Postnatal care: WHO recommendations overview. Global Health Journal, 8(Suppl. 2), e010992. https://gh.bmj.com/content/8/Suppl_2/e010992

Worku, A., Tadesse, T., & Alemu, G. (2025). Risk factors for puerperal sepsis among postpartum women in Ethiopia: A cross-sectional study. BMC Infectious Diseases, 25(1), 123. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12254667/

BAB 2

PERDARAHAN POSTPARTUM: KLASIFIKASI, PENYEBAB (4T) DAN TINDAKAN AWAL DI PELAYANAN PRIMER

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan (PPI/K3) dalam pelayanan/asuhan masa nifas.	CPMK-1, CPMK-4, CPMK-6
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi interprofesional yang berpusat pada ibu dan keluarga.	CPMK-2, CPMK-6, CPMK-7
CPL-3	Menggunakan clinical reasoning dan evidence-based practice dalam pengambilan keputusan asuhan pada komplikasi nifas.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4
CPL-4	Melakukan pengkajian terfokus–komprehensif masa nifas (anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi tanda vital) untuk deteksi dini komplikasi.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5
CPL-5	Melaksanakan tindakan awal, stabilisasi dasar, dan menentukan kebutuhan rujukan pada komplikasi nifas.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-6
CPL-6	Melaksanakan edukasi, konseling, dukungan laktasi dan kesehatan mental, dokumentasi, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.	CPMK-5, CPMK-7, CPMK-1

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan prinsip profesionalisme, etika–legal, keselamatan (PPI/K3), dokumentasi, dan penggunaan pedoman/evidence dalam asuhan komplikasi nifas.
CPMK-2	Melakukan pengkajian terfokus ibu nifas dan menafsirkan tanda vital untuk menetapkan prioritas masalah serta rencana asuhan awal.
CPMK-3	Melaksanakan penatalaksanaan awal perdarahan postpartum dengan pendekatan 4T, stabilisasi, monitoring, dan keputusan rujukan sesuai algoritme.
CPMK-4	Melaksanakan deteksi dini serta penatalaksanaan awal infeksi masa nifas dan sepsis, termasuk pencegahan penyebaran dan evaluasi respons.
CPMK-5	Melaksanakan pengkajian dan penatalaksanaan awal gangguan laktasi (bendungan ASI, puting lecet, mastitis) serta koreksi teknik menyusui dan dukungan keluarga.
CPMK-6	Melakukan triase, stabilisasi pra-rujukan, dan komunikasi rujukan efektif untuk komplikasi nifas termasuk komplikasi sistemik.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Merancang dan melaksanakan edukasi, skrining kesehatan mental, konseling KB, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Perdarahan Postpartum: Klasifikasi, Penyebab (4T), dan Tindakan Awal di Pelayanan Primer	2.1 Menentukan klasifikasi perdarahan postpartum dan menelusuri penyebab dengan pendekatan 4T.	2.2 Menyusun dan menerapkan langkah tindakan awal serta monitoring sesuai algoritme di pelayanan primer.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-6

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Tes tertulis (MCQ/SAQ) + audit dokumentasi kasus	Kepatuhan item keselamatan (PPI/K3/identifikasi) pada checklist; kelengkapan dan ketepatan format dokumentasi klinis; kesesuaian keputusan dengan pedoman/evidence yang dirujuk	10	Lembar jawaban tes; lembar audit dokumentasi; daftar rujukan pedoman
CPMK-2	OSCE pengkajian + ujian kasus tertulis	Kelengkapan data kunci anamnesis–pemeriksaan fisik; akurasi interpretasi tanda vital; ketepatan penetapan prioritas masalah dan rencana awal	15	Checklist OSCE; jawaban kasus tertulis
CPMK-6	Simulasi pra-rujukan + role-play komunikasi SBAR + penilaian resume rujukan	Ketepatan triase dan stabilisasi pra-rujukan; kelengkapan komunikasi SBAR; kelengkapan resume rujukan (diagnosis kerja, tindakan, respons, rencana)	15	Checklist simulasi; rekaman/lembar penilaian SBAR; resume rujukan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Kepatuhan keselamatan pasien & PPI/K3	>2 langkah kritis terlewat; praktik berisiko; tidak konsisten menggunakan APD/hand hygiene	Langkah dasar dilakukan namun ada 1–2 kekeliruan/terlewat; perlu arahan	Langkah kritis terlaksana konsisten; hanya kekurangan minor	Proaktif mengidentifikasi risiko, melakukan mitigasi, dan mengedukasi; tanpa kekeliruan
1.2 Dokumentasi & penggunaan pedoman/evidence	Dokumentasi tidak runtut/tidak lengkap; rasional tidak jelas; rujukan tidak relevan	Dokumentasi cukup tetapi ada data kunci hilang; rasional masih lemah; rujukan terbatas	Dokumentasi lengkap dan jelas; rasional sesuai pedoman; rujukan relevan	Dokumentasi sangat lengkap untuk continuity; rasional kuat; rujukan pedoman mutakhir dan kontekstual

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Anamnesis terfokus & pemeriksaan fisik sistematis	Data tidak terarah; komponen penting banyak terlewat	Data utama terkumpul namun belum sistematis; beberapa komponen terlewat	Sistematis, lengkap, dan komunikatif; kekurangan minor	Sangat sistematis, menggali red flags, menyesuaikan prioritas, komunikasi sangat efektif
2.2 Interpretasi tanda vital & prioritisasi masalah	Salah menafsir tanda vital/red flags; prioritas tidak tepat	Menafsir sebagian benar; prioritas belum konsisten	Menafsir tepat; menetapkan prioritas masalah dan rencana awal dengan rasional	Menafsir sangat tepat (termasuk kewaspadaan dini); prioritas dan rencana monitoring jelas dan terukur

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Klasifikasi PPH & identifikasi 4T	Klasifikasi salah; penyebab tidak terpetakan	Klasifikasi cukup; 1–2 komponen 4T teridentifikasi	Klasifikasi tepat; 4T disaring lengkap; penyebab paling mungkin ditetapkan berbasis temuan	Analisis komprehensif (kemungkinan multipel); menyusun kebutuhan konfirmasi dan pemantauan lanjutan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.2 Tindakan awal–stabilisasi & monitoring	Urutan tindakan tidak sesuai; respons lambat; monitoring tidak terdokumentasi	Tindakan dasar dilakukan namun urutan/monitoring belum konsisten	Tindakan awal dan stabilisasi sesuai algoritme & kewenangan; monitoring dan keputusan rujukan tepat	Sangat cepat dan tepat; monitoring komprehensif; persiapan rujukan terkoordinasi dengan baik

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Identifikasi infeksi/sepsis & derajat kegawatan	Tanda bahaya tidak dikenali; penilaian derajat tidak dilakukan	Gejala umum dikenali, namun red flags/derajat belum lengkap	Tanda klinis kunci dikenali; derajat kegawatan dan diagnosis kerja tepat	Penilaian sangat tajam; memetakan risiko komplikasi dan rencana monitoring terukur
4.2 Tatalaksana awal & pencegahan penyebaran	PPI diabaikan; tatalaksana awal tidak sesuai	PPI sebagian; tatalaksana awal sebagian sesuai; monitoring terbatas	PPI konsisten; tatalaksana awal sesuai protokol/kewenangan; evaluasi respons dilakukan	Komprehensif; koordinasi kolaborasi/rujukan tepat; dokumentasi lengkap dan jelas

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Pengkajian masalah laktasi	Penilaian teknik menyusui tidak dilakukan; masalah tidak teridentifikasi	Penilaian dasar dilakukan namun belum lengkap; penyebab belum jelas	Pengkajian lengkap (ibu–bayi–teknik); penyebab utama tepat	Analisis menyeluruh termasuk faktor psikososial; prioritas masalah dan target perbaikan jelas
5.2 Koreksi teknik menyusui & konseling	Demonstrasi keliru/berisiko; konseling tidak jelas	Demonstrasi cukup tetapi masih ada kesalahan; konseling belum individual	Demonstrasi benar; konseling jelas; rencana tindak lanjut dan kriteria rujukan tepat	Coaching sangat efektif (teach-back); melibatkan keluarga; follow-up terstruktur dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Triase & stabilisasi pra-rujukan	Kegawatan tidak dikenali; stabilisasi tidak	Kegawatan dikenali sebagian;	Triase tepat; stabilisasi sesuai	Sangat cepat, antisipatif, dan terkoordinasi;

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
	tepat/tidak dilakukan	stabilisasi dasar ada namun belum lengkap	protokol/kewenangan; monitoring berkelanjutan	menyiapkan kebutuhan transport/alat secara optimal
6.2 Komunikasi rujukan & resume	Informasi kritis hilang; komunikasi tidak runtut; resume tidak lengkap	Komunikasi cukup runtut tetapi ada data kunci terlewat; resume perlu perbaikan	SBAR lengkap; resume rujukan jelas (tindakan, respons, rencana)	Closed-loop communication; memastikan penerimaan; rencana transport & rujukan balik terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Skrining kesehatan mental & tindak lanjut	Skrining tidak dilakukan; risiko krisis tidak dinilai	Skrining dilakukan terbatas; tindak lanjut belum jelas	Menggunakan instrumen tervalidasi; menilai risiko; dukungan awal dan rujukan sesuai	Komprehensif; safety plan jelas; pelibatan keluarga kuat; follow-up terjadwal dan terdokumentasi
7.2 Edukasi tanda bahaya/KB & continuity of care	Materi edukasi tidak lengkap; tanpa rencana tindak lanjut	Materi cukup namun belum disesuaikan; tindak lanjut umum	Materi lengkap dan terstruktur; metode sesuai; rencana follow-up jelas	Edukasi sangat efektif (teach-back + media); continuity of care rinci (kunjungan/telefollow-up/rujukan balik)

Perdarahan Postpartum: Klasifikasi, Penyebab (4t) Dan Tindakan Awal

A. Teori Dasar

Perdarahan postpartum (Postpartum Hemorrhage/PPH) merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa sekitar 25–30% kematian maternal berkaitan dengan perdarahan, terutama yang terjadi setelah persalinan. Bidan memiliki peran penting dalam mengenali tanda bahaya, melakukan stabilisasi awal, serta menyiapkan rujukan bila diperlukan. Pendekatan sistematis melalui konsep 4T membantu tenaga kesehatan mengidentifikasi penyebab perdarahan postpartum secara cepat sehingga intervensi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

Perdarahan postpartum (Postpartum Hemorrhage/PPH) merupakan salah satu komplikasi obstetri yang paling serius dan menjadi penyebab utama kematian ibu di berbagai negara, terutama di negara berkembang. Perdarahan postpartum

didefinisikan sebagai kehilangan darah yang berlebihan setelah persalinan yang dapat mengganggu kondisi hemodinamik ibu dan berpotensi menyebabkan syok hipovolemik apabila tidak segera ditangani. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) mendefinisikan perdarahan postpartum sebagai kehilangan darah sebanyak ≥500 ml setelah persalinan pervaginam atau ≥1000 ml setelah persalinan dengan operasi sesar, atau setiap kehilangan darah yang menyebabkan tanda-tanda ketidakstabilan hemodinamik pada ibu (WHO, 2017; WHO, 2023). Namun demikian, dalam praktik klinik kebidanan, penilaian perdarahan postpartum tidak hanya didasarkan pada estimasi jumlah darah yang keluar, karena pengukuran kehilangan darah secara akurat sering kali sulit dilakukan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan juga harus memperhatikan kondisi klinis ibu seperti penurunan tekanan darah, peningkatan frekuensi nadi, pucat, penurunan kesadaran, serta tanda-tanda syok hipovolemik sebagai indikator penting terjadinya perdarahan postpartum (Cunningham et al., 2022).

Perdarahan postpartum umumnya terjadi pada periode segera setelah kelahiran plasenta dan sering berkaitan dengan gangguan kontraksi uterus, retensi jaringan plasenta, trauma jalan lahir, atau gangguan pembekuan darah. Untuk mempermudah identifikasi penyebab perdarahan postpartum secara sistematis, digunakan pendekatan 4T, yaitu Tone, Tissue, Trauma, dan Thrombin. Pendekatan ini membantu tenaga kesehatan dalam menilai kemungkinan penyebab perdarahan secara cepat dan menentukan tindakan yang tepat (FIGO, 2022).

Secara epidemiologis, perdarahan postpartum merupakan penyebab sekitar 25–30% kematian maternal di seluruh dunia. Sebagian besar kematian tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui penanganan yang cepat dan tepat pada fase awal perdarahan. Oleh karena itu, kemampuan tenaga kesehatan, khususnya bidan di pelayanan kesehatan primer, dalam mengenali tanda awal perdarahan postpartum dan melakukan tindakan awal sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih berat (Say et al., 2014; WHO, 2023).

B. ETIOLOGI

Perdarahan postpartum dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi uterus, plasenta, jalan lahir, maupun sistem pembekuan darah. Untuk mempermudah identifikasi penyebab secara sistematis, dalam praktik obstetri digunakan pendekatan 4T, yaitu Tone, Tissue, Trauma, dan Thrombin. Pendekatan ini membantu tenaga kesehatan untuk melakukan evaluasi cepat terhadap penyebab perdarahan sehingga intervensi yang diberikan dapat lebih tepat dan efektif (Cunningham et al., 2022; FIGO, 2022).

1. Tone (Atonia Uteri)

   Atonia uteri merupakan penyebab paling sering dari perdarahan postpartum dan diperkirakan menyumbang sekitar 70–80% kasus perdarahan postpartum. Atonia uteri terjadi ketika uterus gagal berkontraksi secara adekuat setelah kelahiran plasenta sehingga pembuluh darah pada tempat implantasi plasenta tidak tertutup secara efektif (WHO, 2017). Secara fisiologis, setelah plasenta lahir, uterus berkontraksi untuk menekan pembuluh darah spiral yang sebelumnya memasok darah ke plasenta. Kontraksi ini merupakan mekanisme utama hemostasis fisiologis setelah persalinan. Apabila kontraksi uterus tidak adekuat, pembuluh darah tetap terbuka dan menyebabkan perdarahan yang terus berlangsung.

   Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya atonia uteri antara lain:

   a. Persalinan lama atau persalinan sangat cepat
   b. Uterus overdistensi (kehamilan ganda, polihidramnion, bayi besar)
   c. Multiparitas
   d. Infeksi intrauterin
   e. Induksi atau augmentasi persalinan dengan oksitosin
   f. Retensi plasenta.

2. Tissue (Retensi Jaringan Plasenta)

   Penyebab kedua dari perdarahan postpartum adalah retensi jaringan plasenta, yaitu kondisi ketika seluruh atau sebagian jaringan plasenta tertinggal di dalam uterus setelah persalinan. Retensi plasenta dapat menghambat kontraksi uterus sehingga perdarahan terus berlangsung.

   Retensi jaringan plasenta dapat terjadi akibat beberapa kondisi, seperti:

   a. Plasenta tidak lahir secara lengkap
   b. Adanya sisa lobus plasenta (succenturiate lobe)
   c. Plasenta akreta, inkreta, atau perkreta
   d. Adhesi plasenta yang abnormal pada dinding uterus

   Keberadaan jaringan plasenta yang tertinggal di dalam uterus menyebabkan uterus tidak dapat berkontraksi secara optimal dan mengganggu proses involusi uterus, sehingga meningkatkan risiko perdarahan postpartum.

3. Trauma (Trauma jalan lahir)

   Perdarahan postpartum juga dapat disebabkan oleh trauma pada jalan lahir, seperti robekan pada serviks, vagina, atau perineum. Trauma ini sering terjadi pada persalinan dengan intervensi atau persalinan yang berlangsung cepat.

   Beberapa jenis trauma jalan lahir yang dapat menyebabkan perdarahan postpartum antara lain:

a. Robekan serviks
b. Robekan vagina
c. Robekan perineum
d. Episiotomi yang luas
e. Ruptur uteri

Pada kasus trauma jalan lahir, uterus biasanya teraba berkontraksi baik, tetapi perdarahan tetap terjadi. Hal ini menjadi petunjuk klinis penting dalam membedakan perdarahan akibat trauma dengan perdarahan akibat atonia uteri.

4. Thrombin (Gangguan Koagulasi)

Penyebab lain dari perdarahan postpartum adalah gangguan pembekuan darah (koagulopati). Kondisi ini menyebabkan darah tidak dapat membeku secara normal sehingga perdarahan menjadi sulit dihentikan.

Gangguan koagulasi dapat terjadi pada beberapa kondisi, antara lain:

a. Preeklampsia berat atau eklampsia
b. Solusio plasenta
c. Infeksi berat (sepsis)
d. Disseminated intravascular coagulation (DIC)
e. Kelainan pembekuan darah yang sudah ada sebelumnya

Walaupun penyebab ini relatif lebih jarang dibandingkan dengan atonia uteri, gangguan koagulasi dapat menyebabkan perdarahan yang sangat berat dan memerlukan penanganan segera di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

C. KLASIFIKASI PERDARAHAN POSTPARTUM

Perdarahan postpartum dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu terjadinya perdarahan serta jumlah kehilangan darah. Klasifikasi ini penting dalam praktik klinik karena membantu tenaga kesehatan menentukan tingkat kegawatan serta tindakan penanganan yang diperlukan (Cunningham et al., 2022).

1. Klasifikasi berdasarkan Waktu Terjadinya

Berdasarkan waktu terjadinya, perdarahan postpartum dibagi menjadi dua jenis, yaitu perdarahan postpartum primer dan perdarahan postpartum sekunder.

a. Perdarahan Postpartum Primer

Perdarahan postpartum primer adalah perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan. Jenis perdarahan ini merupakan bentuk yang paling sering terjadi dan menyumbang sebagian besar kasus perdarahan postpartum.

Penyebab utama perdarahan postpartum primer umumnya berkaitan dengan konsep 4T, yaitu:

1) Tone (atonia uteri)
2) Tissue (retensi plasenta)
3) Trauma (robekan jalan lahir)
4) Thrombin (gangguan koagulasi)

Di antara penyebab tersebut, atonia uteri merupakan penyebab paling umum yang bertanggung jawab terhadap sebagian besar kasus perdarahan postpartum primer

b. Perdarahan Postpartum Sekunder

Perdarahan postpartum sekunder adalah perdarahan yang terjadi setelah 24 jam hingga 6 minggu setelah persalinan. Walaupun kejadian perdarahan postpartum sekunder lebih jarang dibandingkan dengan perdarahan postpartum primer, kondisi ini tetap memerlukan perhatian karena dapat menyebabkan morbiditas maternal yang signifikan.

Beberapa penyebab perdarahan postpartum sekunder antara lain:

1) Retensi sisa jaringan plasenta
2) Infeksi uterus (endometritis)
3) Subinvolusi uterus
4) Gangguan pembekuan darah

Pada kondisi ini, perdarahan biasanya muncul beberapa hari hingga beberapa minggu setelah persalinan dan dapat disertai dengan gejala lain seperti demam, nyeri perut, atau pengeluaran lokia yang tidak normal.

2. Klasifikasi Berdasarkan Derajat Kehilangan Darah

Selain berdasarkan waktu terjadinya, perdarahan postpartum juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah kehilangan darah. Klasifikasi ini membantu menentukan tingkat keparahan perdarahan serta tindakan penanganan yang diperlukan.

Secara umum, kehilangan darah pada perdarahan postpartum dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Perdarahan ringan : kehilangan darah sekitar 500–1000 ml
b. Perdarahan sedang : kehilangan darah sekitar 1000–1500 ml
c. Perdarahan berat : kehilangan darah lebih dari 1500 ml atau disertai tanda syok

Semakin besar jumlah kehilangan darah, semakin tinggi risiko terjadinya syok hipovolemik, yang dapat mengganggu perfusi jaringan dan menyebabkan kegagalan organ apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mampu mengenali tingkat keparahan perdarahan secara cepat dengan memperhatikan jumlah darah yang keluar serta kondisi klinis ibu, sehingga penanganan yang diberikan dapat dilakukan secara tepat dan cepat.

3. Berdasarkan kondisi klinis
   a. PPH Tanpa Syok
   b. PPH dengan Syok Hipovolemik, yang ditandai dengan:
      1) Nadi cepat (>100-110x/menit)
      2) Tekanan darah menurun
      3) Kulit pucat dan dingin
      4) Penurunan kesadaran

D. TANDA DAN GEJALA

Perdarahan postpartum merupakan kondisi kegawatdaruratan obstetri yang dapat berkembang dengan cepat dan membahayakan keselamatan ibu. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mampu mengenali tanda dan gejala perdarahan postpartum secara dini agar tindakan penanganan dapat segera dilakukan. Secara umum, tanda utama perdarahan postpartum adalah perdarahan pervaginam yang berlebihan setelah persalinan. Namun, dalam praktik klinik, penilaian tidak hanya didasarkan pada jumlah darah yang keluar, tetapi juga harus memperhatikan kondisi umum ibu serta perubahan tanda vital (Cunningham et al., 2022).

1. Tanda Klinis Awal

   Pada tahap awal, perdarahan postpartum biasanya ditandai dengan beberapa gejala berikut:
   a. Perdarahan pervaginam yang terus berlangsung atau dalam jumlah banya
   b. Uterus teraba lembek pada palpasi (pada kasus atonia uteri
   c. Tinggi fundus uteri meningkat atau tidak sesuai dengan waktu postpartum
   d. Pengeluaran bekuan darah dari vagina
   e. Ibu tampak lemah, pucat, atau berkeringat dingin
   f. Rasa pusing atau kepala terasa ringan

   Gejala tersebut sering menjadi tanda awal bahwa terjadi kehilangan darah yang cukup signifikan setelah persalinan.
2. Perubahan tanda Vital

   Seiring dengan bertambahnya jumlah kehilangan darah, akan terjadi perubahan pada tanda vital ibu sebagai respons tubuh terhadap penurunan volume darah. Perubahan tanda vital yang dapat ditemukan antara lain:
   a. Takikardia, yaitu peningkatan frekuensi nadi sebagai kompensasi terhadap kehilangan darah
   b. Hipotensi, yaitu penurunan tekanan darah akibat penurunan volume intravaskular
   c. Peningkatan frekuensi napas

d. Penurunan produksi urin (oliguria) akibat penurunan perfusi ginjal
   Perubahan tanda vital ini merupakan indikator penting yang menunjukkan bahwa kondisi ibu mulai mengalami gangguan hemodinamik.

3. Tanda Syok Hipovolemik
   Apabila perdarahan tidak segera ditangani, kondisi ibu dapat berkembang menjadi syok hipovolemik, yaitu keadaan ketika tubuh tidak mampu mempertahankan perfusi jaringan yang adekuat akibat kehilangan darah yang signifikan. Tanda-tanda syok hipovolemik meliputi:
   a. Tekanan darah sangat rendah
   b. Nadi cepat dan lemah
   c. Kulit pucat, dingin, dan lembap
   d. Penurunan kesadaran
   e. Produksi urin sangat sedikit atau tidak ada

   Syok hipovolemik merupakan kondisi kegawatdaruratan yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah terjadinya kegagalan organ dan kematian maternal.

4. Tanda Berdasarkan Penyebab (4T)
   Selain gejala umum, beberapa tanda klinis juga dapat memberikan petunjuk mengenai penyebab perdarahan postpartum berdasarkan konsep 4T.
   a. Tone (Atonia uteri)
      Uterus teraba lembek dan tidak berkontraksi dengan baik.
   b. Tissue (Retensi plasenta)
      Plasenta tidak lahir lengkap atau terdapat sisa jaringan plasenta.
   c. Trauma (Robekan jalan lahir)
      Uterus berkontraksi baik tetapi perdarahan tetap terjadi.
   d. Thrombin (Gangguan koagulasi)
      Perdarahan sulit berhenti dan darah tampak tidak membeku.

   Identifikasi tanda-tanda tersebut sangat membantu tenaga kesehatan dalam menentukan penyebab perdarahan postpartum serta menentukan tindakan penanganan yang tepat.

E. PEMERIKSAAN PENUNJANG

Pemeriksaan penunjang pada perdarahan postpartum bertujuan untuk menilai kondisi umum ibu, menentukan penyebab perdarahan, serta mengevaluasi dampak kehilangan darah terhadap fungsi organ tubuh. Pemeriksaan ini melengkapi hasil pemeriksaan klinis sehingga tenaga kesehatan dapat menentukan penatalaksanaan yang tepat (Cunningham et al., 2022). Dalam praktik kebidanan, pemeriksaan

penunjang pada perdarahan postpartum dapat meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan penunjang lain seperti ultrasonografi.

1. Pemeriksaan Klinis

   Pemeriksaan klinis merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menilai kondisi ibu dengan perdarahan postpartum. Pemeriksaan ini meliputi evaluasi keadaan umum ibu, tanda vital, serta pemeriksaan obstetri.

   Beberapa komponen pemeriksaan klinis yang perlu dilakukan antara lain:

   a. Penilaian keadaan umum ibu, termasuk tingkat kesadaran dan tanda-tanda syok
   b. Pemeriksaan tanda vital, seperti tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi napas, dan suhu tubuh
   c. Palpasi uterus, untuk menilai tonus uterus dan tinggi fundus uteri
   d. Pemeriksaan jalan lahir, untuk mendeteksi adanya robekan pada serviks, vagina, atau perineum
   e. Pemeriksaan plasenta, untuk memastikan bahwa plasenta telah lahir secara lengkap

   Pemeriksaan klinis ini sangat penting untuk membantu tenaga kesehatan menentukan kemungkinan penyebab perdarahan berdasarkan konsep 4T.

2. Pemeriksaan Laboratorium

   Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk menilai kondisi hematologis ibu serta mendeteksi kemungkinan gangguan pembekuan darah.

   Beberapa pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan antara lain:

   a. Pemeriksaan hemoglobin (Hb) dan hematokrit (Ht) untuk menilai derajat anemia akibat kehilangan darah
   b. Hitung trombosit, untuk menilai jumlah trombosit yang berperan dalam proses pembekuan darah
   c. Pemeriksaan waktu pembekuan darah, seperti prothrombin time (PT) dan activated partial thromboplastin time (aPTT)
   d. Pemeriksaan fibrinogen, terutama pada kasus yang dicurigai mengalami disseminated intravascular coagulation (DIC)

   Hasil pemeriksaan laboratorium membantu menentukan tingkat keparahan perdarahan serta kebutuhan transfusi darah.

3. Pemeriksaan USG

   Ultrasonografi (USG) dapat digunakan sebagai pemeriksaan tambahan untuk mendeteksi adanya retensi jaringan plasenta atau bekuan darah di dalam rongga uterus. Pemeriksaan ini sangat berguna terutama pada kasus perdarahan postpartum sekunder atau apabila terdapat kecurigaan sisa jaringan plasenta yang tertinggal. Selain itu, ultrasonografi juga dapat membantu mengevaluasi

kondisi uterus serta menyingkirkan kemungkinan komplikasi lain seperti hematoma pelvis.

4. Pemantauan Kondisi Ibu

   Selain pemeriksaan penunjang di atas, pemantauan kondisi ibu secara berkala juga sangat penting dalam penatalaksanaan perdarahan postpartum. Pemantauan ini meliputi:

   a. Evaluasi tanda vital secara berkala
   b. Pengukuran jumlah perdarahan
   c. Pemantauan produksi urin sebagai indikator perfusi ginjal
   d. Pemantauan respons ibu terhadap terapi yang diberikan

   Pemantauan yang ketat memungkinkan tenaga kesehatan untuk menilai perkembangan kondisi ibu serta menentukan apakah penanganan yang diberikan sudah efektif atau perlu dilakukan tindakan lanjutan.

F. KOMPLIKASI

Perdarahan postpartum merupakan kondisi kegawatdaruratan obstetri yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius apabila tidak segera ditangani. Kehilangan darah dalam jumlah besar dalam waktu singkat dapat mengganggu keseimbangan hemodinamik tubuh dan mempengaruhi fungsi organ vital. Oleh karena itu, penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi yang dapat mengancam keselamatan ibu (Cunningham et al., 2022). Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat perdarahan postpartum antara lain sebagai berikut.

1. Syok hipovolemik

   Syok hipovolemik merupakan komplikasi paling serius dari perdarahan postpartum. Kondisi ini terjadi akibat kehilangan darah yang signifikan sehingga volume darah dalam sirkulasi menurun dan menyebabkan penurunan perfusi jaringan. Pada kondisi syok hipovolemik, tubuh tidak mampu mempertahankan aliran darah yang adekuat ke organ vital seperti otak, jantung, dan ginjal. Gejala yang dapat muncul antara lain:

   a. Penurunan tekanan darah
   b. Nadi cepat dan lemah
   c. Kulit pucat, dingin, dan lembap
   d. Penurunan kesadaran
   e. Produksi urin menurun

   Apabila tidak segera ditangani, syok hipovolemik dapat berkembang menjadi kegagalan organ multipel dan kematian.

2. Anemia berat

   Kehilangan darah yang cukup banyak juga dapat menyebabkan anemia berat, yaitu kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah menurun secara signifikan. Anemia dapat menyebabkan ibu mengalami:

   a. Kelelahan yang berat
   b. Pusing atau sakit kepala
   c. Sesak napas
   d. Penurunan kemampuan tubuh untuk pulih setelah persalinan

   Anemia yang berat dapat memperlambat proses pemulihan ibu pada masa nifas dan meningkatkan risiko komplikasi lainnya.

3. Gangguan Koagulasi

   Perdarahan postpartum yang berat dapat memicu terjadinya gangguan pembekuan darah, salah satunya adalah disseminated intravascular coagulation (DIC). Pada kondisi ini, terjadi aktivasi sistem koagulasi secara luas di dalam pembuluh darah sehingga faktor pembekuan darah menjadi habis dan perdarahan semakin sulit dihentikan. Gangguan koagulasi dapat memperburuk kondisi perdarahan postpartum dan memerlukan penanganan intensif di fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas lengkap.

4. Kematian maternal

   Apabila perdarahan postpartum tidak ditangani secara adekuat, kondisi ini dapat berakhir pada kematian maternal. Secara global, perdarahan postpartum masih menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu, terutama di negara berkembang dengan akses pelayanan kesehatan yang terbatas (WHO, 2023). Sebagian besar kematian akibat perdarahan postpartum sebenarnya dapat dicegah melalui deteksi dini, penanganan yang cepat, serta sistem rujukan yang efektif.

G. PENGKAJIAN KLINIS TERFOKUS

Pengkajian klinis terfokus merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam menangani perdarahan postpartum. Pada kondisi ini, bidan dituntut untuk mampu melakukan pengkajian secara cepat, sistematis, dan tepat sasaran guna mengidentifikasi tingkat kegawatan, menentukan penyebab, serta menetapkan prioritas tindakan. Berbeda dengan pengkajian komprehensif, pengkajian pada kondisi kegawatdaruratan seperti perdarahan postpartum bersifat rapid assessment (penilaian cepat) dengan tetap mempertahankan ketepatan data klinis. Prinsip utama adalah "life-saving first, complete data later", yaitu menyelamatkan nyawa ibu menjadi prioritas utama sebelum melengkapi data lainnya.

1. Anamnesis Terfokus

   Anamnesis dilakukan secara singkat namun tetap terarah untuk mendapatkan informasi kunci yang mendukung penegakan masalah. Hal-hal yang perlu digali meliputi:

   a. Waktu terjadinya perdarahan, apakah segera setelah persalinan (mengarah ke PPH primer) atau beberapa waktu setelahnya (PPH sekunder)
   b. Jumlah dan karakter perdarahan, apakah banyak, terus-menerus, atau disertai bekuan
   c. Riwayat persalinan, termasuk lama persalinan, penggunaan induksi/augmentasi, dan cara persalinan
   d. Status plasenta, apakah sudah lahir dan apakah telah diperiksa kelengkapannya
   e. Faktor risiko, seperti multiparitas, bayi besar, atau riwayat perdarahan sebelumnya
   f. Keluhan penyerta, seperti pusing, lemah, sesak, atau penurunan kesadaran
2. Pemeriksaan Fisik Terfokus

   Pemeriksaan fisik bertujuan menilai kondisi umum ibu dan mendeteksi tanda kegawatan secara cepat. Fokus pemeriksaan meliputi:

   a. Kondisi umum dan kesadaran ibu, apakah tampak lemah, gelisah, atau menurun kesadarannya
   b. Tanda vital, terutama:
      Nadi meningkat sebagai tanda awal syok
      Tekanan darah menurun pada kondisi lanjut
      Frekuensi napas meningkat sebagai kompensasi
   c. Pemeriksaan uterus:
      Uterus lembek → mengarah ke atonia uteri
      Uterus keras → curiga penyebab lain seperti trauma
      Tinggi fundus uteri meningkat → kemungkinan sisa plasenta
   d. Evaluasi perdarahan, meliputi jumlah, warna, dan apakah masih aktif
   e. Inspeksi jalan lahir, untuk mendeteksi laserasi serviks, vagina, atau perineum
   f. Pemeriksaan plasenta, untuk memastikan kelengkapan jaringan
3. Identifikasi Tanda Bahaya

   Selama pengkajian, bidan harus waspada terhadap tanda-tanda kegawatan yang menunjukkan kondisi syok hipovolemik, antara lain:
   Nadi cepat (>100–110 x/menit)
   Tekanan darah menurun
   Kulit pucat, dingin, dan lembap
   Ibu tampak gelisah atau penurunan kesadaran

Perdarahan yang tidak berhenti

4. Penentuan Prioritas Masalah

   Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas masalah secara cepat dan tepat. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan:

   - Stabilitas kondisi ibu (apakah ada tanda syok)
   - Aktivitas perdarahan (masih berlangsung atau tidak)
   - Kemungkinan penyebab utama berdasarkan pendekatan 4T

   Sebagai contoh, uterus yang lembek dengan perdarahan aktif menunjukkan prioritas pada penanganan atonia uteri, sedangkan uterus yang keras dengan perdarahan tetap banyak mengarah pada kemungkinan trauma jalan lahir.

   Data yang diperoleh dari anamnesis dan pemeriksaan fisik terfokus tidak hanya digunakan untuk menilai kondisi umum ibu, tetapi juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi penyebab perdarahan postpartum. Informasi klinis tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan **4T (Tone, Tissue, Trauma, Thrombin)** untuk menentukan etiologi secara cepat dan tepat. Dengan demikian, pengkajian klinis berperan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan tindakan awal yang sesuai.

Tindakan Awal Perdarahan Postpartum di Pelayanan Primer

Tindakan awal pada perdarahan postpartum merupakan intervensi krusial yang harus dilakukan secara cepat, sistematis, dan tepat sesuai kewenangan di pelayanan primer. Tujuan utama penatalaksanaan awal adalah menghentikan perdarahan, mempertahankan stabilitas hemodinamik ibu, serta mencegah terjadinya syok dan komplikasi lebih lanjut. Dalam praktik, bidan harus mampu bertindak berdasarkan algoritme tanpa menunda keputusan, terutama dalam kondisi kegawatdaruratan.

Prinsip Dasar Penatalaksanaan

Penanganan perdarahan postpartum berlandaskan beberapa prinsip utama, yaitu:

- Respon cepat dan tepat, tanpa menunggu kondisi memburuk
- Pendekatan sistematis (ABC: Airway, Breathing, Circulation)
- Identifikasi penyebab menggunakan pendekatan 4T
- Stabilisasi kondisi ibu sebagai prioritas utama
- Persiapan rujukan sejak dini bila diperlukan

Langkah-langkah Tindakan Awal

Penatalaksanaan dilakukan secara berurutan dan simultan sesuai kondisi klinis ibu, meliputi:

1. Panggil bantuan dan siapkan rujukan
   Segera melibatkan tenaga kesehatan lain untuk mempercepat penanganan. Pada saat yang sama, bidan mulai mempertimbangkan kemungkinan rujukan jika kondisi tidak membaik.
2. Penilaian cepat ABC (Airway, Breathing, Circulation)
   - Pastikan jalan napas terbuka
   - Nilai pernapasan dan berikan oksigen bila tersedia
   - Evaluasi sirkulasi melalui nadi, tekanan darah, dan perfusi perifer
3. Pijat uterus (uterine massage)
   Dilakukan segera bila uterus teraba lembek untuk merangsang kontraksi dan mengurangi perdarahan. Ini merupakan tindakan utama pada atonia uteri.
4. Pemberian uterotonika
   Pemberian oksitosin atau uterotonika lain sesuai kewenangan bertujuan meningkatkan kontraksi uterus. Ini merupakan intervensi farmakologis utama dalam PPH akibat atonia.
5. Pemasangan infus dan terapi cairan
   - Pasang jalur intravena
   - Berikan cairan kristaloid (RL/NaCl) secara cepat
   - Bertujuan mempertahankan volume sirkulasi dan mencegah syok
6. Identifikasi penyebab dengan pendekatan 4T
   Dilakukan bersamaan dengan tindakan stabilisasi:
   Tone → uterus lembek
   Tissue → plasenta tidak lengkap
   Trauma → robekan jalan lahir
   Thrombin → gangguan pembekuan
7. Kompresi bimanual (bila diperlukan)
   Dilakukan jika perdarahan tidak berhenti setelah pijat uterus dan uterotonika, sebagai upaya sementara untuk mengurangi perdarahan.
8. Pengosongan kandung kemih
   Kandung kemih penuh dapat menghambat kontraksi uterus, sehingga perlu dikosongkan (spontan atau kateterisasi sesuai indikasi).
9. Monitoring ketat
   Dilakukan secara berkala untuk menilai respons terhadap terapi:
   - Tanda vital setiap 5–15 menit
   - Kontraksi uterus

- Jumlah perdarahan

10. Dokumentasi dan komunikasi rujukan (SBAR)
    Semua tindakan dan respons ibu harus didokumentasikan dengan baik. Bila dirujuk, gunakan komunikasi terstruktur (SBAR) agar kesinambungan asuhan terjaga.

Indikasi Rujukan

Sebelum melakukan rujukan, bidan harus memastikan bahwa kondisi ibu telah distabilisasi secara optimal, meliputi pemberian cairan, pemantauan tanda vital, serta tindakan awal sesuai kewenangan. Selain itu, komunikasi rujukan harus dilakukan secara efektif menggunakan metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) untuk menjamin kesinambungan asuhan. Dokumentasi rujukan harus mencakup kondisi ibu, tindakan yang telah dilakukan, serta respons terhadap terapi.

Rujukan harus dilakukan segera apabila:

- Perdarahan tidak dapat dikendalikan
- Terdapat tanda syok atau kondisi tidak stabil
- Dicurigai retensio plasenta atau sisa plasenta
- Ditemukan laserasi berat
- Terdapat gangguan koagulasi

AKTIVITAS 1 – *Knows How*

MINI – CASE

Seorang perempuan usia 29 tahun, G2P1A0, melahirkan secara spontan di Puskesmas sekitar 1 jam yang lalu. Setelah plasenta lahir, bidan mengamati adanya perdarahan yang cukup banyak dari jalan lahir. Ibu tampak lemah dan mengeluh pusing. Hasil pemeriksaan:

Keadaan umum lemah, TD 90/60 mmHg, nadi 112 x/menit, pernapasan 24 x/menit, suhu 36,7°C. Uterus teraba lembek dan tinggi fundus uteri berada di atas pusat. Plasenta telah lahir dan tampak lengkap. Perdarahan masih berlangsung dan darah tampak merah gelap dengan beberapa bekuan.

Pertanyaan Diskusi

1. Bagaimana klasifikasi perdarahan pada kasus di atas (berdasarkan waktu dan kondisi klinis)?
2. Data apa saja yang mendukung bahwa kasus ini merupakan kondisi kegawatdaruratan?
3. Berdasarkan pendekatan 4T, apa penyebab paling mungkin pada kasus ini? Jelaskan alasan Anda.
4. Tanda bahaya apa yang ditemukan pada ibu?
5. Tentukan prioritas masalah pada kasus ini.
6. Jelaskan langkah-langkah tindakan awal yang harus dilakukan di pelayanan primer.
7. Bagaimana rencana monitoring yang perlu dilakukan setelah tindakan awal?
8. Apakah kasus ini memerlukan rujukan? Jelaskan alasan klinisnya.
9. Informasi apa yang perlu disampaikan kepada ibu dan keluarga sebelum dilakukan rujukan?
10. Jelaskan alur pengambilan keputusan klinis pada kasus di atas berdasarkan kondisi ibu.

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Perdarahan Postpartum
3	Kasus	Perdarahan postpartum primer dengan tindakan awal di pelayanan primer
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta mampu melakukan penilaian dan tindakan awal pada kasus perdarahan postpartum di pelayanan kesehatan primer
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan berusia 29 tahun, G2P1A0, melahirkan bayi secara spontan di Puskesmas pada usia kehamilan 39 minggu. Bayi lahir dengan kondisi baik dan berat badan sekitar 3200 gram. Plasenta lahir sekitar 10 menit setelah bayi lahir dan tampak lengkap. Sekitar 15 menit setelah plasenta lahir, bidan memperhatikan bahwa darah terus keluar dari vagina dalam jumlah yang cukup banyak. Ibu tampak pucat dan mengeluh merasa pusing serta lemas.Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 100/60 mmHg, frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, dan suhu tubuh 36,8°C. Pada pemeriksaan abdomen, tinggi fundus uteri teraba setinggi pusat dan uterus terasa lembek saat dipalpasi. Perdarahan dari vagina masih berlangsung dan diperkirakan mencapai sekitar 700 ml TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai dengan kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai dengan kasus.

No.	Komponen	Isi
		3. Sampaikan diagnosis atau masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu atau keluarga terkait kondisi ibu dan rencana tindakan yang akan dilakukan
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS Jika peserta meminta data tambahan atau melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai, penguji dapat memberikan informasi berikut: 1. Uterus teraba lembek 2. Tinggi fundus uteri setinggi pusat 3. Plasenta lahir lengkap 4. Tidak ditemukan robekan besar pada jalan lahir Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi: 1. Menilai kondisi umum ibu dan tanda vital 2. Melakukan masase uterus 3. Memberikan uterotonika sesuai kewenangan 4. Memastikan kandung kemih kosong 5. Memasang infus cairan

No.	Komponen	Isi
		6. Melakukan pemantauan kondisi ibu 7. Menyiapkan kolaborasi atau rujukan apabila diperlukan INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu yang baru melahirkan sekitar 15 menit yang lalu di Puskesmas. 2. PS tampak **lemah, pucat, dan sedikit gelisah**, sesekali memegang perut bawah dan mengatakan merasa pusing. 3. PS tampak khawatir karena darah masih terus keluar dari vagina. 4. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, **PS merespons kooperatif**. 5. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, **PS tampak cemas tetapi bersedia mengikuti arahan bidan**.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia diperiksa? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu saat ini?

No.	Komponen	Isi
		PS: Saya merasa lemas dan pusing, Bu. Dari tadi darah masih keluar banyak. Peserta: Sejak kapan ibu merasa darah keluar banyak? PS: Sejak bayi saya lahir tadi, Bu. Setelah plasenta keluar, darah masih terus keluar. Peserta: Apakah ibu merasa nyeri di perut? PS: Iya, perut bagian bawah terasa tidak nyaman, Bu. Peserta: Apakah ibu merasa ingin pingsan atau sangat lemah? PS: Iya, saya merasa sangat lemas, Bu. Peserta: Ini persalinan yang ke berapa, Bu? PS: Ini persalinan kedua saya, Bu. Peserta: Apakah sebelumnya ibu pernah mengalami perdarahan setelah melahirkan? PS: Tidak pernah, Bu.

No.	Komponen	Isi
		Peserta: Ibu, saat ini terjadi perdarahan setelah persalinan sehingga perlu segera ditangani. PS: Baik, Bu. Tolong bantu saya ya. Peserta: Saya akan melakukan tindakan awal untuk menghentikan perdarahan dan memantau kondisi ibu. PS: Iya, Bu. Peserta: Jika diperlukan, ibu mungkin perlu dirujuk ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. PS: Baik, Bu. Saya mengikuti arahan bidan saja.. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan aktivitas harian (ADL), PS memberikan jawaban normatif dan tidak mengarah pada diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom abdomen postpartum / manekin abdomen untuk palpasi uterus -Phantom panggul/serviks untuk simulasi pemeriksaan jalan lahir -Lembar kasus perdarahan postpartum
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: -Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin sebelum dan sesudah ujian -Mengganti lembar kasus atau lembar instruksi bila diperlukan -Memastikan seluruh peralatan di setiap station siap digunakan oleh peserta berikutnya

No.	Komponen	Isi
		-Membantu memastikan cairan infus dummy dan alat simulasi dalam kondisi siap pakai
12	Kebutuhan alat	· Tempat tidur/periksa — 1 · Phantom abdomen postpartum/manekin palpasi uterus — 1 · Phantom panggul/serviks — 1 · Lembar kasus perdarahan postpartum — 1 set · Tensimeter — 1 · Stetoskop — 1 · Doppler/Pinard — 1 · Jam tangan/stopwatch — 1 · Termometer — 1 · Sarung tangan bersih — 1 pasang · Handrub — 1 botol · Kain penutup/selimut — 1 · Tisu — 1 pack · Infus set dummy — 1 set · Cairan RL/NaCl dummy — 1 · Abocath dummy — 1 · Obat uterotonika dummy (oksitosin) — 1 set · Formulir rujukan — 1 lembar · Lembar jawaban peserta — 1 lembar · Pena — 1
13	Penulis	Marleni, S.ST., Bdn., M.Tr. Keb
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. 3. World Health Organization. (2017). Managing complications in pregnancy and childbirth: A guide for midwives and doctors (2nd ed.).

No.	Komponen	Isi
		4. World Health Organization. (2023). WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum hemorrhage. 5. Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). Williams Obstetrics (26th ed.). McGraw-Hill Education. 6. International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO). (2022). FIGO recommendations on the management of postpartum hemorrhage. International Journal of Gynecology & Obstetrics

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Kegawatdaruratan Obstetri: Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus : Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal**
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam praktik klinik. Penilai mengamati tindakan mahasiswa secara langsung pada situasi klinik nyata, kemudian memberikan umpan balik segera setelah tindakan selesai. Domain yang umumnya dinilai meliputi informed consent, persiapan pra-tindakan, keterampilan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu postpartum dengan perdarahan, kemudian menilai keterampilan mahasiswa dalam melakukan tindakan awal seperti masase uterus, pemberian uterotonika, pemantauan kondisi ibu, serta persiapan rujukan.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan tindakan awal secara cepat, sistematis, dan aman pada kasus perdarahan postpartum dengan tetap mengutamakan keselamatan ibu. WHO menekankan pentingnya penanganan cepat dan efektif pada perdarahan postpartum untuk mencegah morbiditas dan mortalitas maternal..	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari pemahamannya tentang konsep perdarahan postpartum, tetapi juga dari kemampuannya mengenali tanda perdarahan, menilai kondisi ibu, melakukan stabilisasi awal, serta menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan..
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya	Seorang perempuan 29 tahun, G2P1A0, melahirkan bayi secara spontan di Puskesmas PONED pada usia kehamilan 39 minggu. Plasenta

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus : Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
	kemampuan mengenali tanda perdarahan postpartum, melakukan tindakan awal, serta menentukan kebutuhan rujukan. WHO menempatkan penanganan cepat dan pemberian uterotonika sebagai langkah penting dalam pengelolaan perdarahan postpartum.	lahir lengkap, tetapi 15 menit kemudian terjadi perdarahan sekitar 700 ml. Ibu tampak pucat dan lemas, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 110 kali per menit, dan uterus teraba lembek
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur klinik tertentu, bukan sekadar mendiskusikan kasus. Pada topik ini, keterampilan yang diamati meliputi penilaian kondisi ibu, pemeriksaan tanda vital, palpasi uterus, penilaian jumlah perdarahan, serta tindakan awal seperti masase uterus, pemberian uterotonika, pemasangan infus, dan pemantauan kondisi ibu. WHO juga menekankan pentingnya tindakan cepat seperti uterotonika, resusitasi cairan, serta identifikasi penyebab perdarahan berdasarkan konsep 4T.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu dan tanda vital, menilai tonus uterus dan jumlah perdarahan, menyimpulkan adanya perdarahan postpartum akibat kemungkinan atonia uteri, melakukan masase uterus, menyiapkan pemberian uterotonika, memasang infus cairan, dan menjelaskan perlunya pemantauan serta kemungkinan rujukan.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan meminta bantuan jika	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan perdarahan banyak, uterus lembek, dan tanda vital yang berubah sebagai tanda perdarahan postpartum serta

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus : Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
	diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme. Dalam konteks obstetri, aspek ini juga mencakup ketepatan mengenali penyebab perdarahan dan ketepatan tindakan awal.	mampu melakukan tindakan awal secara tepat.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal. Pada kasus perdarahan postpartum, WHO menekankan pentingnya penanganan cepat untuk mencegah syok hipovolemik.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu mengenali kondisi gawat secara cepat, melakukan masase uterus dengan benar, menyiapkan uterotonika, memasang infus cairan, memantau kondisi ibu, serta mempertimbangkan rujukan segera.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan selesai dan berisi hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik serta area yang perlu diperbaiki. Form DOPS biasanya juga memuat komentar assessor mengenai kekuatan mahasiswa dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan pengkajian awal, tetapi masih perlu meningkatkan kecepatan dalam mengenali tanda kegawatan atau ketelitian dalam memperkirakan jumlah perdarahan.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan didasarkan pada ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan pengambilan keputusan.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut dan aman. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila tidak mampu mengenali perdarahan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus : Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
		postpartum atau salah menentukan prioritas tindakan.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa telah mencapai capaian pembelajaran pada level does, karena performa diamati secara langsung saat melakukan tindakan klinik pada pasien nyata atau simulasi.	Pada kasus perdarahan postpartum, mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkan tindakan awal kegawatdaruratan obstetri secara langsung, cepat, aman, dan profesional di lahan praktik.

PORTOFOLIO

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Portofolio bukan hasil dari satu kali ujian saja
- Portofolio menunjukkan **bukti konsistensi kompetensi mahasiswa dari waktu ke waktu**

Tabel 2. 1 Portofolio pada Kegawatdaruratan Obstetri: Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus : Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik perdarahan postpartum, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian kondisi ibu postpartum, mengenali tanda perdarahan, menentukan kemungkinan penyebab berdasarkan konsep 4T, melakukan tindakan awal, serta

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus : Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
		memperbaiki performa berdasarkan umpan balik dari pembimbing.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik klinik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu bersalin dengan persalinan tidak maju, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI. Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu dengan perdarahan postpartum, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau Clinical Instructor (CI).
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan penanganan awal perdarahan postpartum di laboratorium keterampilan klinik. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan pengkajian ibu postpartum, melakukan masase uterus, menyiapkan uterotonika, dan mempersiapkan rujukan pada kasus perdarahan postpartum.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus seorang ibu G2P1A0 usia kehamilan 39 minggu yang mengalami perdarahan sekitar 700 ml setelah persalinan spontan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus : Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
		dengan uterus lembek. Mahasiswa mencatat data pemeriksaan, tindakan awal yang dilakukan seperti masase uterus dan pemasangan infus, serta keputusan rujukan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan	Mahasiswa merefleksikan pentingnya mengenali perdarahan postpartum secara dini, melakukan tindakan cepat seperti pemberian uterotonika, mencegah keterlambatan penanganan, serta pentingnya komunikasi dengan keluarga dan tim kesehatan dalam situasi kegawatdaruratan obstetri.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan pengkajian kondisi ibu dan melakukan masase uterus, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam memperkirakan jumlah perdarahan serta kecepatan dalam mengambil keputusan rujukan.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus perdarahan postpartum, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu mengenali tanda perdarahan postpartum dan melakukan tindakan awal secara aman.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus : Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik pembimbing, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan penilaian awal ibu postpartum, mengenali tanda kegawatan, serta melakukan tindakan awal yang tepat.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik perdarahan postpartum, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep teori, tetapi juga mampu menerapkan tindakan awal kegawatdaruratan obstetri secara langsung, aman, dan profesional di lahan praktik.

Tabel 2. 2 Case Report pada Kegawatdaruratan Obstetri: Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu postpartum yang mengalami perdarahan setelah persalinan dengan uterus lembek dan tanda awal gangguan hemodinamik.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
	mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, proses stabilisasi ibu, serta keputusan rujukan dan perkembangan kondisi ibu setelah intervensi awal.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini mahasiswa menuliskan keluhan perdarahan setelah persalinan, uterus teraba lembek, perkiraan perdarahan sekitar 700 ml, tekanan darah menurun, nadi meningkat, analisis perdarahan postpartum kemungkinan akibat atonia uteri, tindakan awal berupa masase uterus, pemberian uterotonika, pemasangan infus cairan, serta persiapan rujukan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan perdarahan yang banyak, uterus lembek, dan perubahan tanda vital sebagai tanda perdarahan postpartum yang memerlukan tindakan segera.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, serta kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah	Dari kasus perdarahan postpartum, mahasiswa belajar bahwa pengenalan dini tanda perdarahan, tindakan cepat, serta stabilisasi awal ibu sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih berat..

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep perdarahan postpartum, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh dan sistematis.

Tabel 2. 3 Refleksi Patient Safety pada Kegawatdaruratan Obstetri: Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus perdarahan postpartum, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali perdarahan setelah persalinan dapat menyebabkan syok hipovolemik dan membahayakan keselamatan ibu.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil seperti tidak memantau tonus uterus, tidak memperkirakan jumlah perdarahan, atau menunda tindakan dapat meningkatkan risiko komplikasi serius pada ibu.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah atonia uteri, syok hipovolemik, anemia berat, serta keterlambatan penanganan bila perdarahan tidak segera dikenali.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
	yang berpotensi membahayakan pasien.	mengenali perdarahan postpartum, tidak melakukan masase uterus segera, keterlambatan pemberian uterotonika, serta keterlambatan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pemantauan uterus secara berkala setelah persalinan, pemberian uterotonika sesuai protokol, pemantauan tanda vital, stabilisasi awal ibu, serta komunikasi cepat kepada keluarga dan tim kesehatan.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal tersebut akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada kasus perdarahan postpartum, deteksi dini, tindakan cepat, serta kemampuan mengambil keputusan rujukan merupakan bagian penting dari praktik kebidanan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan klinis, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko serta meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

H. RINGKASAN

Perdarahan postpartum merupakan salah satu kegawatdaruratan obstetri yang paling sering menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal di seluruh dunia. World Health Organization (WHO) mendefinisikan perdarahan postpartum sebagai kehilangan darah ≥500 ml setelah persalinan pervaginam atau ≥1000 ml setelah persalinan dengan operasi sesar, atau setiap kehilangan darah yang menyebabkan gangguan hemodinamik pada ibu. Kondisi ini memerlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk mencegah komplikasi yang lebih berat seperti syok hipovolemik, kegagalan organ, dan kematian maternal.

Secara klinis, penyebab perdarahan postpartum sering dirangkum dalam konsep 4T, yaitu Tone, Tissue, Trauma, dan Thrombin. Tone mengacu pada atonia uteri yang merupakan penyebab paling sering dari perdarahan postpartum. Tissue berkaitan dengan retensi jaringan plasenta atau sisa jaringan dalam uterus. Trauma meliputi robekan pada serviks, vagina, atau perineum, sedangkan Thrombin berkaitan dengan gangguan pembekuan darah. Pendekatan 4T membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi penyebab perdarahan secara cepat sehingga penanganan yang diberikan dapat lebih tepat.

Tanda klinis yang perlu diwaspadai pada perdarahan postpartum meliputi perdarahan pervaginam dalam jumlah banyak, uterus lembek pada palpasi, peningkatan tinggi fundus uteri, pucat, lemah, pusing, serta perubahan tanda vital seperti takikardia dan hipotensi. Kehilangan darah yang cepat dapat menyebabkan syok hipovolemik yang berpotensi mengancam keselamatan ibu.

Tindakan awal bidan di pelayanan kesehatan primer berfokus pada penilaian cepat kondisi ibu, identifikasi penyebab perdarahan, stabilisasi awal, serta persiapan rujukan bila diperlukan. Langkah penting meliputi menilai keadaan umum ibu, memeriksa tanda vital, memperkirakan jumlah perdarahan, melakukan palpasi uterus, melakukan masase uterus bila uterus lembek, memberikan uterotonika sesuai kewenangan, mengosongkan kandung kemih, memasang infus cairan, serta melakukan pemantauan kondisi ibu secara berkala.

Selain itu, bidan juga perlu melakukan komunikasi yang jelas kepada ibu dan keluarga mengenai kondisi yang terjadi serta rencana tindakan yang akan dilakukan. Apabila perdarahan tidak dapat dikendalikan di fasilitas pelayanan primer, maka bidan harus segera menyiapkan kolaborasi atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu. WHO menekankan bahwa keputusan rujukan harus dilakukan tanpa penundaan, dengan komunikasi yang baik kepada keluarga dan fasilitas kesehatan tujuan rujukan.

Alur Asuhan Singkat

Ibu postpartum dengan perdarahan → nilai cepat kondisi ibu dan tanda vital → identifikasi penyebab berdasarkan konsep **4T** → lakukan tindakan awal (masase uterus, uterotonika, infus cairan) → pantau kondisi ibu → tentukan kebutuhan kolaborasi atau rujukan → dokumentasi dan handover yang jelas.

Tabel 2. 4 Red Flags & Eskalasi

Red flags	**Makna klinis**	**Tindakan eskalasi**
Perdarahan >500 ml setelah persalinan	Mengarah pada perdarahan postpartum	Lakukan penilaian cepat dan tindakan awal
Uterus lembek pada palpasi	Kemungkinan atonia uteri	Lakukan masase uterus dan berikan uterotonika
Perdarahan terus berlangsung meskipun uterus berkontraksi	Curiga trauma jalan lahir atau sisa plasenta	Lakukan evaluasi lebih lanjut dan kolaborasi
Perdarahan disertai bekuan darah dan uterus tidak mengecil	Curiga retensi jaringan plasenta	Evaluasi uterus dan siapkan rujukan
Nadi >100 x/menit dan tekanan darah menurun	Tanda awal syok hipovolemik	Stabilisasi ibu, berikan cairan, dan siapkan rujukan
Ibu tampak pucat, lemas, atau pusing	Menunjukkan kehilangan darah signifikan	Pemantauan ketat dan stabilisasi segera
Perdarahan tidak berhenti setelah tindakan awal	Risiko komplikasi serius	Segera lakukan kolaborasi atau rujukan
Penurunan kesadaran atau tanda syok	Kegawatdaruratan maternal	Resusitasi awal dan rujukan emergensi

Form Checklist

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan definisi perdarahan postpartum	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan klasifikasi perdarahan postpartum	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menjelaskan konsep 4T pada perdarahan postpartum	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa melakukan anamnesis pada ibu postpartum dengan perdarahan	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengenali tanda dan gejala perdarahan postpartum	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa memperkirakan jumlah perdarahan secara klinis	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menilai tonus uterus melalui palpasi abdomen	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya ibu pada perdarahan postpartum	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa melakukan masase uterus dengan benar	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa memberikan uterotonika sesuai kewenangan	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menyiapkan pemasangan infus cairan	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa memantau kondisi ibu secara sistematis	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi ibu kepada keluarga	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menentukan kapan kasus harus dirujuk	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menyiapkan rujukan dan handover dengan jelas	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
16	Saya sudah bisa mendokumentasikan tindakan secara lengkap	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

BAB 3

RETENSIO PLASENTA DAN SISA PLASENTA: TANDA KLINIS, PENANGANAN AWAL, DAN RUJUKAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan (PPI/K3) dalam pelayanan/asuhan masa nifas.	CPMK-1, CPMK-4, CPMK-6
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi interprofesional yang berpusat pada ibu dan keluarga.	CPMK-2, CPMK-6, CPMK-7
CPL-3	Menggunakan clinical reasoning dan evidence-based practice dalam pengambilan keputusan asuhan pada komplikasi nifas.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4
CPL-4	Melakukan pengkajian terfokus–komprehensif masa nifas (anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi tanda vital) untuk deteksi dini komplikasi.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5
CPL-5	Melaksanakan tindakan awal, stabilisasi dasar, dan menentukan kebutuhan rujukan pada komplikasi nifas.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-6
CPL-6	Melaksanakan edukasi, konseling, dukungan laktasi dan kesehatan mental, dokumentasi, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.	CPMK-5, CPMK-7, CPMK-1

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan prinsip profesionalisme, etika–legal, keselamatan (PPI/K3), dokumentasi, dan penggunaan pedoman/evidence dalam asuhan komplikasi nifas.
CPMK-2	Melakukan pengkajian terfokus ibu nifas dan menafsirkan tanda vital untuk menetapkan prioritas masalah serta rencana asuhan awal.
CPMK-3	Melaksanakan penatalaksanaan awal perdarahan postpartum dengan pendekatan 4T, stabilisasi, monitoring, dan keputusan rujukan sesuai algoritme.
CPMK-4	Melaksanakan deteksi dini serta penatalaksanaan awal infeksi masa nifas dan sepsis, termasuk pencegahan penyebaran dan evaluasi respons.
CPMK-5	Melaksanakan pengkajian dan penatalaksanaan awal gangguan laktasi (bendungan ASI, puting lecet, mastitis) serta koreksi teknik menyusui dan dukungan keluarga.
CPMK-6	Melakukan triase, stabilisasi pra-rujukan, dan komunikasi rujukan efektif untuk komplikasi nifas termasuk komplikasi sistemik.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Merancang dan melaksanakan edukasi, skrining kesehatan mental, konseling KB, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Retensio Plasenta dan Sisa Plasenta: Tanda Klinis, Penanganan Awal, dan Rujukan	3.1 Mengidentifikasi tanda retensio/sisa plasenta serta risiko perdarahan dan infeksi.	3.2 Melaksanakan penanganan awal, persiapan, dan komunikasi rujukan sesuai kebutuhan.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-6

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSCE pengkajian + ujian kasus tertulis	Kelengkapan data kunci anamnesis–pemeriksaan fisik; akurasi interpretasi tanda vital; ketepatan penetapan prioritas masalah dan rencana awal	15	Checklist OSCE; jawaban kasus tertulis
CPMK-3	Simulasi/OSCE perdarahan postpartum + kuis algoritme	Akurasi klasifikasi PPH dan identifikasi 4T; ketepatan urutan tindakan awal–stabilisasi; ketepatan keputusan rujukan dan monitoring terdokumentasi	20	Checklist simulasi; log monitoring; jawaban kuis
CPMK-6	Simulasi pra-rujukan + role-play komunikasi SBAR + penilaian resume rujukan	Ketepatan triase dan stabilisasi pra-rujukan; kelengkapan komunikasi SBAR; kelengkapan resume rujukan (diagnosis kerja, tindakan, respons, rencana)	15	Checklist simulasi; rekaman/lembar penilaian SBAR; resume rujukan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Kepatuhan keselamatan pasien & PPI/K3	>2 langkah kritis terlewat; praktik berisiko; tidak konsisten menggunakan APD/hand hygiene	Langkah dasar dilakukan namun ada 1–2 kekeliruan/terlewat; perlu arahan	Langkah kritis terlaksana konsisten; hanya kekurangan minor	Proaktif mengidentifikasi risiko, melakukan mitigasi, dan mengedukasi; tanpa kekeliruan
1.2 Dokumentasi & penggunaan pedoman/evidence	Dokumentasi tidak runtut/tidak lengkap; rasional tidak jelas; rujukan tidak relevan	Dokumentasi cukup tetapi ada data kunci hilang; rasional masih lemah; rujukan terbatas	Dokumentasi lengkap dan jelas; rasional sesuai pedoman; rujukan relevan	Dokumentasi sangat lengkap untuk continuity; rasional kuat; rujukan pedoman mutakhir dan kontekstual

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Anamnesis terfokus & pemeriksaan fisik sistematis	Data tidak terarah; komponen penting banyak terlewat	Data utama terkumpul namun belum sistematis; beberapa komponen terlewat	Sistematis, lengkap, dan komunikatif; kekurangan minor	Sangat sistematis, menggali red flags, menyesuaikan prioritas, komunikasi sangat efektif
2.2 Interpretasi tanda vital & prioritisasi masalah	Salah menafsir tanda vital/red flags; prioritas tidak tepat	Menafsir sebagian benar; prioritas belum konsisten	Menafsir tepat; menetapkan prioritas masalah dan rencana awal dengan rasional	Menafsir sangat tepat (termasuk kewaspadaan dini); prioritas dan rencana monitoring jelas dan terukur

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Klasifikasi PPH & identifikasi 4T	Klasifikasi salah; penyebab tidak terpetakan	Klasifikasi cukup; 1–2 komponen 4T teridentifikasi	Klasifikasi tepat; 4T disaring lengkap; penyebab paling mungkin ditetapkan berbasis temuan	Analisis komprehensif (kemungkinan multipel); menyusun kebutuhan konfirmasi dan pemantauan lanjutan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.2 Tindakan awal–stabilisasi & monitoring	Urutan tindakan tidak sesuai; respons lambat; monitoring tidak terdokumentasi	Tindakan dasar dilakukan namun urutan/monitoring belum konsisten	Tindakan awal dan stabilisasi sesuai algoritme & kewenangan; monitoring dan keputusan rujukan tepat	Sangat cepat dan tepat; monitoring komprehensif; persiapan rujukan terkoordinasi dengan baik

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Identifikasi infeksi/sepsis & derajat kegawatan	Tanda bahaya tidak dikenali; penilaian derajat tidak dilakukan	Gejala umum dikenali, namun red flags/derajat belum lengkap	Tanda klinis kunci dikenali; derajat kegawatan dan diagnosis kerja tepat	Penilaian sangat tajam; memetakan risiko komplikasi dan rencana monitoring terukur
4.2 Tatalaksana awal & pencegahan penyebaran	PPI diabaikan; tatalaksana awal tidak sesuai	PPI sebagian; tatalaksana awal sebagian sesuai; monitoring terbatas	PPI konsisten; tatalaksana awal sesuai protokol/kewenangan; evaluasi respons dilakukan	Komprehensif; koordinasi kolaborasi/rujukan tepat; dokumentasi lengkap dan jelas

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Pengkajian masalah laktasi	Penilaian teknik menyusui tidak dilakukan; masalah tidak teridentifikasi	Penilaian dasar dilakukan namun belum lengkap; penyebab belum jelas	Pengkajian lengkap (ibu–bayi–teknik); penyebab utama tepat	Analisis menyeluruh termasuk faktor psikososial; prioritas masalah dan target perbaikan jelas
5.2 Koreksi teknik menyusui & konseling	Demonstrasi keliru/berisiko; konseling tidak jelas	Demonstrasi cukup tetapi masih ada kesalahan; konseling belum individual	Demonstrasi benar; konseling jelas; rencana tindak lanjut dan kriteria rujukan tepat	Coaching sangat efektif (teach-back); melibatkan keluarga; follow-up terstruktur dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Triase & stabilisasi pra-rujukan	Kegawatan tidak dikenali; stabilisasi tidak	Kegawatan dikenali sebagian;	Triase tepat; stabilisasi sesuai	Sangat cepat, antisipatif, dan terkoordinasi;

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
	tepat/tidak dilakukan	stabilisasi dasar ada namun belum lengkap	protokol/kewenangan; monitoring berkelanjutan	menyiapkan kebutuhan transport/alat secara optimal
6.2 Komunikasi rujukan & resume	Informasi kritis hilang; komunikasi tidak runtut; resume tidak lengkap	Komunikasi cukup runtut tetapi ada data kunci terlewat; resume perlu perbaikan	SBAR lengkap; resume rujukan jelas (tindakan, respons, rencana)	Closed-loop communication; memastikan penerimaan; rencana transport & rujukan balik terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Skrining kesehatan mental & tindak lanjut	Skrining tidak dilakukan; risiko krisis tidak dinilai	Skrining dilakukan terbatas; tindak lanjut belum jelas	Menggunakan instrumen tervalidasi; menilai risiko; dukungan awal dan rujukan sesuai	Komprehensif; safety plan jelas; pelibatan keluarga kuat; follow-up terjadwal dan terdokumentasi
7.2 Edukasi tanda bahaya/KB & continuity of care	Materi edukasi tidak lengkap; tanpa rencana tindak lanjut	Materi cukup namun belum disesuaikan; tindak lanjut umum	Materi lengkap dan terstruktur; metode sesuai; rencana follow-up jelas	Edukasi sangat efektif (teach-back + media); continuity of care rinci (kunjungan/telefollow-up/rujukan balik)

Pendahuluan

Komplikasi pada masa persalinan dan nifas masih menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kematian ibu di berbagai negara berkembang. Salah satu komplikasi yang sering terjadi pada kala III persalinan adalah retensio plasenta. Kondisi ini dapat menyebabkan perdarahan postpartum (postpartum hemorrhage/PPH) yang merupakan penyebab utama kematian maternal secara global (World Health Organization, 2022).

Retensio plasenta terjadi ketika plasenta tidak lahir secara spontan dalam waktu tertentu setelah bayi lahir. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus karena dapat berkembang menjadi keadaan darurat obstetri apabila tidak segera ditangani. Selain retensio plasenta, komplikasi lain yang dapat terjadi adalah sisa plasenta (retained placental tissue), yaitu tertinggalnya sebagian jaringan plasenta di dalam uterus setelah persalinan.

Penanganan yang tepat pada retensio plasenta sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti perdarahan postpartum, infeksi puerperal, hingga syok hipovolemik. Oleh karena itu tenaga kesehatan, termasuk bidan, harus memiliki kemampuan untuk mengenali tanda klinis, melakukan penanganan awal, serta menentukan indikasi rujukan secara tepat.

A. Definisi

1. Retensio Plasenta

   Retensio plasenta adalah kondisi dimana plasenta tidak lahir secara spontan setelah bayi lahir dalam waktu lebih dari 30 menit pada manajemen aktif kala III persalinan atau apabila terjadi perdarahan sebelum plasenta lahir (Perlman & Carusi, 2019).

   Retensio plasenta adalah kondisi dimana plasenta belum lahir dalam waktu ≥30 menit setelah bayi lahir, sedangkan sisa plasenta adalah bagian plasenta yang tertinggal dalam uterus setelah proses persalinan (Cunningham et al., 2022)

   Pada persalinan normal, plasenta biasanya lahir dalam waktu 5–30 menit setelah bayi lahir. Apabila plasenta tidak keluar dalam waktu tersebut, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai retensio plasenta.

   Retensio plasenta merupakan komplikasi yang relatif jarang tetapi berpotensi menimbulkan masalah serius. Insidens retensio plasenta dilaporkan berkisar antara 0,5–3% dari seluruh persalinan pervaginam (Favilli et al., 2021).
2. Sisa Plasenta

   Sisa plasenta merupakan kondisi ketika sebagian jaringan plasenta atau selaput ketuban tertinggal di dalam kavum uteri setelah proses persalinan selesai. Sisa plasenta dapat menyebabkan perdarahan postpartum sekunder, infeksi endometrium, serta subinvolusi uterus.

B. Etiologi

Etiologi retensio plasenta berkaitan dengan gangguan pada proses fisiologis pemisahan plasenta dari dinding uterus. Secara umum, penyebab retensio plasenta dapat dikelompokkan menjadi beberapa mekanisme utama.

1. Atonia uteri

   Atonia uteri merupakan penyebab paling umum retensio plasenta.. Kondisi dimana uterus gagal berkontraksi secara adekuat setelah persalinan sehingga plasenta tidak dapat terlepas secara fisiologis. Pada kondisi normal setelah bayi lahir, uterus berkontraksi kuat, Kontraksi menyebabkan pelepasan plasenta dari dinding uterus. Namun pada atonia Serabut otot uterus tidak berkontraksi

optimal, tidak terbentuk bidang pemisahan plasenta dan Plasenta tetap melekat. Yang menjadi penyebab Atonia adalah Overdistensi uterus (kehamilan kembar, polihidramnion), Persalinan lama, Kelelahan otot uterus, Penggunaan obat relaksan uterus. Atonia uteri merupakan penyebab paling umum retensio plasenta dan berhubungan langsung dengan perdarahan postpartum (Cunningham et al., 2022).

2. Perlekatan abnormal plasenta / Implantasi Abnormal Plasenta

   Kondisi dimana plasenta melekat secara abnormal pada dinding uterus akibat gangguan pembentukan desidua. Patofisiologinya adalah Tidak terbentuk lapisan desidua basalis secara normal, Vili korion menempel langsung atau menembus myometrium, Tidak ada bidang pemisahan fisiologis. Kondisi ini termasuk spektrum Plasenta akreta, Plasenta inkreta dan Plasenta perkreta . Implantasi abnormal plasenta disebabkan oleh Riwayat operasi uterus (misalnya *sectio caesarea)*, Kuretase berulang, Endometrium rusak. Sehingga pada Implantasi Abnormal Plasenta Implikasi Klinisnya Plasenta tidak dapat dilepaskan spontan, Perdarahan hebat saat pelepasan, sering memerlukan tindakan bedah. Implantasi abnormal merupakan penyebab retensio plasenta yang serius karena berisiko tinggi menyebabkan komplikasi berat (ACOG, 2022).

3. Plasenta terperangkap (*trapped placenta*) atau Obstruksi mekanik (serviks menutup dini)

   Pada kondisi ini, sebenarnya plasenta sudah terlepas dari dinding uterus, namun tidak dapat keluar karena adanya hambatan pada jalan lahir. Hambatan ini biasanya disebabkan oleh serviks yang menutup terlalu cepat atau mengalami spasme. Akibatnya, plasenta terperangkap di dalam kavum uteri. Secara klinis, kondisi ini ditandai dengan uterus yang sudah berkontraksi baik dan keras, tetapi plasenta tetap tidak keluar. Hal ini berbeda dengan atonia uteri, di mana uterus justru lembek. Penanganan pada kondisi ini biasanya memerlukan relaksasi serviks atau tindakan manual untuk mengeluarkan plasenta.

4. Sisa Plasenta (Retained Placental Tissue)

   Kondisi dimana sebagian jaringan plasenta atau selaput ketuban tertinggal di dalam uterus setelah persalinan. Pelepasan plasenta tidak lengkap, Fragmen plasenta tertinggal di kavum uteri sehingga menghambat kontraksi uterus. Sisa plasenta disebakan oleh Plasenta rapuh, Penanganan kala III yang tidak adekuat, Kelainan bentuk plasenta. Bila tidak ditangani dapat menyebabkan Perdarahan terus-menerus, Subinvolusi uterus dan Infeksi (endometritis). Sisa plasenta merupakan penyebab retensio yang sering terlambat dikenali dan dapat menyebabkan komplikasi infeksi.

5. Kesalahan manajemen aktif kala III

   Kala III merupakan fase yang sangat penting dan memerlukan keterampilan serta ketepatan tindakan, terutama dalam penerapan Manajemen Aktif Kala III (AMTSL). Kesalahan seperti tidak memberikan oksitosin segera setelah bayi lahir, melakukan penegangan tali pusat yang tidak tepat, atau menarik tali pusat sebelum plasenta terlepas dapat mengganggu proses pelepasan plasenta. Tindakan yang tidak sesuai prosedur ini dapat menyebabkan plasenta tidak terlepas dengan sempurna atau bahkan menimbulkan sisa plasenta di dalam uterus. *Menurut* World Health Organization, penerapan AMTSL yang benar terbukti efektif dalam mencegah retensio plasenta dan perdarahan postpartum.

   Secara keseluruhan, etiologi retensio plasenta bersifat multifaktorial, melibatkan gangguan kontraksi uterus, kelainan perlekatan plasenta, hambatan mekanik, serta faktor iatrogenik akibat kesalahan penatalaksanaan. Pemahaman yang komprehensif mengenai penyebab ini sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, agar dapat melakukan deteksi dini, pencegahan, serta penanganan yang tepat untuk mengurangi risiko komplikasi yang dapat mengancam jiwa ibu.

C. FAKTOR RISIKO

1. Faktor maternal
   a. Usia >35 tahun
   b. Paritas tinggi
   c. Riwayat retensio plasenta
2. Faktor obstetri
   a. Plasenta previa
   b. Preeklamsia
   c. Persalinan premature
3. Faktor iatrogenik:
   a. Induksi persalinan
   b. Penatalaksanaan kala III tidak sesuai standar

D. PATOFISIOLOGI

Retensio plasenta merupakan akibat dari kegagalan proses fisiologis kala III persalinan, yaitu pelepasan dan pengeluaran plasenta dari dinding uterus. Secara normal, setelah bayi lahir, uterus akan berkontraksi kuat sehingga plasenta terlepas secara spontan. Ketika mekanisme ini terganggu, maka terjadi retensio plasenta.

Menurut World Health Organization (2023), proses ini melibatkan interaksi kompleks antara kontraksi miometrium, struktur desidua, dan sistem vaskular uterus.

1. Uterus Tidak Berkontraksi Optimal

   Setelah bayi lahir, uterus seharusnya mengalami kontraksi kuat dan terkoordinasi. Kontraksi ini berfungsi untuk: Mengecilkan ukuran uterus , Menekan pembuluh darah, Membantu pelepasan plasenta, Jika kontraksi tidak adekuat: Tidak terjadi penurunan luas permukaan tempat implantasi plasenta, Plasenta tetap melekat pada dinding uterus, Tidak terbentuk gaya dorong untuk pengeluaran plasenta. Yang mana Mekanismenya Atonia menyebabkan serabut otot miometrium tidak mampu menjepit pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko perdarahan

2. Tidak Terbentuk Bidang Pemisahan (Failure of Separation Plane)

   Secara fisiologis, pelepasan plasenta terjadi di antara Desidua basalis (lapisan maternal) dan Lapisan spongiosa. Pada kondisi normal Terbentuk hematoma retroplasenta, Hematoma ini membantu "mengangkat" plasenta dari dinding uterus. Pada retensio plasenta Tidak terbentuk hematoma retroplasenta, Lapisan desidua tidak mengalami degenerasi sempurna, tidak ada "bidang pemisah". Akibatnya, plasenta tetap melekat kuat pada uterus.

3. Plasenta Tetap Melekat (*Abnormal Adherence*)

   Pada kondisi patologis tertentu, terjadi perlekatan abnormal plasenta, seperti: Plasenta akreta, Plasenta inkreta, Plasenta perkreta. Mekanisme: Vili korialis menembus lebih dalam ke myometrium, Tidak ada lapisan desidua yang memisahkan sehingga Plasenta tidak bisa lepas secara spontan, hal ini sering terjadi pada: Bekas operasi sesar, Kerusakan endometrium, Plasenta previa. Menurut International Federation of Gynecology and Obstetrics (2022), kondisi ini merupakan salah satu penyebab retensio plasenta yang paling berbahaya karena berisiko perdarahan masif.

4. Terjadi Perdarahan Karena Sinus Uterina Terbuka

   Saat plasenta belum terlepas namun sebagian pembuluh darah sudah terbuka: Sinus uterina (pembuluh darah besar di uterus) tidak tertutup, Tidak ada kontraksi yang menekan pembuluh tersebut akibatnya: Terjadi perdarahan aktif, darah keluar terus-menerus, Risiko syok hipovolemik meningkat. Secara fisiologis normal:

   Kontraksi uterus berfungsi seperti "ligasi alami" yang menutup pembuluh darah. Pada retensio plasenta Mekanisme ini gagal Pembuluh tetap terbuka sehingga terjadi perdarahan hebat. Pada sisa plasenta: Fragmen plasenta

tertinggal yang menghambat kontraksi uterus sehingga menyebabkan perdarahan berlanjut

E. KLASIFIKASI

1. Retensio plasenta:
   a. Plasenta adhesive
      Implantasi yang kuat dari jonjot korion plasenta sehingga menyebabkan kegagalan mekanisme separasi fisiologis
   b. Plasenta akreta
      Implantasi jonjot korion plasenta hingga memasuki sebagian lapisan miometrium.
   c. Plasenta inkreta
      Implantasi jonjot korion plasenta yang menembus lapisan otot hingga mencapai lapisan serosa dinding uterus.
   d. Plasenta perkreta
      Implantasi jonjot korion plasenta yang menembus lapisan serosa dinding uterus hingga ke peritonium
   e. Plasenta Inkarserata
      Tertahannya plasenta di dalam kavum uteri disebabkan oleh konstriksi ostium uteri
2. Sisa plasenta
   a. Parsial
   b. Total (jarang, biasanya retensio total)

F. TANDA DAN GEJALA

1. Retensio plasenta
   a. Plasenta tidak lahir >30 menit
   b. Perdarahan postpartum
   c. Uterus lembek
2. Sisa plasenta
   a. Perdarahan sekunder
   b. Lochia abnormal
   c. Subinvolusi uterus

G. PEMERIKSAAN PENUNJANG

1. USG

   USG dilakukan dengan tujuan Mengidentifikasi adanya sisa jaringan plasenta (*Retained Products of Conception/RPOC*), Menilai isi kavum uteri, Membantu menentukan tindakan (observasi vs evakuasi)
2. Pemeriksaan Laboratorium /Pemeriksaan Hematologi

   Hitung darah lengkap untuk menentukan tingkat hemoglobin (Hb) dan hematokrit (Hct), melihat adanya trombositopenia, serta jumlah leukosit. Pada keadaan yang disertai dengan infeksi, leukosit biasanya meningkat
3. Koagulasi

   Menentukan adanya gangguan koagulasi dengan hitung *Protrombin Time* (PT) dan *Activated Partial Tromboplastin Time* (APTT) atau yang sederhana dengan *Clotting Time* (CT) atau *Bleeding Time* (BT). Ini penting untuk menyingkirkan perdarahan yang disebabkan oleh faktor lain.

   Penelitian terbaru menunjukkan USG memiliki sensitivitas tinggi dalam mendeteksi *retained products of conception (RPOC).*

H. KOMPLIKASI

1. Perdarahan postpartum

   Pada kondisi retensio plasenta, plasenta yang tidak terlepas menyebabkan pembuluh darah pada tempat implantasi tetap terbuka. Secara normal, kontraksi uterus akan menutup pembuluh darah tersebut, tetapi pada retensio plasenta mekanisme ini gagal. Akibatnya, darah terus mengalir keluar dari uterus sehingga terjadi perdarahan yang dapat berlangsung cepat dan masif. Kehilangan darah yang tidak segera dihentikan akan menyebabkan penurunan kadar hemoglobin, penurunan volume sirkulasi, dan gangguan perfusi jaringan. Menurut World Health Organization, perdarahan postpartum merupakan penyebab utama kematian ibu di dunia, dan retensio plasenta menjadi salah satu faktor penyebab utamanya.
2. Syok hipovolemik

   Syok hipovolemik terjadi akibat kehilangan volume darah dalam jumlah besar sehingga tubuh tidak mampu mempertahankan perfusi organ vital. Pada tahap awal, tubuh akan mencoba mengompensasi dengan meningkatkan denyut jantung dan vasokonstriksi perifer. Namun, jika kehilangan darah berlanjut, mekanisme kompensasi ini akan gagal, sehingga tekanan darah menurun, aliran darah ke organ vital berkurang, dan fungsi organ mulai terganggu. Secara klinis, ibu akan tampak pucat, berkeringat dingin, nadi cepat dan lemah, serta

mengalami penurunan kesadaran. Tanpa penanganan segera, syok hipovolemik dapat berlanjut menjadi kegagalan organ dan kematian.

3. Infeksi puerperium

   Selain perdarahan, retensio plasenta juga berisiko menyebabkan infeksi puerperium, terutama jika terdapat sisa jaringan plasenta yang tertinggal di dalam uterus. Jaringan sisa tersebut menjadi media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri. Proses infeksi biasanya dimulai dari endometrium (endometritis), kemudian dapat menyebar ke jaringan sekitarnya. Secara klinis, infeksi puerperium ditandai dengan demam, nyeri perut bagian bawah, lochia yang berbau busuk, serta subinvolusi uterus. Infeksi ini dapat diperberat oleh tindakan yang tidak aseptik atau daya tahan tubuh ibu yang menurun setelah persalinan.

4. Sepsis

   Apabila infeksi tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi sepsis, yaitu respons sistemik tubuh terhadap infeksi yang menyebabkan disfungsi organ. Pada sepsis, bakteri atau toksin masuk ke dalam aliran darah dan memicu respons inflamasi yang luas. Hal ini menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah, termasuk vasodilatasi, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, serta penurunan tekanan darah. Akibatnya, perfusi organ menjadi tidak adekuat dan dapat terjadi kegagalan multi organ. Gejala sepsis meliputi demam tinggi atau hipotermia, denyut jantung cepat, napas cepat, serta penurunan kesadaran. Menurut International Federation of Gynecology and Obstetrics, sepsis postpartum merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu setelah perdarahan.

5. Kematian ibu

   Kematian biasanya merupakan akibat dari keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya, keterlambatan dalam memberikan penanganan, atau keterlambatan dalam merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Retensio plasenta yang tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan perdarahan masif yang berujung pada syok, atau infeksi berat yang berkembang menjadi sepsis. Kedua kondisi ini sama-sama dapat menyebabkan kegagalan organ vital dan akhirnya kematian.

   Secara keseluruhan, komplikasi retensio plasenta menunjukkan suatu rangkaian yang progresif, dimulai dari perdarahan atau infeksi lokal, kemudian berkembang menjadi gangguan sistemik, dan akhirnya berujung pada kondisi yang mengancam jiwa. Oleh karena itu, deteksi dini, penanganan cepat, dan rujukan tepat waktu sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat dan meningkatkan keselamatan ibu.

I. PENATALAKSANAAN

1. Penanganan awal:
   a. Stabilkan pasien

      Pada kondisi retensio plasenta, ibu berisiko mengalami perdarahan yang dapat menyebabkan gangguan sirkulasi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus segera melakukan penilaian kondisi umum ibu melalui pendekatan ABCDE (*Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure*). Jalan napas harus dipastikan terbuka, pernapasan dinilai adekuat, dan sirkulasi dievaluasi melalui pemeriksaan tekanan darah, nadi, serta tanda-tanda perfusi seperti warna kulit dan kesadaran. Ibu sebaiknya diposisikan dengan kaki sedikit ditinggikan untuk membantu aliran darah ke organ vital. Selain itu, pemantauan tanda vital harus dilakukan secara berkala untuk mendeteksi adanya perburukan kondisi, seperti tanda-tanda syok berupa nadi cepat, tekanan darah menurun, kulit dingin dan pucat, serta penurunan kesadaran. Menurut World Health Organization, stabilisasi kondisi pasien merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam penanganan kegawatdaruratan obstetri.

   b. Infus RL/NaCl

      Pemberian cairan intravena bertujuan untuk menggantikan kehilangan volume darah dan mempertahankan perfusi organ. Idealnya, dipasang satu hingga dua jalur infus dengan ukuran besar agar cairan dapat diberikan dengan cepat. Cairan diberikan secara bolus awal, kemudian dilanjutkan sesuai respons pasien. Selama pemberian cairan, tenaga kesehatan harus terus memantau tekanan darah, denyut nadi, serta produksi urin sebagai indikator kecukupan perfusi. Jika pasien tidak menunjukkan perbaikan, maka harus dipertimbangkan kemungkinan perdarahan masif dan kebutuhan transfusi darah. Resusitasi cairan yang cepat dan adekuat sangat penting untuk mencegah terjadinya syok hipovolemik

   c. Oksitosin 10 IU

      Oksitosin berfungsi untuk merangsang kontraksi otot uterus sehingga membantu proses pelepasan plasenta dan sekaligus menekan pembuluh darah di tempat implantasi untuk mengurangi perdarahan. Oksitosin dapat diberikan secara intramuskular atau intravena perlahan sesuai kondisi pasien. Setelah pemberian oksitosin, diharapkan uterus menjadi lebih keras dan kontraksi meningkat, sehingga plasenta dapat terlepas secara spontan. Selain itu, kontraksi uterus juga berperan sebagai mekanisme alami untuk menghentikan perdarahan. Jika respons terhadap oksitosin tidak adekuat, dapat dipertimbangkan pemberian uterotonik tambahan sesuai indikasi

2. Penanganan lanjutan atau definitif:
   a. Manual plasenta

      Manual plasenta merupakan tindakan utama pada retensio plasenta, yaitu pengeluaran plasenta secara manual dengan tangan melalui jalan lahir. Tindakan ini dilakukan apabila plasenta tidak lahir dalam waktu ≥30 menit setelah bayi lahir atau terjadi perdarahan aktif. Prosedur ini harus dilakukan dengan teknik aseptik yang ketat. Setelah pasien dipastikan dalam kondisi relatif stabil, tenaga kesehatan memasukkan tangan dominan ke dalam uterus melalui vagina sambil mengikuti tali pusat hingga mencapai lokasi plasenta. Tangan kemudian digunakan untuk memisahkan plasenta dari dinding uterus dengan gerakan menyapu secara perlahan, dimulai dari tepi plasenta hingga seluruh bagian terlepas. Setelah itu, plasenta dikeluarkan secara perlahan bersama dengan tangan.

      Secara fisiologis, tindakan ini menggantikan proses alami pelepasan plasenta yang gagal terjadi. Namun, prosedur ini memiliki risiko, seperti perdarahan, trauma uterus, dan infeksi, sehingga harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih.

      Menurut World Health Organization (2023), manual plasenta direkomendasikan sebagai tindakan utama pada retensio plasenta yang tidak dapat ditangani secara konservatif.

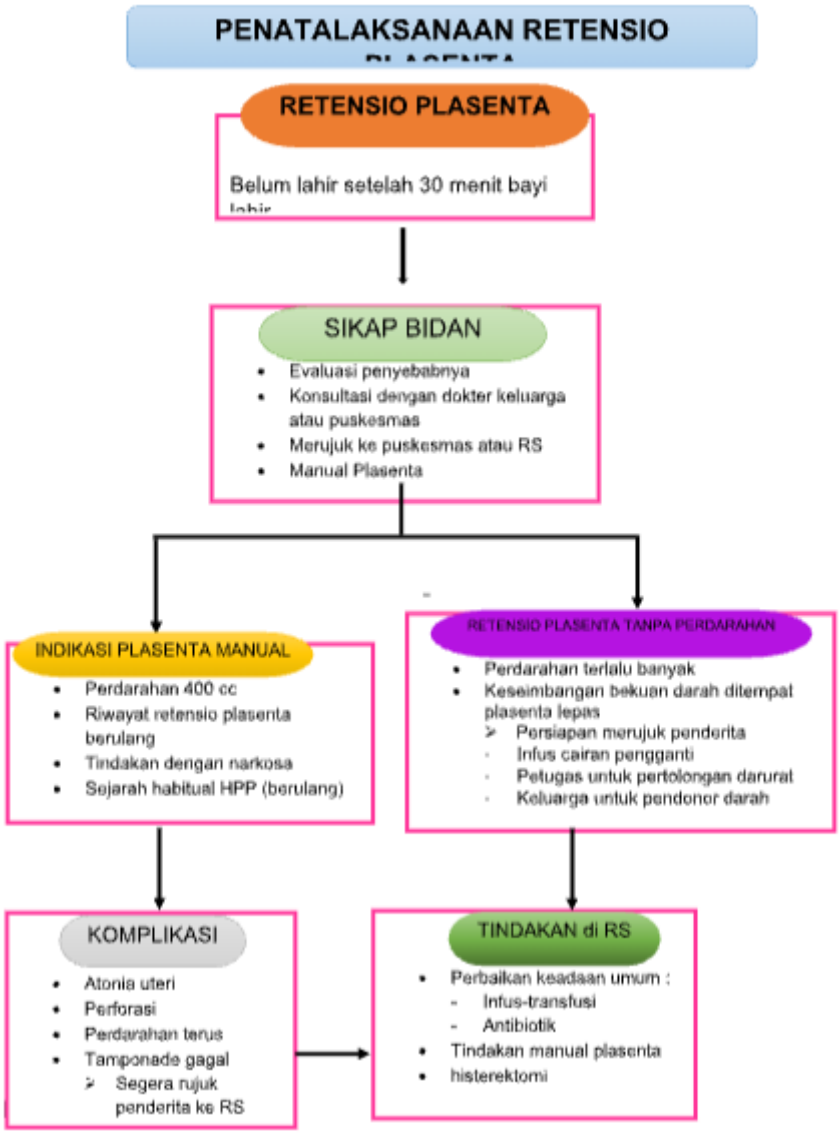
   b. Kuretase

      Kuretase adalah tindakan untuk mengeluarkan sisa jaringan plasenta yang tertinggal di dalam uterus menggunakan alat khusus (kuret atau vakum aspirasi). Tindakan ini biasanya dilakukan jika Diduga terdapat sisa plasenta setelah manual plasenta, Terjadi perdarahan postpartum sekunder, Hasil USG menunjukkan *retained products of conception* (RPOC). Secara patofisiologis, sisa jaringan plasenta yang tertinggal dapat menghambat kontraksi uterus dan menjadi sumber perdarahan serta infeksi. Oleh karena itu, evakuasi yang tuntas sangat penting. Namun, tindakan ini juga memiliki risiko seperti: Perforasi uterus, Infeksi, Sindrom Asherman (perlekatan intrauterin). Menurut *Royal College of Obstetricians and Gynaecologists*, evakuasi uterus harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan indikasi yang jelas untuk mencegah komplikasi.

   c. Antibiotik profilaksis

      Pemberian antibiotik profilaksis bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi puerperium, terutama setelah tindakan invasif seperti manual plasenta dan kuretase. Pada kondisi retensio plasenta, risiko infeksi meningkat karena: adanya jaringan plasenta yang tertinggal, Terbukanya jalan lahir, Prosedur

intrauterine. Antibiotik diberikan untuk mencegah kolonisasi dan pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan endometritis hingga sepsis.



Seorang ibu, usia 30 tahun, G2P1A0, melahirkan normal 35 menit yang lalu. Plasenta belum lahir. Terjadi perdarahan ±400 ml. Uterus teraba lembek.

Tugas

1. Apa diagnosis kasus di atas?
2. Apa penyebab yang paling mungkin?
3. Apa tindakan awal yang harus dilakukan?
4. Apa risiko komplikasi yang mungkin terjadi?
5. Kapan pasien harus dirujuk?

Tempalte SOAL OSCE

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Persalinan: Gadar
3	Kasus	Retensio Plasenta dengan tindakan awal dan rujukan
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan Obstetri 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, usia 26 tahun, G2P1A0, baru saja melahirkan bayi secara spontan di Puskesmas PONED. Bayi lahir 30 menit yang lalu, namun plasenta belum lahir. Ibu tampak lemah dan mengeluh pusing.. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: Actual mark (0/1/2/3)dan Global rating (1/2/3/4)

		3. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 4. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis → PS menjawab sesuai dialog 2. Jika peserta melakukan palpasi: - Uterus lembek - Tinggi fundus setinggi pusat 2. Jika peserta mengevaluasi plasenta: - Plasenta belum lahir (>30 menit) - Tindakan awal yang diharapkan: ▪ Menilai kondisi ibu (ABC) ▪ Menjelaskan kondisi secara singkat ▪ Memposisikan ibu dengan benar ▪ Memasang infus RL/NaCl ▪ Memberikan oksitosin 10 IU ▪ Memantau perdarahan ▪ Menyiapkan rujukan INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 6. PS berperan sebagai ibu inpartu kala III 7. PS tampak cemas, lelah, dan pusing karena plasenta belum lahir 8. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 9. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta:

		Peserta: Selamat pag, Bu PS: Pagi, Bu Peserta: Saya bidan A yang akan memeriksa ibu, apakah bersedia? PS: Iya, Bu Peserta: Apa keluhan ibu sekarang? PS: Plasenta saya belum keluar, Bu Peserta: Apakah ada perdarahan? PS: Iya, cukup banyak Peserta: Apakah ibu merasa pusing? PS: Iya, Bu, agak pusing Peserta: Ibu, plasenta belum keluar dan perlu penanganan segera PS: Baik, Bu Peserta: Saya akan melakukan tindakan awal dan mungkin akan merujuk ibu PS: Iya, Bu, saya ikut saja : Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dll memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	- Phantom uterus postpartum - Manekin panggul - Simulasi tali pusat
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa 1 2. Phantom abdomen uterus postpartum - 1 3. Phantom panggul/serviks — 1 4. Tensimeter — 1 5. Stetoskop — 1 6. Jam tangan/stopwatch — 1 7. Termometer — 1 8. Sarung tangan Panjang DTT – 1 Pasang 9.Kain penutup/selimut — 1 10. Infus set Dewasa — 1 set 11. Cairan RL/NaCl— 1 12. Abocath 16-18 — 1

		13. Formulir rujukan — 1 lembar 14. Nierbeken – 1 Buah 15. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 16. Pena — 1
13	Penulis	Bd. Teresia Hemelka, S.Tr.Keb., M.Keb
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pelayanan Kebidanan*. 2. Kemenkes RI (2022). *Pedoman Pelayanan Kebidanan*. 3. Manuaba, I.B.G. (2020). *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB*. EGC.

J. RANGKUMAN

Retensio plasenta adalah kondisi ketika plasenta tidak lahir dalam waktu ≥30 menit setelah bayi lahir, sedangkan sisa plasenta merupakan tertinggalnya sebagian jaringan plasenta di dalam uterus setelah persalinan.

Secara etiologi, retensio plasenta disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu kontraksi uterus yang tidak adekuat (atonia uteri), perlekatan abnormal plasenta (plasenta akreta spectrum), obstruksi mekanik seperti serviks yang menutup sebelum plasenta keluar, serta kesalahan dalam manajemen kala III persalinan. Faktor-faktor ini mengganggu mekanisme fisiologis pelepasan plasenta dari dinding uterus.

Retensio plasenta terjadi karena kegagalan uterus berkontraksi optimal sehingga tidak terbentuk bidang pemisahan antara plasenta dan dinding rahim..

Klasifikasi retensio plasenta meliputi plasenta adhesiva (perlekatan ringan), plasenta akreta (melekat hingga miometrium), plasenta inkreta (menembus miometrium), dan plasenta perkreta (menembus seluruh lapisan uterus hingga organ sekitar). Tingkat keparahan meningkat seiring dalamnya invasi plasenta.

Tanda dan gejala utama meliputi plasenta tidak lahir dalam waktu yang seharusnya, perdarahan postpartum, uterus lembek (pada atonia), serta tanda syok seperti pucat, nadi cepat, dan tekanan darah menurun bila perdarahan berat. Pada kasus sisa plasenta, gejala dapat muncul kemudian berupa perdarahan sekunder, lochia abnormal, demam, dan subinvolusi uterus.

Pemeriksaan penunjang yang penting antara lain ultrasonografi (USG), pemeriksaan hemoglobin (Hb) untuk menilai anemia, serta pemeriksaan koagulasi pada perdarahan berat untuk mendeteksi gangguan pembekuan darah.

Komplikasi retensio plasenta sangat serius, meliputi perdarahan postpartum, syok hipovolemik akibat kehilangan darah, infeksi puerperium, hingga sepsis. Jika

tidak ditangani secara cepat dan tepat, kondisi ini dapat berujung pada kematian ibu.

Penatalaksanaan dilakukan secara bertahap. Penanganan awal bertujuan menstabilkan kondisi ibu melalui penilaian cepat, pemasangan infus cairan, dan pemberian oksitosin untuk merangsang kontraksi uterus. Setelah kondisi stabil, dilakukan penanganan definitif berupa manual plasenta untuk mengeluarkan plasenta, kuretase jika terdapat sisa jaringan, serta pemberian antibiotik profilaksis untuk mencegah infeksi.

Referensi

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2022). *Placenta Accreta Spectrum*.

Cunningham, F.G., et al. (2022). *Williams Obstetrics, 26th Edition*. McGraw-Hill.

FIGO. (2022). *Guidelines for Postpartum Hemorrhage Management*.

International Federation of Gynecology and Obstetrics. (2022). *PPH Management*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pelayanan Kebidanan*.

Kemenkes RI (2022). *Pedoman Pelayanan Kebidanan*.

Manuaba, I.B.G. (2020). *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB*. EGC.

RCOG (2021). *Postpartum Hemorrhage Guidelines*.

Silver, R.M. (2019). Placenta Accreta Spectrum. *Obstetrics & Gynecology*.

Varney, H. (2021). *Varney's Midwifery*.

Weeks, A. (2015). The retained placenta. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*.

Weeks, A. (2022). *Retained Placenta: Pathophysiology and Management*.

World Health Organization. (2023). *WHO Recommendations for the Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage*.

BAB 4

LASERASI JALAN LAHIR DAN HEMATOMA: IDENTIFIKASI, PENATALAKSANAAN AWAL, DAN RUJUKANCAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan (PPI/K3) dalam pelayanan/asuhan masa nifas.	CPMK-1, CPMK-4, CPMK-6
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi interprofesional yang berpusat pada ibu dan keluarga.	CPMK-2, CPMK-6, CPMK-7
CPL-3	Menggunakan clinical reasoning dan evidence-based practice dalam pengambilan keputusan asuhan pada komplikasi nifas.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4
CPL-4	Melakukan pengkajian terfokus–komprehensif masa nifas (anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi tanda vital) untuk deteksi dini komplikasi.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5
CPL-5	Melaksanakan tindakan awal, stabilisasi dasar, dan menentukan kebutuhan rujukan pada komplikasi nifas.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-6
CPL-6	Melaksanakan edukasi, konseling, dukungan laktasi dan kesehatan mental, dokumentasi, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.	CPMK-5, CPMK-7, CPMK-1

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan prinsip profesionalisme, etika–legal, keselamatan (PPI/K3), dokumentasi, dan penggunaan pedoman/evidence dalam asuhan komplikasi nifas.
CPMK-2	Melakukan pengkajian terfokus ibu nifas dan menafsirkan tanda vital untuk menetapkan prioritas masalah serta rencana asuhan awal.
CPMK-3	Melaksanakan penatalaksanaan awal perdarahan postpartum dengan pendekatan 4T, stabilisasi, monitoring, dan keputusan rujukan sesuai algoritme.
CPMK-4	Melaksanakan deteksi dini serta penatalaksanaan awal infeksi masa nifas dan sepsis, termasuk pencegahan penyebaran dan evaluasi respons.
CPMK-5	Melaksanakan pengkajian dan penatalaksanaan awal gangguan laktasi (bendungan ASI, puting lecet, mastitis) serta koreksi teknik menyusui dan dukungan keluarga.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Melakukan triase, stabilisasi pra-rujukan, dan komunikasi rujukan efektif untuk komplikasi nifas termasuk komplikasi sistemik.
CPMK-7	Merancang dan melaksanakan edukasi, skrining kesehatan mental, konseling KB, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.

F. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Laserasi Jalan Lahir dan Hematoma: Identifikasi, Penatalaksanaan Awal, dan Rujukan	4.1 Mengidentifikasi laserasi jalan lahir/hematoma melalui inspeksi dan tanda klinis.	4.2 Menyusun tatalaksana awal, monitoring, dan keputusan rujukan berdasarkan kondisi klinis.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-6

G. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSCE pengkajian + ujian kasus tertulis	Kelengkapan data kunci anamnesis–pemeriksaan fisik; akurasi interpretasi tanda vital; ketepatan penetapan prioritas masalah dan rencana awal	15	Checklist OSCE; jawaban kasus tertulis
CPMK-3	Simulasi/OSCE perdarahan postpartum + kuis algoritme	Akurasi klasifikasi PPH dan identifikasi 4T; ketepatan urutan tindakan awal–stabilisasi; ketepatan keputusan rujukan dan monitoring terdokumentasi	20	Checklist simulasi; log monitoring; jawaban kuis
CPMK-6	Simulasi pra-rujukan + role-play komunikasi SBAR + penilaian resume rujukan	Ketepatan triase dan stabilisasi pra-rujukan; kelengkapan komunikasi SBAR; kelengkapan resume rujukan (diagnosis kerja, tindakan, respons, rencana)	15	Checklist simulasi; rekaman/lembar penilaian SBAR; resume rujukan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Kepatuhan keselamatan pasien & PPI/K3	>2 langkah kritis terlewat; praktik berisiko; tidak konsisten menggunakan APD/hand hygiene	Langkah dasar dilakukan namun ada 1–2 kekeliruan/terlewat; perlu arahan	Langkah kritis terlaksana konsisten; hanya kekurangan minor	Proaktif mengidentifikasi risiko, melakukan mitigasi, dan mengedukasi; tanpa kekeliruan
1.2 Dokumentasi & penggunaan pedoman/evidence	Dokumentasi tidak runtut/tidak lengkap; rasional tidak jelas; rujukan tidak relevan	Dokumentasi cukup tetapi ada data kunci hilang; rasional masih lemah; rujukan terbatas	Dokumentasi lengkap dan jelas; rasional sesuai pedoman; rujukan relevan	Dokumentasi sangat lengkap untuk continuity; rasional kuat; rujukan pedoman mutakhir dan kontekstual

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Anamnesis terfokus & pemeriksaan fisik sistematis	Data tidak terarah; komponen penting banyak terlewat	Data utama terkumpul namun belum sistematis; beberapa komponen terlewat	Sistematis, lengkap, dan komunikatif; kekurangan minor	Sangat sistematis, menggali red flags, menyesuaikan prioritas, komunikasi sangat efektif
2.2 Interpretasi tanda vital & prioritisasi masalah	Salah menafsir tanda vital/red flags; prioritas tidak tepat	Menafsir sebagian benar; prioritas belum konsisten	Menafsir tepat; menetapkan prioritas masalah dan rencana awal dengan rasional	Menafsir sangat tepat (termasuk kewaspadaan dini); prioritas dan rencana monitoring jelas dan terukur

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Klasifikasi PPH & identifikasi 4T	Klasifikasi salah; penyebab tidak terpetakan	Klasifikasi cukup; 1–2 komponen 4T teridentifikasi	Klasifikasi tepat; 4T disaring lengkap; penyebab paling mungkin ditetapkan berbasis temuan	Analisis komprehensif (kemungkinan multipel); menyusun kebutuhan konfirmasi dan pemantauan lanjutan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.2 Tindakan awal–stabilisasi & monitoring	Urutan tindakan tidak sesuai; respons lambat; monitoring tidak terdokumentasi	Tindakan dasar dilakukan namun urutan/monitoring belum konsisten	Tindakan awal dan stabilisasi sesuai algoritme & kewenangan; monitoring dan keputusan rujukan tepat	Sangat cepat dan tepat; monitoring komprehensif; persiapan rujukan terkoordinasi dengan baik

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Identifikasi infeksi/sepsis & derajat kegawatan	Tanda bahaya tidak dikenali; penilaian derajat tidak dilakukan	Gejala umum dikenali, namun red flags/derajat belum lengkap	Tanda klinis kunci dikenali; derajat kegawatan dan diagnosis kerja tepat	Penilaian sangat tajam; memetakan risiko komplikasi dan rencana monitoring terukur
4.2 Tatalaksana awal & pencegahan penyebaran	PPI diabaikan; tatalaksana awal tidak sesuai	PPI sebagian; tatalaksana awal sebagian sesuai; monitoring terbatas	PPI konsisten; tatalaksana awal sesuai protokol/kewenangan; evaluasi respons dilakukan	Komprehensif; koordinasi kolaborasi/rujukan tepat; dokumentasi lengkap dan jelas

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Pengkajian masalah laktasi	Penilaian teknik menyusui tidak dilakukan; masalah tidak teridentifikasi	Penilaian dasar dilakukan namun belum lengkap; penyebab belum jelas	Pengkajian lengkap (ibu–bayi–teknik); penyebab utama tepat	Analisis menyeluruh termasuk faktor psikososial; prioritas masalah dan target perbaikan jelas
5.2 Koreksi teknik menyusui & konseling	Demonstrasi keliru/berisiko; konseling tidak jelas	Demonstrasi cukup tetapi masih ada kesalahan; konseling belum individual	Demonstrasi benar; konseling jelas; rencana tindak lanjut dan kriteria rujukan tepat	Coaching sangat efektif (teach-back); melibatkan keluarga; follow-up terstruktur dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Triase & stabilisasi pra-rujukan	Kegawatan tidak dikenali; stabilisasi tidak	Kegawatan dikenali sebagian;	Triase tepat; stabilisasi sesuai	Sangat cepat, antisipatif, dan terkoordinasi;

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
	tepat/tidak dilakukan	stabilisasi dasar ada namun belum lengkap	protokol/kewenangan; monitoring berkelanjutan	menyiapkan kebutuhan transport/alat secara optimal
6.2 Komunikasi rujukan & resume	Informasi kritis hilang; komunikasi tidak runtut; resume tidak lengkap	Komunikasi cukup runtut tetapi ada data kunci terlewat; resume perlu perbaikan	SBAR lengkap; resume rujukan jelas (tindakan, respons, rencana)	Closed-loop communication; memastikan penerimaan; rencana transport & rujukan balik terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Skrining kesehatan mental & tindak lanjut	Skrining tidak dilakukan; risiko krisis tidak dinilai	Skrining dilakukan terbatas; tindak lanjut belum jelas	Menggunakan instrumen tervalidasi; menilai risiko; dukungan awal dan rujukan sesuai	Komprehensif; safety plan jelas; pelibatan keluarga kuat; follow-up terjadwal dan terdokumentasi
7.2 Edukasi tanda bahaya/KB & continuity of care	Materi edukasi tidak lengkap; tanpa rencana tindak lanjut	Materi cukup namun belum disesuaikan; tindak lanjut umum	Materi lengkap dan terstruktur; metode sesuai; rencana follow-up jelas	Edukasi sangat efektif (teach-back + media); continuity of care rinci (kunjungan/telefollow-up/rujukan balik)

A. Pendahuluan

Laserasi jalan lahir merupakan salah satu penyebab terjadinya perdarahan pascapersalinan. Perdarahan dalam keadaan dimana plasenta telah lahir lengkap dan kontraksi rahim baik, dapat dipastikan bahwa perdarahan tersebut berasal dari laserasi jalan lahir. Laserasi jalan lahir pada umumnya terjadi pada perineum yaitu yang terjadi pada garis tengah dan bisa menjadi luas apabila kepala janin lahir terlalu cepat

Selain itu, hematoma obstetri sebagai komplikasi trauma jaringan juga dapat menyebabkan perdarahan tersembunyi yang berbahaya jika tidak dikenali secara dini.

B. Definisi

1. Laserasi Jalan Lahir

   Laserasi jalan lahir adalah robekan pada serviks, vagina, atau perineum yang tidak segera diperbaiki. Laserasi jalan lahir Adalah robekan atau luka pada jalan lahir yang terjadi selama persalinan, terutama saat bayi melewati vagina. Laserasi ini dapat melibatkan perineum, vagina, serviks, atau bahkan area yang lebih dalam seperti otot dasar panggul.
2. Hematoma Obstetri

   Hematoma adalah pembengkakan jaringan yang berisi darah.

   Hematoma dapat muncul akibat pecahnya pembuluh darah secara tiba-tiba atau karena trauma. Bahaya utama hematoma meliputi kehilangan darah yang signifikan akibat perdarahan, anemia, dan infeksi.

C. Klasifikasi Laserasi

1. Berdasarkan Derajat
   - **Laserasi Derajat I**: Robekan pada mukosa vagina dan/ atau kulit perineum tanpa mengenai otot (Biasanya tidak memerlukan jahitan).
   - **Laserasi Derajat II**: Mengenai otot perineum tetapi tidak sampai ke sfingter ani (Biasanya membutuhkan jahitan untuk memperbaiki otot yang robek)
   - **Laserasi Derajat III**: Mengenai sfingter ani tetapi sampai ke mukosa rectum. Dibagi menjadi : 3A (Robekan < 50% sfingter ani eksternal), 3B (Robekan > 50% sfingter ani eksternal, 3C (Mengenai sfingter ani internal).
   - **Laserasi Derajat IV**: Robekan hingga mukosa rectum (Membutuhkan penjahitan dengan Teknik khusus untuk mencegah komplikasi seperti inkontinensia fekal).

   Penatalaksanaan berbeda sesuai derajat, Laserasi Jalan lahir terutama derajat III–IV yang memerlukan tindakan khusus dan rujukan.

D. Etiologi dan Faktor Risiko

1. Laserasi Jalan Lahir
   a. Faktor Maternal
      - Primigravida/ Paritas
      - Umur Ibu
      - Pinggul sempit
      - Jaringan perineum kaku
      - Riwayat laserasi sebelumnya

b. Faktor Janin
   - Berat badan bayi besar (Makrosomia)
   - Presentasi abnormal (Presentasi muka atau bokong)
   - Distosia Bahu
   - Posisi janin tidak optimal

c. Faktor Persalinan
   - Persalinan cepat (presipitatus/ eksplosif)
   - Ibu yang mengejan terus menerus tidak berhenti
   - Persalinan yang diselesaikan dengan tergesa-gesa dan dengan intervensi dorongan fundus yang berlebihan.
   - Kala II lama
   - Persalinan dengan alat (forceps/vakum)

2. Hematoma
   - Persalinan dengan prosedur bedah
   - Robekan yang tidak dijahit setelah pemberian anestesi lokal
   - Kegagalan menghentikan perdarahan sepenuhnya sebelum menjahit laserasi atau episiotomy
   - Pembuluh darah di atas puncak insisi atau laserasi yang tidak dibendung
   - Kegagalan menjahit pada titik tertentu.

E. Patofisiologi

1. Luka Jalan Lahir
   Tekanan kepala janin pada jalan lahir menyebabkan peregangan jaringan. Bila elastisitas tidak adekuat, terjadi robekan. Pada hematoma, pembuluh darah robek → darah terkumpul → meningkatkan tekanan jaringan → nyeri hebat dan risiko syok.
2. Hematoma
   Adanya pembuluh darah yang pepcah secara tiba-tiba atau karena terjadi trauma.

F. Manifestasi Klinis

1. Laserasi
   - Perdarahan segera setelah persalinan
   - Nyeri perineum
   - Luka terbuka pada jalan lahir
2. Hematoma
   - Nyeri hebat (tidak sesuai dengan jumlah perdarahan tampak)
   - Pembengkakan pada vulva/vagina

- Tanda syok jika besar

G. Identifikasi dan Diagnosis

1. Pemeriksaan
   - Inspeksi perineum, vagina, serviks
   - Evaluasi perdarahan
   - Palpasi adanya massa (hematoma)
   - Pemeriksaan tanda vital
2. Diagnosis Banding
   - Atonia uteri
   - Retensio plasenta
   - Koagulopati

H. Penatalaksanaan Awal

1. Prinsip Umum
   - Stabilkan kondisi ibu (ABC)
   - Identifikasi sumber perdarahan
   - Pencegahan infeksi
2. Penatalaksanaan Laserasi
   - **Derajat I–II**:
     - Observasi atau penjahitan jika perlu
   - **Derajat III–IV**:
     - Jahitan berlapis dengan teknik aseptik
     - Anestesi adekuat
     - Antibiotik profilaksis

   Penjahitan harus dilakukan per lapisan untuk mempercepat penyembuhan dan mengurangi komplikasi. Dilakukan manajemen nyeri, baik dengan obat maupun terapi non-farmakologis. Perawatan luka dilakukan dengan menjaga kebersihan dan menghindari tekanan berlebih pada area yang terluka.
3. Pentalaksanaan Hematoma

   Hematoma yang berukuran kecil atau sedang, mungkin akan terserap Kembali dengan sendirinya. Namun jika hematoma terus berkembang dan tidak stabil, perlu dilakukan kolaborasi dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut.
4. Penatalaksanaan Hematoma
   - **Kecil (<5 cm)**:
     - Observasi
     - Kompres dingin

- **Besar / progresif**:
  - Insisi dan evakuasi
  - Ligasi pembuluh darah
  - Transfusi bila perlu

5. Manajemen Nyeri dan Perawatan
   - Analgesik
   - Perawatan perineum
   - Teknik nonfarmakologi (relaksasi) dapat menurunkan nyeri postpartum

I. Pencegahan

- Pijat perineum selama kehamilan dengan usia kehamilan >34 minggu dengan minyak Virgin Coconut Oil (VCO)
- Teknik meneran yang benar
- Kontrol kala II persalinan
- Episiotomi selektif

J. Indikasi Rujukan

Rujukan harus segera dilakukan jika:

- Laserasi derajat III–IV
- Hematoma besar atau progresif
- Perdarahan tidak terkontrol
- Syok atau anemia berat
- Tidak tersedia fasilitas penanganan

K. Komplikasi

- Perdarahan postpartum
- Infeksi
- Disfungsi sfingter ani
- Nyeri kronis
- Gangguan seksual

Perawatan yang tidak adekuat meningkatkan risiko infeksi dan morbiditas ibu.

L. Peran Bidan

- Deteksi dini laserasi dan hematoma
- Penatalaksanaan awal sesuai kompetensi
- Edukasi ibu postpartum
- Edukasi kepada ibu hamil tentang teknik mengejan yang tepat

- Edukasi pentingnya senam hamil
- Dokumentasi SOAP
- Kolaborasi dan rujukan tepat waktu

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang perempuan, usia 29 tahun, G1P0A0, melahirkan spontan 4 jam yang lalu di Tempat Praktik Mandiri Bidan. Bayi lahir spontan dengan berat badan lahir 3800 gram. Hasil Pemeriksaan awal: keadaan umum baik, TD: 120/80 mmHg, Nadi: 88 x/menit, suhu: 36.8 ^{o}C, RR: 20 x/menit. Kontrasi uterus (+), Perdarahan ±. Setelah plasenta lahir, bidan menemukan adanya robekan pada perineum yang meluas hingga otot perineum namun tidak sampai ke arah sfingter ani. Pasien mengeluh nyeri hebat pada daerah perineum.

Pertanyaan diskusi:

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis anda?
3. Berdasarkan penyebab perdarahan pada ibu nifas, faktor mana yang paling mungkin menjadi penyebab utama?
4. Tanda bahaya apa yang mungkin terjadi jika tidak segera ditangani pada penyebab utama?
5. Apa tindakan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus ini?
6. Apakah kasus ini masih dapat ditangani post partum hemorrhage di fasilitas awal, atau perlu eskalasi/ rujukan? Jelaskan alasan anda.
7. Informasi penting apa yang harus disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga sebelum tindakan lanjutan atau rujukan?

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Post Partum: Hemorrhage
3	Kasus	Laserasi Jalan Lahir dan Hematoma dengan tindakan bidan sesuai kewenangan
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, usia 29 tahun, G1P0A0, melahirkan spontan 4 jam yang lalu di Tempat Praktik Mandiri Bidan. Bayi lahir spontan dengan berat badan lahir 3800 gram. Hasil Pemeriksaan awal: keadaan umum baik, TD: 120/80 mmHg, Nadi: 88 x/menit, suhu: 36.8 ^{o}C, RR: 20 x/menit. Kontrasi uterus (+), Perdarahan ±. Setelah plasenta lahir, bidan menemukan adanya robekan pada perineum yang meluas hingga otot perineum namun tidak sampai kea rah sfingter ani. Pasien mengeluh nyeri hebat pada daerah perineum. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana kolaborasi/rujukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut:

No.	Komponen	Isi
		a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi abdomen, penguji memberikan data: Kontraksi uterus (+) 3. Jika peserta menyatakan akan melakukan infeksi pada vagina, penguji memberikan data: Jumlah Perdarahan, Robekan jalan lahir hingga luas area yang mengalami robekan, 4. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi: Menilai ulang kondisi ibu secara cepat- Menjelakan kondisi ibu secara singkat dan jelas- Memposisikan ibu dengan posisi litotomi- Menyiapkan/ memasang infus cairan sesuai kewenangan dan fasilitas- Mempersiapkan *set hecting*- Melakukan pemantauan perdarahan dan tanda vital- Memberikan edukasi *personal hygienis* 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan Langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN

No.	Komponen	Isi
		1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 10. PS berperan sebagai ibu post partum dengan *post partum hemorrhage*. 11. PS tampak lemah, meringis menahan rasa sakit pada daerah perineum, dan berbicara terputus saat nyeri datang. 12. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 13. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dilakukan penghectingan, PS tampak ketakutan tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya merasakan sakit, Bu, alat kelamin bagian bawah saya terasa sakit sekali. Peserta: Sejak kapan ibu mengalami hal ini? PS: Sejak selesai bersalin, Bu. Peserta: Apakah ada keluar cairan/lendir dari alat kelamin ibu? PS: Iya, ada keluar cairan berwarna merah segar. Peserta: Apakah banyak yang keluar Bu? Ada satu duk/ softex penuh? PS: iya, satu duk penuh. Peserta: Ada nyeri di bagian perut ibu? PS: iya, Bu. Tapi sekali-sekali Peserta: Apakah saya bisa melihat daerah alat kelamin ibu? PS: Bisa, Bu.

No.	Komponen	Isi
		Peserta: Tolong ibu mengatur posisi dengan membuka kaki lebar-lebar ya. Peserta: iya, Bu PS: Saya melihat ada robekan di bagian perineum ibu, apakah ibu bersedia untuk saya meng*hecting*nya? Peserta: Apakah sakit Bu? PS: Tidak Bu, karena sebelum saya meng*hecting*, saya akan memberikan obat biusnya terlebih dahulu Peserta: Baik Bu, tolong bantu saya ya Bu. PS: Baik, Bu. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	- Phantom vulva vagina - Phantom *hecting*
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom Vulva vagina— 1 3. Phantom *hecting*— 1 4. *Set Hecting* — 1 5. Tensimeter — 1 6. Stetoskop — 1 7. Termometer — 1 8. Jam tangan/stopwatch — 1 9. Termometer — 1 10. Sarung tangan steril & bersih — 1 pasang 11. Perlak dan alas pemeriksaan— 1 12. Lampu/ senter pemeriksaan — 1 13. Kasa steril — 1 14. Larutan antiseptic (NaCl & Povidone Iodine) — 1

No.	Komponen	Isi
		15. Set infus — 1 set 16. Spuit & jarum suntik — 1 17. Hand sanitizer— 1 18. APD (masker, sarung tangan, apron) — 1 19. Tempat limbah medis — 1 20. Lembar Partograf Nifas — 1
13	Penulis	Bdn. Helena Fransysca, SST, M.Kes
14	Referensi	1. Yanti, Evi, dkk. 2025. Buku Asuhan Kebidanan Pada Persalinan Kala IV, Jakarta: Mahakarya Citra Utama 2. Lalita Elisabeth Machdalena F.,dkk. 2025. Asuhan Kebidanan Masa Nifas, Jawa Tengah: PT Media Pustaka Indo 3. Yunifitri Astri, Aulia Devy Lestari Nurul Aulia, Roza Nova. 2022. Pijat Perineum Untuk Mencegah Laserasi Jalan Lahir 4. Ashri Rizki Hallifah. 2023. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Robekan Jalan Lahir Pada Ibu Bersalin Di Klinik Alyssa Medika Periode Tahun 2023 5. Mirawati, Masdiputri Rr. Sri Nuriaty, Puteri Mahfuzhah Deswita. 2021. Analisis Determinan Kejadian Laserasi Jalan Lahir Pada Ibu Bersalin di Rs Islam Banjarmasin 6. Isfaroh Marida, Qomariyah, Angio Maya Cobalt. 2023. Pengaruh Pijat Perineum Menggunakan Minyak VCO (Virgin Coconut Oil) Terhadap Laserasi Jalan Lahir Pada Persalinan Normal 7. World Health Organization. *Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience* (2018) 8. Varney H dalam Philippi Julia, Gordon Ira Kantrowitz. *Varney's Midwifery. Seventh Edition* 9. Rahmi Aulia, Syapira Norol. 2025. Faktor Berhubungan Dengan Robekan Perineum Pada Persalinan Di Klinik Pratama ZamZam Banjarmasin 10. Yunifitri A, et al. (2022). Pijat Perineum Untuk Mencegah Laserasi Jalan Lahir

Referensi

Yanti, Evi, dkk. 2025. Buku Asuhan Kebidanan Pada Persalinan Kala IV, Jakarta: Mahakarya Citra Utama

Lalita Elisabeth Machdalena F.,dkk. 2025. Asuhan Kebidanan Masa Nifas, Jawa Tengah: PT Media Pustaka Indo

Yunifitri Astri, Aulia Devy Lestari Nurul Aulia, Roza Nova. 2022. Pijat Perineum Untuk Mencegah Laserasi Jalan Lahir

Ashri Rizki Hallifah. 2023. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Robekan Jalan Lahir Pada Ibu Bersalin Di Klinik Alyssa Medika Periode Tahun 2023

Mirawati, Masdiputri Rr. Sri Nuriaty, Puteri Mahfuzhah Deswita. 2021. Analisis Determinan Kejadian Laserasi Jalan Lahir Pada Ibu Bersalin di Rs Islam Banjarmasin

Isfaroh Marida, Qomariyah, Angio Maya Cobalt. 2023. Pengaruh Pijat Perineum Menggunakan Minyak VCO (Virgin Coconut Oil) Terhadap Laserasi Jalan Lahir Pada Persalinan Normal

World Health Organization. *Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience* (2018)

Varney H dalam Philippi Julia, Gordon Ira Kantrowitz. *Varney's Midwifery. Seventh Edition*

Rahmi Aulia, Syapira Norol. 2025. Faktor Berhubungan Dengan Robekan Perineum Pada Persalinan Di Klinik Pratama ZamZam Banjarmasin

Yunifitri A, et al. (2022). Pijat Perineum Untuk Mencegah Laserasi Jalan Lahir

BAB 5

INFEKSI MASA NIFAS: ENDOMETRITIS, INFEKSI LUKA, DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan (PPI/K3) dalam pelayanan/asuhan masa nifas.	CPMK-1, CPMK-4, CPMK-6
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi interprofesional yang berpusat pada ibu dan keluarga.	CPMK-2, CPMK-6, CPMK-7
CPL-3	Menggunakan clinical reasoning dan evidence-based practice dalam pengambilan keputusan asuhan pada komplikasi nifas.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4
CPL-4	Melakukan pengkajian terfokus–komprehensif masa nifas (anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi tanda vital) untuk deteksi dini komplikasi.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5
CPL-5	Melaksanakan tindakan awal, stabilisasi dasar, dan menentukan kebutuhan rujukan pada komplikasi nifas.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-6
CPL-6	Melaksanakan edukasi, konseling, dukungan laktasi dan kesehatan mental, dokumentasi, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.	CPMK-5, CPMK-7, CPMK-1

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan prinsip profesionalisme, etika–legal, keselamatan (PPI/K3), dokumentasi, dan penggunaan pedoman/evidence dalam asuhan komplikasi nifas.
CPMK-2	Melakukan pengkajian terfokus ibu nifas dan menafsirkan tanda vital untuk menetapkan prioritas masalah serta rencana asuhan awal.
CPMK-3	Melaksanakan penatalaksanaan awal perdarahan postpartum dengan pendekatan 4T, stabilisasi, monitoring, dan keputusan rujukan sesuai algoritme.
CPMK-4	Melaksanakan deteksi dini serta penatalaksanaan awal infeksi masa nifas dan sepsis, termasuk pencegahan penyebaran dan evaluasi respons.
CPMK-5	Melaksanakan pengkajian dan penatalaksanaan awal gangguan laktasi (bendungan ASI, puting lecet, mastitis) serta koreksi teknik menyusui dan dukungan keluarga.
CPMK-6	Melakukan triase, stabilisasi pra-rujukan, dan komunikasi rujukan efektif untuk komplikasi nifas termasuk komplikasi sistemik.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Merancang dan melaksanakan edukasi, skrining kesehatan mental, konseling KB, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.

G. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 5. Infeksi Masa Nifas: Endometritis, Infeksi Luka, dan Pencegahan Penyebaran	5.1 Membedakan endometritis dan infeksi luka berdasarkan gejala, faktor risiko, dan pemeriksaan.	5.2 Menerapkan tatalaksana awal serta pencegahan penyebaran (PPI) pada infeksi masa nifas.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-1

H. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Tes tertulis (MCQ/SAQ) + audit dokumentasi kasus	Kepatuhan item keselamatan (PPI/K3/identifikasi) pada checklist; kelengkapan dan ketepatan format dokumentasi klinis; kesesuaian keputusan dengan pedoman/evidence yang dirujuk	10	Lembar jawaban tes; lembar audit dokumentasi; daftar rujukan pedoman
CPMK-2	OSCE pengkajian + ujian kasus tertulis	Kelengkapan data kunci anamnesis–pemeriksaan fisik; akurasi interpretasi tanda vital; ketepatan penetapan prioritas masalah dan rencana awal	15	Checklist OSCE; jawaban kasus tertulis
CPMK-4	CBT berbasis kasus infeksi/sepsis + simulasi tatalaksana awal	Ketepatan identifikasi infeksi/sepsis dan red flags; konsistensi penerapan PPI; kesesuaian tatalaksana awal dan evaluasi respons	15	Skor CBT; checklist simulasi; catatan evaluasi

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Kepatuhan keselamatan pasien & PPI/K3	>2 langkah kritis terlewat; praktik berisiko; tidak	Langkah dasar dilakukan namun ada 1–2	Langkah kritis terlaksana konsisten;	Proaktif mengidentifikasi risiko, melakukan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
	konsisten menggunakan APD/hand hygiene	kekeliruan/terlewat; perlu arahan	hanya kekurangan minor	mitigasi, dan mengedukasi; tanpa kekeliruan
1.2 Dokumentasi & penggunaan pedoman/evidence	Dokumentasi tidak runtut/tidak lengkap; rasional tidak jelas; rujukan tidak relevan	Dokumentasi cukup tetapi ada data kunci hilang; rasional masih lemah; rujukan terbatas	Dokumentasi lengkap dan jelas; rasional sesuai pedoman; rujukan relevan	Dokumentasi sangat lengkap untuk continuity; rasional kuat; rujukan pedoman mutakhir dan kontekstual

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Anamnesis terfokus & pemeriksaan fisik sistematis	Data tidak terarah; komponen penting banyak terlewat	Data utama terkumpul namun belum sistematis; beberapa komponen terlewat	Sistematis, lengkap, dan komunikatif; kekurangan minor	Sangat sistematis, menggali red flags, menyesuaikan prioritas, komunikasi sangat efektif
2.2 Interpretasi tanda vital & prioritisasi masalah	Salah menafsir tanda vital/red flags; prioritas tidak tepat	Menafsir sebagian benar; prioritas belum konsisten	Menafsir tepat; menetapkan prioritas masalah dan rencana awal dengan rasional	Menafsir sangat tepat (termasuk kewaspadaan dini); prioritas dan rencana monitoring jelas dan terukur

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Klasifikasi PPH & identifikasi 4T	Klasifikasi salah; penyebab tidak terpetakan	Klasifikasi cukup; 1–2 komponen 4T teridentifikasi	Klasifikasi tepat; 4T disaring lengkap; penyebab paling mungkin ditetapkan berbasis temuan	Analisis komprehensif (kemungkinan multipel); menyusun kebutuhan konfirmasi dan pemantauan lanjutan
3.2 Tindakan awal–stabilisasi & monitoring	Urutan tindakan tidak sesuai; respons lambat; monitoring	Tindakan dasar dilakukan namun urutan/monitoring belum konsisten	Tindakan awal dan stabilisasi sesuai algoritme & kewenangan;	Sangat cepat dan tepat; monitoring komprehensif; persiapan rujukan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
	tidak terdokumentasi		monitoring dan keputusan rujukan tepat	terkoordinasi dengan baik

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Identifikasi infeksi/sepsis & derajat kegawatan	Tanda bahaya tidak dikenali; penilaian derajat tidak dilakukan	Gejala umum dikenali, namun red flags/derajat belum lengkap	Tanda klinis kunci dikenali; derajat kegawatan dan diagnosis kerja tepat	Penilaian sangat tajam; memetakan risiko komplikasi dan rencana monitoring terukur
4.2 Tatalaksana awal & pencegahan penyebaran	PPI diabaikan; tatalaksana awal tidak sesuai	PPI sebagian; tatalaksana awal sebagian sesuai; monitoring terbatas	PPI konsisten; tatalaksana awal sesuai protokol/kewenangan; evaluasi respons dilakukan	Komprehensif; koordinasi kolaborasi/rujukan tepat; dokumentasi lengkap dan jelas

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Pengkajian masalah laktasi	Penilaian teknik menyusui tidak dilakukan; masalah tidak teridentifikasi	Penilaian dasar dilakukan namun belum lengkap; penyebab belum jelas	Pengkajian lengkap (ibu–bayi–teknik); penyebab utama tepat	Analisis menyeluruh termasuk faktor psikososial; prioritas masalah dan target perbaikan jelas
5.2 Koreksi teknik menyusui & konseling	Demonstrasi keliru/berisiko; konseling tidak jelas	Demonstrasi cukup tetapi masih ada kesalahan; konseling belum individual	Demonstrasi benar; konseling jelas; rencana tindak lanjut dan kriteria rujukan tepat	Coaching sangat efektif (teach-back); melibatkan keluarga; follow-up terstruktur dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Triase & stabilisasi pra-rujukan	Kegawatan tidak dikenali; stabilisasi tidak tepat/tidak dilakukan	Kegawatan dikenali sebagian; stabilisasi dasar ada namun belum lengkap	Triase tepat; stabilisasi sesuai protokol/kewenangan; monitoring berkelanjutan	Sangat cepat, antisipatif, dan terkoordinasi; menyiapkan kebutuhan transport/alat secara optimal

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.2 Komunikasi rujukan & resume	Informasi kritis hilang; komunikasi tidak runtut; resume tidak lengkap	Komunikasi cukup runtut tetapi ada data kunci terlewat; resume perlu perbaikan	SBAR lengkap; resume rujukan jelas (tindakan, respons, rencana)	Closed-loop communication; memastikan penerimaan; rencana transport & rujukan balik terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Skrining kesehatan mental & tindak lanjut	Skrining tidak dilakukan; risiko krisis tidak dinilai	Skrining dilakukan terbatas; tindak lanjut belum jelas	Menggunakan instrumen tervalidasi; menilai risiko; dukungan awal dan rujukan sesuai	Komprehensif; safety plan jelas; pelibatan keluarga kuat; follow-up terjadwal dan terdokumentasi
7.2 Edukasi tanda bahaya/KB & continuity of care	Materi edukasi tidak lengkap; tanpa rencana tindak lanjut	Materi cukup namun belum disesuaikan; tindak lanjut umum	Materi lengkap dan terstruktur; metode sesuai; rencana follow-up jelas	Edukasi sangat efektif (teach-back + media); continuity of care rinci (kunjungan/telefollow-up/rujukan balik)

Pendahuluan

Kehamilan berhubungan erat dengan angka kematian dan kesakitan, sosio ekonomi global dan Kesehatan. Periode nifas terjadi dari sejak persalinan sampai 6 minggu post partum, dan kejadian infeksi nifas umumnya terjadi sekitar 5-7% pada periode ini. Sepsis puerperium merupakan peringkat tertinggi dari 5 penyebab kehamilan yang berhubungan dengan kematian dan menyebabkan 10-15% kematian di masa nifas (Boushra et al., 2026). Proporsi Kematian: Infeksi nifas menyumbang sekitar 5% hingga 10% dari kematian ibu di Indonesia. Meskipun angka ini lebih rendah daripada perdarahan, yang mencapai 30%, infeksi nifas dianggap sebagai kematian yang seharusnya dapat dicegah. Variasi Wilayah: Kejadian lebih tinggi terjadi di daerah dengan akses layanan kesehatan yang terbatas (daerah 3T: Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), di mana persalinan di rumah oleh tenaga non-medis masih terjadi (Kemenkes RI., 2023). Pada bab ini akan membahas tentang endometritits, dan infeksi akibat luka. Infeksi nifas adalah infeksi bakteri pada traktus genitalia atau area lain sejak persalinan hingga 42 hari setelah persalinan. Infeksi ini diidentifikasi dengan demam dengan suhu minimal 38°C dua hari berturut-turut setelah 24 jam pertama

setelah persalinan. Sebagian besar infeksi pascapersalinan disebabkan oleh trauma fisiologis atau iatrogenik yang terjadi pada dinding perut dan saluran reproduksi, genital, atau saluran kemih selama persalinan atau prosedur aborsi. Trauma ini dapat mengganggu penghalang normal perut, memungkinkan bakteri untuk menyebar ke jaringan atau area yang lebih dalam di mana infeksi dapat berkembang (Boushra et al., 2026).

A. Endometritis

Peradangan yang terlokalisasi pada endometrium, lapisan dalam rahim, biasanya disebabkan oleh infeksi disebut endometritis. Penyakit radang panggul (PID) didefinisikan sebagai infeksi yang meluas ke tuba fallopi, ovarium, atau peritoneum panggul. Endometritis biasanya dibagi menjadi dua kategori: akut dan kronis. Subtipe endometritis akut yang terjadi selama kehamilan dikenal sebagai endometritis postpartum (Smfm et al., 2023). Endometritis postpartum merupakan penyebab infeksi postpartum yang paling umum. Sebagian besar kasus endometritis postpartum bersifat polimikroba, melibatkan bakteri aerob dan anaerob, dan disebabkan oleh translokasi flora vagina normal ke dalam rongga rahim selama persalinan. Endometritis 5 hingga 20 kali lebih umum terjadi pada pasien yang menjalani persalinan sesar dibandingkan persalinan normal (Ad et al., 2015).

1. Penyebab

   Endometritis terutama disebabkan oleh naiknya mikroorganisme dari saluran genital bagian bawah (yaitu, serviks dan kubah vagina) ke dalam rongga endometrium. Patogen spesifik yang lebih sering ditemukan menginfeksi endometrium bervariasi tergantung pada jenis endometritis dan terkadang sulit untuk diidentifikasi (Ravel et al., 2021). Selama kehamilan, selaput amnion melindungi rongga rahim dari infeksi, dan endometritis jarang terjadi. Saat serviks melebar dan selaput janin pecah, peluang kolonisasi rongga rahim oleh organisme dari vagina meningkat. Risiko ini semakin meningkat dengan instrumentasi dan pemasukan benda asing ke dalam rongga rahim. Bakteri juga lebih mungkin mengkolonisasi jaringan rahim yang telah mati atau rusak. Mirip dengan infeksi intraamniotik, infeksi endometrium pascapersalinan bersifat polimikroba, melibatkan bakteri aerob dan anaerob, termasuk: Coccus Gram-positif: Streptococcus Grup A dan B, Staphylococcus, Enterococcus. Basil Gram-negatif: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus. Organisme anaerob: Bacteroides, Peptostreptococcus, Peptococcus, Prevotella, dan Clostridium. Lainnya: Mycoplasma, Neisseria gonorrhoeae (Fm & Rm, 2014).

2. Faktor risiko

Berbagai faktor risiko yang terkait dengan endometritis pascapersalinan termasuk persalinan sesar, infeksi intraamniotik intrapartum (juga disebut korioamnionitis), pecah ketuban yang berkepanjangan atau persalinan yang lama, pemasukan benda asing ke dalam rahim (seperti alat pemantauan invasif rahim dan janin), ekstraksi plasenta secara manual, persalinan pervaginam operatif, dan kondisi ibu tertentu seperti infeksi HIV, diabetes melitus, dan penyakit jantung. Untuk mengidentifikasi dan menangani endometritis pascapersalinan, sangat penting untuk mengetahui faktor risiko ini karena mereka dapat berkontribusi pada perkembangan kondisi ini dan memandu tindakan pencegahan dan pengobatan (Taylor et al., 2026).

3. Patofisiologi

Pada endometritis pascapersalinan, pecahnya selaput amnion memungkinkan flora bakteri dari vagina dan serviks masuk ke endometrium. Bakteri ini lebih cenderung mengkolonisasi jaringan rahim yang rusak, pendarahan, atau kerusakan lainnya (seperti yang terjadi selama persalinan sesar). Selain itu, bakteri ini dapat menyerang miometrium, menyebabkan kerusakan dan infeksi (Ad et al., 2015), Demam setelah persalinan atau keguguran baru-baru ini adalah tanda utama endometritis postpartum. Penyakit awal muncul dalam 48 jam setelah persalinan, dan penyakit lanjut muncul hingga 6 minggu setelah persalinan. Nyeri tekan rahim, nyeri perut bagian bawah yang signifikan, dan lokia purulen berbau busuk adalah gejala yang mendukung diagnosis ini. Juga dapat mengalami gejala umum seperti rasa tidak enak badan, sakit kepala, dan menggigil (Beigi et al., 2017).

4. Tanda dan gejala

Temuan klinis endometritis postpartum meliputi nyeri suprapubik dan uterus yang menonjol, pembesaran ukuran uterus postpartum, dan kelainan tanda vital tambahan seperti demam dan takikardia. Mempertahankan tingkat kecurigaan yang tinggi terhadap sepsis maternal juga penting. Selain demam dan takikardia, tanda-tandanya dapat meliputi hipotensi, hipotermia, perubahan status mental, dan disfungsi organ akhir yang tidak dapat dijelaskan. Endometritis yang disebabkan oleh streptokokus Grup A atau spesies Clostridium seringkali sangat parah dan dapat dengan cepat berkembang menjadi sindrom syok toksik dan fasciitis nekrotikans (Gonzalo-carballes et al., n.d.).

5. Pemeriksaan penunjang

USG panggul biasanya direkomendasikan sebagai modalitas pertama. Kecuali diagnosis alternatif seperti retensi produk konsepsi atau tromboflebitis panggul septic. Setiap USG endometritis postpartum harus dikorelasikan dengan

riwayat klinis karena hasilnya biasanya tidak spesifik dan tumpang tindih dengan tanda-tanda postpartum normal, seperti gas di rongga endometrium dan pembesaran uterus. Jika ada kondisi yang dicurigai, seperti abses panggul atau tromboflebitis panggul septik, CT scan panggul juga dapat dipertimbangkan.

6. Penatalaksanaan

Sebagian besar pasien memerlukan pengobatan dengan antibiotik intravena; ini termasuk pasien dengan penyakit sedang hingga berat, yang mengalami risiko sepsis atau endometritis setelah persalinan sesar. Di antara rejimen antibiotik untuk endometritis pascapersalinan, tinjauan Cochrane menemukan bahwa kombinasi klindamisin dan gentamisin adalah yang paling efektif:. Jika Streptococcus grup B positif atau tanda dan gejala tidak membaik dalam 48 jam, tambahkan salah satu dari ini: Ampisilin 2 g intravena setiap 6 jam atau dosis awal 2 g intravena, diikuti dengan 1 g setiap 4 hingga 8 jam; atau klindamisin 900 mg intravena setiap 8 jam. Penyedia layanan kesehatan harus memperluas diagnosis banding mereka untuk mempertimbangkan infeksi lain seperti pneumonia, pielonefritis, dan tromboflebitis septik panggul jika pasien tidak membaik dalam 72 jam. Pasien harus terus mendapatkan antibiotik intravena sampai dia tidak lagi demam selama setidaknya satu hari, bersamaan dengan perbaikan dalam pengurangan nyeri dan resolusi leukositosis. Setelah perbaikan klinis, penggunaan antibiotik oral tidak menunjukkan peningkatan signifikan dalam hasil yang berorientasi pada pasien. Pasien dengan gejala ringan setelah keluar dari rumah sakit, seperti endometritis pascapersalinan onset lambat, dapat mempertimbangkan untuk menerima antibiotik oral dengan hati-hati (Shields & Assis, 2021).

B. Infeksi Luka

1. Pengertian

Infeksi Luka Operasi (ILO) pada Sectio Caesarea (SC) adalah infeksi yang terjadi pada sayatan operasi dan biasanya muncul 30 hari setelah operasi. Keluhan seperti nyeri, kemerahan, bengkak, panas, dan keluarnya nanah. Usia, obesitas, diabetes, dan ketidakpatuhan perawat dan pasien terhadap prosedur sterilitas adalah faktor risiko utama. *The Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) mengklasifikasikan infeksi luka operasi ke dalam beberapa kategori, seperti infeksi superfisial, infeksi sayatan dalam, atau infeksi organ/ruang. Setiap luka operasi yang dinyatakan terinfeksi atau dibuka oleh ahli bedah dikategorikan sebagai infeksi luka operasi. Infeksi ini harus terjadi dalam waktu 30 hari setelah

operasi atau dalam waktu 1 tahun setelah implantasi untuk memenuhi kriteria klasifikasi (Sharman, 2026).

2. Penyebab

   Penyebab infeksi luka pascaoperasi beragam, mulai dari kontak langsung atau penularan melalui udara hingga kontaminasi dengan mikroba endogen, dengan kerentanan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pola infeksi dapat bervariasi berdasarkan prosedur bedah, pendekatan operatif, dan lokasi geografis. Faktor risiko dapat dikategorikan menjadi faktor pasien dan faktor prosedural.

3. Faktor risiko

   Faktor risiko pasien untuk infeksi luka meliputi, tetapi tidak terbatas pada, usia lanjut, malnutrisi, hipovolemia, obesitas, penggunaan steroid, diabetes yang tidak terkontrol dengan baik, kondisi imunosupresi, merokok, trauma, lokasi prosedur (intraabdominal, panggul, atau ekstremitas), rawat inap praoperasi yang lama, kebersihan kulit praoperasi yang tidak memadai, dan infeksi yang sudah ada di lokasi yang jauh.

4. Klasifikasi

   Klasifikasi, menurut The Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) 2011, didefinisikan sebagai berikut:

   a. Bersih: Prosedur yang ditandai dengan tidak adanya peradangan dan terjaga sterilitasnya. Saluran pencernaan, urogenital, dan paru-paru tidak diakses.
   b. Bersih-terkontaminasi: Prosedur yang melibatkan masuk ke saluran pencernaan, urogenital, atau paru-paru secara terkontrol, tanpa adanya kontaminasi.
   c. Terkontaminasi: Prosedur di mana terjadi pelanggaran teknik steril dan/atau terdapat tumpahan besar dari saluran pencernaan, atau sayatan melalui jaringan yang meradang akut (tidak bernanah). Kategori ini juga mencakup luka traumatis terbuka yang berusia 12 hingga 24 jam.
   d. Kotor atau terinfeksi: Prosedur yang dilakukan pada organ dalam yang berlubang atau sayatan melalui jaringan yang meradang akut dan bernanah. Luka traumatis terbuka yang berusia lebih dari 24 jam dengan jaringan nekrotik atau kontaminasi feses juga termasuk dalam kategori ini.

5. Patofisiologi

   Peristiwa pemicu terjadinya infeksi luka operasi biasanya dimulai dengan kontaminasi mikroba pada luka. Faktor-faktor seperti virulensi dan jumlah organisme yang mengkontaminasi berkontribusi terhadap infeksi, yang sering didefinisikan sebagai melebihi 10^5 mikroorganisme per gram jaringan tanpa adanya benda asing. Agen etiologi infeksi luka operasi dapat berupa endogen

atau eksogen. Mikroba endogen berasal dari kulit pasien, selaput lendir, atau organ berongga di dekatnya, atau dapat masuk melalui penyebaran hematogen. Organisme penyebab endogen yang paling umum dari infeksi luka operasi bervariasi tergantung pada lokasi anatomi prosedur. Misalnya, setelah operasi jantung, payudara, mata, ortopedi, dan vaskular, Staphylococcus aureus dan stafilokokus koagulase-negatif seringkali terlibat. Sebaliknya, setelah prosedur abdominopelvik, Enterococcus, basil gram-negatif, dan anaerob lebih sering ditemukan sebagai agen etiologi (Sharman, 2026)

Mikroba eksogen dapat berasal dari ruang operasi atau individu yang tinggal di sana. Mereka juga dapat menyebar melalui udara, instrumen, atau bahan, atau bahkan dari karyawan rumah sakit. Stafilokokus dan streptokokus adalah organisme eksogen yang paling umum ditemukan pada infeksi lokasi operasi. Namun, mikroba rumah sakit seperti Staphylococcus aureus resisten metisilin (MRSA) atau mikroba beta-laktamase spektrum luas yang diisolasi dari infeksi di lokasi operasi menjadi lebih umum. Tren ini mungkin disebabkan oleh penggunaan antibiotik spektrum luas yang meluas dan terkadang tidak tepat (Owens & Stoessel, 2008)

6. Pencegahan dan Penatalaksanaan

Faktor-faktor seperti prosedur khusus yang dilakukan, jenis mikroba yang terlibat, pertimbangan anatomi, dan karakteristik pasien memengaruhi keputusan pengobatan. Dalam kasus di mana benda asing seperti mesh, stent, implan, atau logam terlibat, pengangkatan mungkin diperlukan karena kontaminasi dan pembentukan biofilm Kultur disarankan untuk luka terbuka dan drainase, terutama jika bernanah, karena hasilnya akan mempengaruhi pemilihan antibiotik. Kultur luka negatif dapat menunjukkan infeksi bakteri tahan asam atau jamur yang tidak biasa, terutama pada orang yang memiliki sistem kekebalan yang lemah. Dalam situasi seperti itu, kultur khusus organisme ini harus diperoleh.

Praoperasi

Persiapan pasien

a. Jika memungkinkan, identifikasi dan obati infeksi jarak jauh, dan tunda operasi sampai infeksi tersebut sembuh (1A)
b. Jangan mencabut rambut di sekitar lokasi operasi, kecuali jika akan mengganggu operasi (1A)
c. Jika rambut dicabut, ini harus dilakukan segera sebelum operasi, sebaiknya dengan gunting rambut (1A)
d. Kendalikan kadar glukosa darah secara memadai pada pasien diabetes, dan hindari hiperglikemia perioperatif (1B)
e. Dorong penghentian penggunaan tembakau (1B)

f. Jangan menahan produk darah yang diperlukan sebagai cara untuk mencegah infeksi luka operasi (1B)
g. Wajibkan pasien untuk mandi atau berendam dengan agen antiseptik setidaknya pada malam sebelum operasi (1B)
h. Cuci dan bersihkan secara menyeluruh di sekitar lokasi sayatan untuk menghilangkan kontaminasi kasar sebelum melakukan persiapan kulit antiseptik (1B)
i. Gunakan antiseptik yang sesuai untuk persiapan kulit (1B)

Antiseptik tangan/lengan bawah untuk anggota tim bedah :

a. Jaga agar kuku tetap pendek dan jangan memakai kuku palsu (1B)
b. Lakukan pencucian tangan praoperasi setidaknya selama 2,5 menit menggunakan antiseptik yang sesuai. Cuci tangan dan lengan bawah hingga siku (1B)
c. Setelah melakukan pencucian tangan, angkat tangan dan jauhkan dari tubuh (siku ditekuk). Keringkan tangan dengan handuk steril dan kenakan gaun dan sarung tangan steril (1B)

Manajemen Personel Bedah yang Terinfeksi atau Terkolonisasi

a. Mendidik dan mendorong personel bedah yang memiliki tanda dan gejala penyakit menular untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada supervisor dan layanan kesehatan kerja mereka (1B)
b. Mengembangkan kebijakan yang jelas mengenai tanggung jawab perawatan pasien ketika personel memiliki kondisi infeksi yang berpotensi menular (1B)
c. Memperoleh kultur yang sesuai dari, dan mengecualikan dari tugas, personel bedah dengan lesi kulit yang mengeluarkan cairan sampai infeksi telah disingkirkan atau diselesaikan (1B)
d. Jangan secara rutin mengecualikan personel yang terkolonisasi dengan organisme seperti S. aureus atau streptokokus Grup A kecuali personel tersebut telah dikaitkan secara epidemiologis dengan penyebaran organisme di lingkungan perawatan kesehatan (1B)

Profilaksis Antimikroba

a. Berikan profilaksis antimikroba hanya bila diindikasikan dan pilih agen sesuai dengan kemanjuran terhadap patogen yang paling umum yang terkait dengan prosedur tertentu (1A)
b. Berikan dosis awal secara intravena, diatur waktunya sehingga konsentrasi bakterisida terbentuk dalam serum dan jaringan ketika sayatan dibuat. Pertahankan konsentrasi terapeutik dalam serum dan jaringan sepanjang prosedur hingga paling lama beberapa jam setelah penutupan luka di ruang operasi (1A)

c. Sebelum operasi kolorektal elektif, siapkan usus besar secara mekanis dengan menggunakan enema dan agen pencahar.
d. Berikan agen antimikroba oral yang tidak dapat diserap dalam dosis terbagi pada hari sebelum operasi (1A)
e. Untuk operasi caesar berisiko tinggi, berikan profilaksis segera setelah tali pusar dijepit (1A)
f. Jangan menggunakan vankomisin secara rutin untuk profilaksis antimikroba (1B)

Ventilasi Intraoperatif

a. Pertahankan tekanan positif di ruang operasi sehubungan dengan koridor dan area yang berdekatan (1B)
b. Pertahankan setidaknya 15 pergantian udara per jam, di mana tiga di antaranya harus udara segar (1B)
c. Saring semua udara, yang disirkulasikan kembali dan udara segar, melalui filter yang sesuai (1B)
d. Masukkan semua udara di langit-langit, dan buang di dekat lantai (1B)
e. Jangan gunakan radiasi UV di ruang operasi untuk mencegah infeksi luka operasi (1B)
f. Jaga agar pintu ruang operasi tetap tertutup kecuali jika diperlukan untuk lewatnya peralatan, personel, dan pasien (1B)

Pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan

a. Jika terjadi pengotoran atau kontaminasi yang terlihat dengan darah atau cairan tubuh lainnya pada permukaan atau peralatan selama operasi, bersihkan area yang terkena dampak dengan disinfektan sebelum operasi berikutnya (1B)
b. Jangan melakukan pembersihan khusus atau penutupan ruang operasi setelah operasi yang terkontaminasi atau kotor (1B)
c. Jangan gunakan keset lengket di pintu masuk ruang operasi untuk mencegah infeksi kontrol (1B)

Pengambilan sampel mikrobiologis

a. Jangan melakukan pengambilan sampel lingkungan rutin di ruang operasi. Lakukan pengambilan sampel mikrobiologis pada permukaan lingkungan ruang operasi atau udara hanya sebagai bagian dari investigasi epidemiologis (1B)

Sterilisasi instrumen bedah

a. Sterilkan semua instrumen bedah sesuai dengan pedoman yang diterbitkan (1B)
b. Lakukan sterilisasi kilat hanya untuk instrumen perawatan pasien yang akan segera digunakan (misalnya, untuk memproses ulang instrumen yang terjatuh).

Jangan menggunakan sterilisasi kilat karena alasan kenyamanan, sebagai alternatif untuk membeli set instrumen tambahan, atau untuk menghemat waktu (1B)

c. Pakaian dan kain penutup bedah
d. Kenakan masker bedah yang sepenuhnya menutupi mulut dan hidung saat memasuki ruang operasi jika operasi akan segera dimulai atau sudah berlangsung, atau jika instrumen steril terpapar. Kenakan masker selama operasi (1B)
e. Kenakan topi atau penutup kepala untuk menutupi sepenuhnya rambut di kepala dan wajah saat memasuki ruang operasi (1B)
f. Jangan mengenakan penutup sepatu untuk mencegah infeksi luka operasi (1B)
g. Kenakan sarung tangan steril jika Anda anggota tim bedah. Kenakan sarung tangan setelah mengenakan gaun bedah (1B)
h. Gunakan gaun bedah dan kain penutup yang merupakan penghalang efektif saat basah (yaitu bahan yang tahan terhadap penetrasi cairan) (1B)
i. Ganti pakaian bedah yang terlihat kotor, terkontaminasi, dan/atau ditembus oleh darah atau bahan lain yang berpotensi menular (1B)

Asepsis dan teknik bedah

a. Patuhi prinsip-prinsip asepsis saat memasang alat intravaskular atau saat memberikan obat intravena (1A)
b. Tangani jaringan dengan lembut, pertahankan hemostasis yang efektif, minimalkan jaringan yang mati dan benda asing (misalnya jahitan, jaringan hangus, puing nekrotik), dan hilangkan ruang mati di lokasi operasi (1B)
c. Gunakan penutupan kulit primer tertunda atau biarkan sayatan terbuka untuk sembuh dengan penyembuhan sekunder jika lokasi operasi dianggap sangat terkontaminasi (1B)
d. Jika drainase diperlukan, gunakan drainase hisap tertutup. Pasang drainase melalui sayatan terpisah yang jauh dari sayatan operasi. Lepaskan drainase sesegera mungkin (1B)

Perawatan luka sayatan pasca operasi

a. Lindungi luka sayatan yang telah ditutup secara primer dengan perban steril selama 24-48 jam pasca operasi (1B)
b. Cuci tangan sebelum dan sesudah mengganti perban dan kontak apa pun dengan lokasi operasi (1B)

Pengawasan

a. Gunakan definisi SSI CDC tanpa modifikasi untuk mengidentifikasi SSI di antara pasien rawat inap dan rawat jalan bedah (1B)

b. Untuk penemuan kasus pasien rawat inap (termasuk penerimaan kembali), gunakan observasi prospektif langsung, deteksi prospektif tidak langsung, atau kombinasi metode langsung dan tidak langsung selama masa rawat inap (1B)
c. Untuk penemuan kasus pasien rawat jalan, gunakan metode yang mengakomodasi sumber daya dan kebutuhan data yang tersedia (1B)
d. Untuk setiap pasien yang menjalani operasi yang dipilih untuk pengawasan, catat variabel-variabel yang terbukti berhubungan dengan peningkatan risiko SSI (misalnya, kelas luka bedah, durasi operasi, dll.) (1B)
e. Hitung secara berkala tingkat SSI spesifik operasi yang dikelompokkan berdasarkan variabel yang terbukti berhubungan dengan peningkatan SSI risiko (misalnya indeks risiko NNIS) (1B)
f. Laporkan tingkat SSI yang terstratifikasi secara tepat dan spesifik operasi kepada anggota tim bedah. Frekuensi dan format optimal untuk perbandingan tingkat SSI akan ditentukan oleh tingkat beban kasus yang terstratifikasi dan tujuan inisiatif peningkatan kualitas berkelanjutan lokal (1B)

Catatan : rekomendasi kategori 1 adalah 'sangat direkomendasikan untuk diimplementasikan', dan didukung oleh studi klinis atau epidemiologis yang dirancang dengan baik; rekomendasi kategori 1A dan 1B hanya berbeda dalam kekuatan bukti pendukungnya.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Seorang ibu P2A0, hari ke-3 postpartum spontan, mengeluh demam 38,5°C, nyeri perut bawah, dan lochia berbau. Pada pemeriksaan uterus nyeri tekan, TFU sepusat, lokia rubra.

Tugas Mahasiswa:

1. Identifikasi kemungkinan diagnosis
2. Tentukan faktor risiko yang mungkin
3. Sebutkan tanda bahaya (red flags)
4. Rencanakan penatalaksanaan awal

Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab perawatan luka post SC

Skenario Kasus : seorang Perempuan, umur 28 tahun, P1A0, Post-SC hari ke-3, datang ke RS dengan keluhan nyeri pada luka bekas operasi SC. Hasil anamnesis: demam, meriang. Hasil pemeriksaan: TD 110/70 mmHg, N 100 x/menit, P 20x/menit, S 38,7 C, tampak kasa penutup luka basah, berbau, TFU 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus keras,

Tugas:

1. Lakukan pengkajian luka (REEDA Scale)
2. Lakukan pembersihan luka,
3. Tentukan apakah terjadi infeksi.

Instrumen & Alat (Checklist Persiapan)

Kategori	Alat yang Dibutuhkan
Set Ganti Balutan	Pinset sirurgis & anatomis, gunting jaringan, kom kecil, kasa steril.
Cairan & Obat	NaCl 0,9%, antiseptik (sesuai SOP), salep antibiotik (jika ada resep).
APD	Handscoon steril, masker, apron.
Lain-lain	Manekin abdomen post-SC, penggaris luka, lembar dokumentasi/REEDA score card.

Langkah-Langkah Aktivitas (SOP)

1. Pra-Interaksi: Mencuci tangan 6 langkah dan menggunakan APD.
2. Tahap Orientasi: Menjelaskan prosedur kepada "pasien" (manekin/simulan) untuk menurunkan kecemasan.
3. Tahap Kerja (Core Skill):

a. Membuka Balutan: Membasahi plester dengan alkohol/wash bensin agar tidak nyeri, buang balutan lama ke kantong kuning (infeksius). Inspeksi (Deteksi ILO): Mengamati luka menggunakan skala REEDA (Redness, Edema, Ecchymosis, Discharge, Approximation). Palpasi: Menekan area sekitar luka untuk mengecek adanya pus (nanah) atau nyeri tekan berlebih. Cleansing: Membersihkan luka dengan teknik sirkuler atau dari area bersih ke kotor menggunakan NaCl 0,9%.
b. Tindakan Lanjutan: Jika ada pus, lakukan debridement ringan atau pengambilan sampel swab.

4. Penutupan: Menutup kembali dengan modern dressing atau kasa steril sesuai kondisi luka.
5. Terminasi: Merapikan pasien dan mencatat hasil observasi pada lembar integrasi.

Aktifitas 4 - Portofolio

PORTOFOLIO KLINIK
Kasus Infeksi Luka Operasi SC

Identitas Mahasiswa
Nama : .....
NIM : .....
Lahan Praktik: .....
Pembimbing : .....

I. Bukti yang Dikumpulkan
- OSCE : Nilai .....
- DOPS : (Kompeten / Supervisi / Remedial)

II. Catatan Kasus
Pasien: Ny. A, 28 tahun, hari ke-5 post SC
Keluhan: Luka nyeri, keluar cairan
Diagnosa: Infeksi luka operasi SC
Tindakan: Perawatan luka, antibiotik, edukasi
Evaluasi: Luka membaik

III. Refleksi Patient Safety
Apa yang sudah baik: .....
Risiko yang ditemukan: .....
Perbaikan: .....
Pembelajaran: .....

IV. Feedback Pembimbing
Kelebihan: .....
Perlu perbaikan: .....
Saran: .....

Kesimpulan:
Perkembangan kompetensi: .....

Referensi

Ad, M., Re, P., Ota, E., Speer, L., Ad, M., Re, P., Ota, E., & Speer, L. (2015). *Antibiotic regimens for postpartum endometritis (Review)*. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001067.pub3.www.cochranelibrary.com

Beigi, R., Silverman, N. S., & El-sayed, Y. Y. (2017). *Intrapartum Management of Intraamniotic Infection*. *130*(712), 95–101.

Boushra, M., Carlson, K., Rahman, O., & Medicine, N. (2026). *Postpartum Infection*. 1–12.

Fm, S., & Rm, G. (2014). *Antibiotic prophylaxis versus no prophylaxis for preventing infection a er cesarean section (Review)*. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007482.pub3.www.cochranelibrary.com

Gonzalo-carballes, M., Ríos-vives, M. Á., Fierro, E. C., Azogue, X. G., Herrero, S. G., Rodríguez, A. E., Rus, M. N., Planes-conangla, M., & Escudero-fernandez, J. M. (n.d.). *WOMEN ' S IMAGING A Pictorial Review of Postpartum Complications*. *1*.

Kemenkes RI. (2023). *Survey Kesehatan Indonesia*.

Owens, C. D., & Stoessel, K. (2008). Surgical site infections : epidemiology , microbiology and prevention. *The Journal of Hospital Infection*, *70*, 3–10. https://doi.org/10.1016/S0195-6701(08)60017-1

Ravel, J., Moreno, I., & Simón, C. (2021). Expert Reviews Bacterial vaginosis and its association with infertility , endometritis , and pelvic. *The American Journal of Obstetrics & Gynecology*, *224*(3), 251–257. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.10.019

Sharman, M. Z. S. W. L. T. (2026). *Postoperative Wound Infections*. *Cdc*, 1–16.

Shields, A., & Assis, V. De. (2021). *Top 10 Pearls for the Recognition , Evaluation , and Management of Maternal Sepsis*. *138*(2), 289–304. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000004471

Smfm, M. M., Shields, A. D., Plante, L. A., & Pacheco, L. D. (2023). Society for Maternal-Fetal Medicine Consult Series # 67 : Maternal sepsis. *The American Journal of Obstetrics & Gynecology*, *229*(3), B2–B19. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2023.05.019

Taylor, M., Jenkins, S. M., Pillarisetty, L. S., & Heights, W. (2026). *Endometritis*. 1–12.

Profil Penulis



Marleni, S.ST., Bdn., M.Tr. Keb

merupakan dosen Program Studi Sarjana Kebidanan, Institut Citra Internasional. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma III Kebidanan di Akbid Indragiri Rengat, pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik di Universitas Respati Yogyakarta, dan Pendidikan Magister Kebidanan di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta. Saat ini aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang keahlian penulis adalah Asuhan Kebidanan Nifas, yang mencakup pelayanan kebidanan pada ibu nifas, laktasi, adaptasi fisiologis dan psikologis masa nifas, deteksi dini komplikasi, serta pelayanan kebidanan berbasis evidence-based practice. Selain mengajar, penulis juga aktif membimbing mahasiswa, mengembangkan bahan ajar, serta terlibat dalam pengembangan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) di lingkungan Institut Citra Internasional. Penulis aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah di bidang kebidanan, khususnya kesehatan ibu dan anak.

Motto : Mengabdi dengan ilmu, mendidik dengan hati, dan memberikan pelayanan terbaik bagi kesehatan ibu dan bayi

Profil Penulis



Bdn. Fitriana Yuni Permana Sari, S.Tr.Keb., M.Keb

Saya merupakan seorang bidan, dosen, dan praktisi kesehatan dengan latar belakang pendidikan Profesi Bidan serta Magister Kebidanan dari Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Saat ini saya mengemban tugas sebagai dosen pada Program Studi Sarjana Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Bidang kepakaran saya berfokus pada Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui dengan pendekatan holistik yang menekankan aspek biofisik, psikologis, sosial, dan spiritual dalam pemberian pelayanan kebidanan. Dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, saya berkomitmen untuk mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan kualitas kesehatan ibu dan bayi.

Sebagai dosen, saya mengampu berbagai mata kuliah inti di bidang kebidanan, antara lain Konsep Dasar Praktik Kebidanan (KDPK), Keterampilan Klinis Praktik Kebidanan (KKPK), Pemeriksaan Dasar Kebidanan, Dokumentasi Kebidanan, Komunikasi Kebidanan, Fundamental Kebidanan, serta Manajemen Pelayanan Kebidanan. Melalui proses pembelajaran, saya berupaya mengembangkan kompetensi mahasiswa agar mampu memberikan pelayanan kebidanan yang profesional, berbasis bukti (evidence-based), serta berorientasi pada keselamatan dan kebutuhan perempuan.

Aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan berfokus pada isu-isu kesehatan ibu, khususnya asuhan masa nifas, praktik kebidanan holistik, kesehatan mental ibu, serta upaya promotif dan preventif dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi. Selain berkiprah di bidang akademik, saya juga aktif sebagai praktisi kesehatan dengan sertifikasi Mom and Baby Spa, Certified Mental Health First Aid (CMHFA), dan Emotional Freedom Techniques (EFT). Kompetensi tersebut mendukung penerapan pelayanan kebidanan yang komprehensif, dengan memadukan intervensi berbasis ilmiah dan pendekatan holistik untuk meningkatkan kesehatan fisik maupun psikologis ibu dipublikasikan.

“Merawat ibu secara utuh, membangun generasi yang lebih sehat”

Profil Penulis



Bd. Teresia Hemelka, S.Tr.Keb., M.Keb

Lahir di Natai Panjang, 26 Juli 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III (D-III) di Akademi Kebidanan St.Benedicta Pontianak tahun 2014, Penulis melanjutkan Diploma IV (D-4) pada Program Studi Bidan Pendidik, Universitas Nasional tahun 2016, Penulis melanjutkan Pendidikan Profesi bidan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati dan lulus tahun 2023. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2025. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014 setelah lulus dari D III Kebidanan bekerja di salah satu praktik Mandiri dokter. Saat ini ini penulis bekerja di Pemerintah Desa Sungai Raya Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi dan turut berkontribusi dalam mendukung program pembangunan desa terutama pada bidang kesehatan masyarakat, pembinaan kader posyandu, serta penguatan peran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak. Penulis juga aktif mengikuti berbagai seminar, workshop, dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi serta memperluas wawasan dalam bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: teresiahemelka@yahoo.com

Motto: "Berani bermimpi, tekun berusaha, dan berserah kepada Tuhan"



Bdn. Helena Fransysca, SST, M.Kes

Merupakan lulusan D-IV Kebidanan dari Program Studi Diploma IV Bidan Pendidik Universitas Sumatera Utara pada tahun 2011. Ia kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang Magister Kesehatan Masyarakat (S2) di Universita Sumatera Utara dan berhasil menyelesaikannya pada Bulan Agustus 2016. Sejak tahun 2017, Helena mulai aktif mengajar sebagai dosen kebidanan. Pada tahun 2024, ia bergabung sebagai dosen kebidanan di Universitas Murni Teguh. Selain mengajar, ia juga aktif menulis dan menerbitkan berbagai buku serta berkontribusi dalam publikasi jurnal nasional. Ia dapat dihubungi melalui email: helenpardosy@gmail.com.

Motto:

Dari ilmu menuju praktik, dari kompetensi menuju pelayanan yang bermutu.

Profil Penulis



Bdn. Leni Suhartini, S.ST,M.Kes

Lahir di Bandung, 21 April 1980. Menyelesaikan Pendidikan D1 Kebidanan tahun 1999 dari PPB Muhammadiyah Cirebon, D3 Kebidanan lulus tahun 2003 dari Poltekes Kemenkes Bandung, D4 Kebidanan lulus tahun 2007 dari Poltekes Kemenkes Jakarta III, S2 Kesehatan Reproduksi lulus tahun 2015 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM), Profesi lulus tahun 2025 dari STIKes RSPAD Gatot Soebroto. Mengawali karier bidan pada tahun 2000 di TPMB, kemudian 2004-2007 sebagai asisten dosen di Akbid RSPAD Gatot Soebroto, tahun 2007-2011 sebagai bidan pelaksana di Kamar Bersalin RSPAD Gatot Soebroto, tahun 2011-2016 sebagai bidan pelaksana di ruang perawatan ginekologi dan onkologi RSPAD Gatot Soebroto, tahun 2017-2020 sebagai Wakil Direktur 1 Bidang Kurikulum dan Akademik Akbid RSPAD Gatot Soebroto, Tahun 2020-2022 sebagai Kepala Program Studi D3 Kebidanan STIKes RSPAD Gatot Soebroto,tahun 2022- 2025 sebagai Kepala Ruangan ruang nifas RSPAD Gatot Soebroto, 2025-saat ini sebagai Karu ruang perawatan ginekologi onkologi dan Dosen Tetap Prodi Pendidikan Profesi Bidan STIKes RSPAD Gatot Soebroto. Saya juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengabdian masyarakat, dan narasumber seminar. Dengan bekal pengalaman saya di pelayanan dan di pendidikan, sebagai pemimpin dan manajer saya berusaha berbagi tentang Manajemen dan Kepemimpinan dalam buku ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sejawat bidan, dan sebagai gambaran penerapan pemimpin dan manajemen bagi mahasiswi kebidanan**.** Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lenibestari@gmail.com

Motto: “Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak berhenti mengajar”

Sinopsis

Buku Ajar *Komplikasi Nifas: Perdarahan, Infeksi, Gangguan Laktasi, dan Kesehatan Mental Ibu* disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, keperawatan, dan tenaga kesehatan dalam memahami berbagai komplikasi yang dapat terjadi pada masa nifas. Masa nifas merupakan periode penting yang membutuhkan pemantauan komprehensif karena perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang dialami ibu dapat berkembang menjadi kondisi berisiko apabila tidak dikenali dan ditangani secara tepat.

Buku ini membahas konsep dasar komplikasi masa nifas, meliputi fisiologi nifas, faktor risiko, serta prinsip keselamatan ibu sebagai dasar dalam pemberian asuhan. Pembahasan dilanjutkan dengan perdarahan postpartum yang mencakup klasifikasi, penyebab berdasarkan konsep 4T, serta tindakan awal yang dapat dilakukan di pelayanan primer. Materi ini penting untuk membekali pembaca dalam mengenali tanda bahaya secara cepat dan menentukan langkah penanganan awal yang sesuai.

Selain itu, buku ini menguraikan retensio plasenta dan sisa plasenta, termasuk tanda klinis, penanganan awal, serta indikasi rujukan. Bab berikutnya membahas laserasi jalan lahir dan hematoma, mulai dari identifikasi, penatalaksanaan awal, hingga pengambilan keputusan rujukan yang aman. Pembahasan mengenai infeksi masa nifas juga disajikan secara sistematis, meliputi endometritis, infeksi luka, serta upaya pencegahan penyebaran infeksi dalam pelayanan kesehatan.

Buku ini juga memuat pembahasan mengenai gangguan eliminasi dan komplikasi lain pada masa nifas, seperti retensi urine, konstipasi, dan hemoroid. Materi disusun dengan pendekatan aplikatif agar pembaca tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan situasi nyata dalam praktik pelayanan kesehatan ibu.

Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang membantu mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan kemampuan identifikasi dini, penatalaksanaan awal, edukasi, serta rujukan pada kasus komplikasi masa nifas. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan pelayanan kesehatan ibu pada masa nifas dapat diberikan secara aman, tepat, profesional, dan berorientasi pada keselamatan ibu.

Buku Ajar Komplikasi Nifas: Perdarahan, Infeksi, Gangguan Laktasi, dan Kesehatan Mental Ibu disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, keperawatan, dan tenaga kesehatan dalam memahami berbagai komplikasi yang dapat terjadi pada masa nifas. Masa nifas merupakan periode penting yang membutuhkan pemantauan komprehensif karena perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang dialami ibu dapat berkembang menjadi kondisi berisiko apabila tidak dikenali dan ditangani secara tepat.

Buku ini membahas konsep dasar komplikasi masa nifas, meliputi fisiologi nifas, faktor risiko, serta prinsip keselamatan ibu sebagai dasar dalam pemberian asuhan. Pembahasan dilanjutkan dengan perdarahan postpartum yang mencakup klasifikasi, penyebab berdasarkan konsep 4T, serta tindakan awal yang dapat dilakukan di pelayanan primer. Materi ini penting untuk membekali pembaca dalam mengenali tanda bahaya secara cepat dan menentukan langkah penanganan awal yang sesuai. Selain itu, buku ini menguraikan retensio plasenta dan sisa plasenta, termasuk tanda klinis, penanganan awal, serta indikasi rujukan. Bab berikutnya membahas laserasi jalan lahir dan hematoma, mulai dari identifikasi, penatalaksanaan awal, hingga pengambilan keputusan rujukan yang aman. Pembahasan mengenai infeksi masa nifas juga disajikan secara sistematis, meliputi endometritis, infeksi luka, serta upaya pencegahan penyebaran infeksi dalam pelayanan kesehatan.

Buku ini juga memuat pembahasan mengenai gangguan eliminasi dan komplikasi lain pada masa nifas, seperti retensi urine, konstipasi, dan hemoroid. Materi disusun dengan pendekatan aplikatif agar pembaca tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan situasi nyata dalam praktik pelayanan kesehatan ibu.

Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang membantu mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan kemampuan identifikasi dini, penatalaksanaan awal, edukasi, serta rujukan pada kasus komplikasi masa nifas. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan pelayanan kesehatan ibu pada masa nifas dapat diberikan secara aman, tepat, profesional, dan berorientasi pada keselamatan ibu.



Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-77-0 (PDF)
9 786347 756770